

Buku Referensi
**EDUKASI KESEHATAN
REPRODUKSI
PADA IBU HAMIL**

Surmiasih • Yaumil Fauziah • Sestu Retno Dwi Andayani
Israini Suriati • Rina Utami • Sri Wahyuni

Editor: Emy Yulianti



BUKU REFERENSI EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI PADA IBU HAMIL

Dr. Surmiasih, S,Kep., Ners., M.Kes
Bdn. Yaumil Fauziah, S.Tr.Keb., M.Keb.
Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes
Bdn. Israini Suriati, S.ST.,M.Keb.,CBMHCT.
Rina Utami, M.Tr.Keb.
Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat

Editor: Emy Yulianti, M.Kes.



BUKU REFERENSI
EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI PADA IBU HAMIL

Penulis: Dr. Surmiasih, S.Kep., Ners., M.Kes
Bdn. Yaumil Fauziah, S.Tr.Keb., M.Keb.
Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes
Bdn. Israini Suriati, S.ST., M.Keb., CBMHCT.
Rina Utami, M.Tr.Keb.
Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat

Editor: Emy Yulianti, M.Kes

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-623-10-9625-8

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Prakata

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku Referensi yang berjudul "**Edukasi Kesehatan Reproduksi pada Ibu Hamil**" ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada ibu hamil, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas tentang pentingnya kesehatan reproduksi selama kehamilan. Melalui pembahasan yang komprehensif dan berbasis bukti, diharapkan buku ini menjadi sumber pengetahuan yang akurat, praktis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa pemahaman terhadap kesehatan reproduksi masih menjadi tantangan besar, khususnya di Indonesia, di mana angka kematian ibu masih cukup tinggi. Buku ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menguraikan berbagai aspek penting mulai dari perencanaan kehamilan yang sehat, tanda bahaya kehamilan, pentingnya nutrisi, hingga pemanfaatan teknologi dalam mendukung kesehatan ibu hamil. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas yang disajikan dalam buku ini menjadi kekuatan tersendiri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam proses penyusunan buku ini, penulis berupaya menghadirkan informasi yang dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dilengkapi dengan studi kasus nyata dan data-data terbaru. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran konstruktif senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan edisi selanjutnya.

Akhir kata, semoga buku ini membawa manfaat nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan reproduksi ibu hamil di Indonesia.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENTINGNYA KESEHATAN REPRODUKSI SELAMA KEHAMILAN	1
A.Pendahuluan.....	1
B.Kesehatan Reproduksi dalam Merencanakan Kehamilan Sehat	2
C.Pelayanan Antenatal Terpadu	4
D.Perawatan Sehari-hari Ibu Hamil.....	8
E.Program untuk Menjaga Kesehatan Ibu Hamil.....	9
F.Penutup.....	11
Referensi	12
BAB II EDUKASI TENTANG TANDA BAHAYA KEHAMILAN.....	13
A.Pendahuluan.....	13
B.Penyebab utama kematian ibu hamil di Indonesia pada tahun 2023.	14
C.Intervensi Pemerintah untuk Menurunkan AKI.	15
D.Peran Perawat dalam Meningkatkan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang tanda dan bahaya kehamilan	17
E.Asuhan Keperawatan Maternitas pada Ibu Hamil tentang tanda bahaya Kehamilan.....	21
F.Penutup.....	24
Referensi	25
BAB III PENGARUH NUTRISI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI IBU HAMIL.....	27
A.Pendahuluan.....	27
B.Peran Nutrisi dalam Kesehatan Reproduksi Ibu Hamil.....	27
C.Nutrisi dan Kesehatan Hormonal pada Ibu Hamil	29
D.Makronutrien dan Mikronutrien yang Mempengaruhi Kesuburan dan Kehamilan.....	32
E.Nutrisi yang Mendukung Kehamilan Sehat.....	41
F.Penutup.....	42
Referensi	44
BAB IV STRATEGIS KOMUNITAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN KESEHATAN REPRODUKSI	49
A.Pendahuluan.....	49
B.Definisi Kesehatan Reproduksi	51
C.Membangun Kerja Sama Antar-Sektor.....	58
D.Menggunakan Media Massa dan Teknologi dalam Penyuluhan	60
E.Penyuluhan dan Edukasi Berbasis Kasus di Komunitas	63
Referensi	66
BAB V PEMANFAATAN APLIKASI KESEHATAN UNTUK IBU HAMIL	69
A.Pendahuluan.....	69
B.PEMANFAATAN APLIKASI KESEHATAN UNTUK IBU HAMIL	69
1. Pengertian Kehamilan	69
2. Teknologi dalam Kesehatan Ibu Hamil.....	69
3. Manfaat Aplikasi Kesehatan bagi Ibu Hamil.....	71
4. Dampak Penggunaan Aplikasi terhadap Kesehatan Ibu dan Janin	71
5. Fungsi Aplikasi	72

6. Jenis Aplikasi.....	73
7. Selain menggunakan aplikasi, ibu hamil juga dapat menjaga kesehatannya dengan:..	74
8. Penggunaan Aplikasi	75
C.Penutup	77
Referensi	78
BAB VI DUKUNGAN PSIKOLOGIS BAGI IBU HAMIL DENGAN KOMPLIKASI.....	80
A.Pendahuluan.....	80
B.Konsep Kehamilan Risiko Tinggi	81
C.Dampak Komplikasi Kehamilan Terhadap Kesehatan Mental Ibu	84
D.Jenis Dukungan Psikologis yang Diperlukan	87
E.Peran Tenaga Kesehatan dan Keluarga	91
F.Strategi Implementasi Dukungan Psikologis	94
G.Studi Kasus atau Data Penunjang	97
H.Kesimpulan dan Rekomendasi	100
I.Penutup	102
Referensi	104
Profil Penulis	112

BAB I

PENTINGNYA KESEHATAN REPRODUKSI SELAMA KEHAMILAN

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi begitu luas. Kesehatan reproduksi bukan hanya tentang kesehatan reproduksi perempuan dalam arti yang sempit, contohnya hanya pada masalah perempuan usia subur yang telah menikah, kehamilan dan persalinan, tetapi mencakup hal yang lebih luas yaitu seluruh tahapan kehidupan perempuan mulai dari masa konsepsi, masa kehamilan, persalinan sampai usia lanjut. Masalah yang perlu diperhatikan dalam kesehatan reproduksi, yaitu kesehatan reproduksi, seks bebas di kalangan remaja, pencegahan penyakit HIV/ AIDS, PMS dan pencegahan kenakalan remaja, kontrasepsi dan Keluarga Berencana. (Wardhani, 2023)

Kegiatan Promosi hak-hak kesehatan reproduksi, advokasi hak-hak kesehatan reproduksi, KIE hak-hak kesehatan reproduksi dan sistem pelayanan hak-hak reproduksi. Pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan dan tingkat pendidikan ibu yang tinggi dapat mempengaruhi baiknya pengetahuan ibu tersebut tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Berbagai faktor yang banyak memberi pengetahuan pada manusia adalah pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Dari hasil yang didapatkan pada ibu hamil di Desa Gisik Cemandi ini, menunjukkan bahwa terdapat 66,67% responden berpendidikan minimal SMA/SMK, sehingga untuk menerima informasi sebagai salah satu upaya peningkatan pengetahuan mengenai kehamilan dan kesehatan reproduksi ini lebih mudah. Pengetahuan ibu hamil tentang kehamilan dan tingkat pendidikan ibu yang tinggi dapat mempengaruhi baiknya pengetahuan ibu tersebut tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Berbagai faktor yang banyak memberi pengetahuan pada manusia adalah pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Dari hasil yang didapatkan pada ibu hamil di Desa Gisik Cemandi ini, menunjukkan bahwa terdapat 66,67% responden berpendidikan minimal SMA/SMK, sehingga untuk menerima informasi sebagai salah satu upaya peningkatan pengetahuan mengenai kehamilan dan kesehatan reproduksi ini lebih mudah. (Harnani, 2022)

B. Kesehatan Reproduksi dalam Merencanakan Kehamilan Sehat

Perencanaan kehamilan baik untuk kehamilan yang aman dan sehat secara optimal sesuai yang diinginkan oleh keluarga salah satu faktor terpenting upaya dalam menurunkan angka kematian maternal. Menjaga jarak kehamilan bukan hanya untuk menyelamatkan ibu dan bayi sudut pandang kesehatan, tetapi juga memperbaiki kualitas hubungan psikologi keluarga.

Merencanakan kehamilan merupakan hal yang baik untuk dilakukan setiap pasangan suami istri. Baik itu dari psikolog/mental, fisik dan finansial tidak boleh diabaikan. Merencanakan kehamilan untuk persiapan kehamilan yang berguna untuk mendukung terciptanya kehamilan yang sehat dan menghasilkan keturunan yang berkualitas yang diinginkan keluarga

Beberapa faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Kehamilan Menurut Mirza (2008) ada hal yang perlu dipersiapkan dalam merencanakan kehamilan, diantaranya :

1. Kesiapan Aspek Psikologis

Apabila seorang ibu memutuskan untuk hamil, sebaiknya mulai menjalani konseling prahamil. Konseling ini merupakan saran dan anjuran, seperti dengan cara melakukan pemeriksaan fisik (pemeriksaan umum dan kandungan) dan laboratorium. Sebab, tujuan dari konseling prahamil ini akan menyiapkan calon ibu beserta calon ayah dan untuk menyiapkan kehamilan yang sehat sehingga bisa terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, bisa segera dideteksi atau ditangani bila ada penyakit yang diturunkan secara genetis, misalnya: diabetes militus, hipertensi, dan sebagainya. Konseling prahamil dilakukan untuk mencegah cacat bawaan akibat kekurangan zat gizi tertentu atau terpapar zat berbahaya.

2. Kesiapan Fisik

Pengaruh fisik berpengaruh terhadap proses kehamilan. Tanpa kesehatan fisik yang baik, kehamilan memungkinkan tidak akan terwujud dan bahkan kalau kehamilan itu terwujud, kemungkinan fisik yang tidak prima akan mempengaruhi kesehatan janin. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:

a. Mulai menata pola hidup

Selain kondisi tubuh, pola hidup dan lingkungan juga berpengaruh kesehatan fisik. Akan lebih baik lagi, bila persiapan fisik ini dilakukan secara maksimal kira-kira 6 bulan menjelang konsepsi.

b. Pencapaian berat badan ideal

Berat badan sangat berpengaruh terhadap kesuburan. Karena berat badan kurang atau berlebihan, mempengaruhi keseimbangan hormon dalam tubuh akan ikut terganggu. Akibatnya siklus ovulasi terganggu. Berat badan yang jauh dari ideal juga memicu terjadinya berbagai macam gangguan kesehatan.

TABEL 1. Berat Badan yang disarankan

Tinggi Badan (Cm)	Bentuk Badan		
	Kecil	Sedang	Besar
147	42 - 45	44 - 45	47 - 54
150	43 - 46	45 - 50	48 - 56
152	44 - 47	46 - 51	50 - 58
153	45 - 49	47 - 53	51 - 59
157	46 - 50	49 - 54	52 - 60
160	48 - 51	50 - 56	54 - 61
162	49 - 53	51 - 57	55 - 63
166	51 - 54	53 - 58	57 - 65
168	52 - 56	55 - 61	58 - 66
170	54 - 58	56 - 63	60 - 68
173	56 - 60	58 - 65	62 - 70
176	57 - 61	60 - 67	64 - 72
178	60 - 64	62 - 70	66 - 74
180	61 - 66	64 - 71	67 - 76
183	63 - 67	66 - 72	70 - 79

Sumber. Kemenkes RI

c. Menjaga pola makan

Disiplin memperbaiki pola makan bukannya tanpa alasan. Karena zat-zat gizi akan mengoptimalkan fungsi organ reproduksi, tetap mempertahankan kondisi kesehatan selama hamil, serta mempersiapkan cadangan energy bagi tumbuh kembang janin, Caranya sebagai berikut :

- 1) Mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air dalam menu makanan sehari-hari secara beragam dan dalam jumlah yang pas, sesuai kebutuhan.
- 2) Hindari bahan yang mengandung pengawet atau tambahan pada makanan, karena dapat menimbulkan kecacatan pada janin dan alergi.
- 3) Perbanyak makan-makanan yang segar dan tidak terlalu lama diolah, sehingga kandungan zat-zat gizinya tidak

4) Olahraga secara teratur

Olahraga memang berkhasiat untuk melancarkan aliran darah. Peredaran nutrisi dan pasokan oksigen ke seluruh organ tubuhpun jadi efisien, sebab benar-benar bebas hambatan. Jadi, kondisi seperti ini dibutuhkan untuk pembentukan sperma dan sel telur yang baik. Berolahraga secara rutin bisa pula memperbaiki mood karena meningkatnya produksi hormon endorphen. Tubuh juga lebih sehat dan bugar. Kalau ini yang terjadi, proses kehamilan, persalinan, serta kembalinya bentuk tubuh keadaan bentuk semula jadi lebih mudah. Yang paling cocok dilakukan yaitu olahraga jogging, jalan kaki, berenang, bersepeda dan senam.

3. Kesiapan Finansial

Persiapan finansial untuk ibu yang akan merencanakan kehamilan merupakan suatu kebutuhan yang mutlak yang harus disiapkan, dimana kesiapan finansial atau yang berkaitan dengan penghasilan dan keuangan yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan selama kehamilan berlangsung sampai persalinan (Kurniasih, 2010). Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kesiapan finansial, diantaranya:

a. Sumber keuangan

Memiliki anak memang tidak murah. Makanya, perlu merancang keuangan keluarga sejak jauh-jauh hari. Disadari atau tidak, anak ternyata membutuhkan alokasi dana yang cukup besar.

b. Ada beberapa dana yang wajib disiapkan sebagai calon orang tua, yaitu:

1) Saat hamil

Yaitu biaya pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan penunjang (laboratorium, USG, dan sebagainya), serta mengatasi penyakit (bila ada).

2) Saat bersalin

Meliputi biaya melahirkan (secara normal atau operasi caesar), "menginap" di rumah sakit pilihan, obat-obatan, serta biaya penolong persalinan.

3) Setelah bayi lahir

Memprioritaskan keuangan keluarga jadi berubah dan perlu memperhitungkan masa depan anak. (Linda, 2022)

C. Pelayanan Antenatal Terpadu

Pada ibu hamil pelayanan kesehatan tidak hanya dipisahkan dengan pelayanan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Fungsi

pelayanan antenatal yang diberikan akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu hamil dan janinnya, ibu bersalin dan bayi baru lahir serta ibu nifas.

Dalam pelayanan antenatal terpadu, tenaga kesehatan harus dapat memastikan bahwa kehamilan berlangsung normal, mampu mendeteksi dini masalah dan penyakit yang dialami ibu hamil, melakukan intervensi secara adekuat sehingga ibu hamil siap untuk menjalani persalinan normal.

Dalam pelayanan antenatal terpadu, tenaga kesehatan harus dapat memastikan bahwa kehamilan berlangsung normal, mampu mendeteksi dini masalah dan penyakit yang dialami ibu hamil, melakukan intervensi secara adekuat sehingga ibu hamil siap untuk menjalani persalinan normal.

Setiap kehamilan, dalam perkembangannya mempunyai risiko mengalami penyulit atau komplikasi. Oleh karena itu, pelayanan antenatal harus dilakukan secara rutin, sesuai standar dan terpadu untuk pelayanan antenatal yang berkualitas.

Pelayanan antenatal terpadu merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas yang dilakukan melalui :

- a. pemberian pelayanan dan konseling kesehatan termasuk stimulasi dan gizi agar kehamilan berlangsung sehat dan janinnya lahir sehat dan cerdas
- b. deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit/komplikasi kehamilan
- c. penyiapan persalinan yang bersih dan aman;
- d. perencanaan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi.
- e. penatalaksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat waktu bila diperlukan.
- f. Melibatkan ibu hamil, suami dan keluarganya dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi

Dalam melakukan pemeriksaan antenatal, tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai standar terdiri dari :

1. Timbang Berat Badan dan Ukur Tinggi Badan

Penimbangan berat badan pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan janin. Penambahan berat badan yang kurang dari 9 kilogram selama kehamilan atau kurang dari 1 kilogram setiap bulannya menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan janin. Pengukuran tinggi badan pada pertama kali kunjungan dilakukan untuk menapis adanya faktor risiko pada ibu hamil. Tinggi badan ibu hamil kurang dari 145 cm meningkatkan risiko untuk terjadinya Cephalo Pelvic Disproportion (CPD)

2. Ukur Tekanan Darah

Pengukuran tekanan darah pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya hipertensi (tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg) pada kehamilan dan preeklampsia (hipertensi disertai edema wajah dan atau tungkai bawah; dan atau proteinuria)

3. Nilai Status Gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas / LiLA)

Pengukuran LiLA hanya dilakukan pada kontak pertama oleh tenaga kesehatan di trimester I untuk skrining ibu hamil berisiko Kurang Energi Kronis (KEK). Kurang energi kronis disini maksudnya ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dan telah berlangsung lama (beberapa bulan atau tahun) dimana ukuran LiLA kurang dari 23,5 cm. Ibu hamil dengan KEK akan dapat melahirkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).

4. Ukur Tinggi Fundus Uteri

Pengukuran tinggi fundus pada setiap kali kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan umur kehamilan. Jika tinggi fundus tidak sesuai dengan umur kehamilan, kemungkinan ada gangguan pertumbuhan janin. Standar pengukuran menggunakan pita pengukur setelah kehamilan 24 minggu.

5. Tentukan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ)

Menentukan presentasi janin dilakukan pada akhir trimester II dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui letak janin. Jika pada trimester III bagian bawah janin bukan kepala, atau kepala janin belum masuk ke panggul berarti ada kelainan letak, panggul sempit atau ada masalah lain. Penilaian DJJ dilakukan pada akhir trimester I dan selanjutnya setiap kali kunjungan antenatal. DJJ lambat kurang dari 120 kali/menit atau DJJ cepat lebih dari 160 kali/menit menunjukkan adanya gawat janin.

6. Skrining Status Imunisasi Tetanus dan Berikan Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila Diperlukan

Untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum, ibu hamil harus mendapat imunisasi TT. Pada saat kontak pertama, ibu hamil diskriminasi status imunisasi T-nya. Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil, disesuaikan dengan status imunisasi T ibu saat ini. Ibu hamil minimal memiliki status imunisasi T2 agar mendapatkan perlindungan terhadap infeksi tetanus. Ibu hamil dengan status imunisasi T5 (TT Long Life) tidak perlu diberikan imunisasi TT lagi. Pemberian imunisasi TT tidak mempunyai interval maksimal, hanya terdapat interval minimal. Interval minimal pemberian imunisasi TT dan lama perlindungannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Imunisasi TT	Selang waktu minimal pemberian imunisasi	Lama Perlindungan
TT1		Langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus
TT2	1 bulan setelah TT 1	3 Tahun
TT3	6 bulan setelah TT 2	5 Tahun
TT4	12 bulan setelah TT 3	10 Tahun
TT5	12 bulan setelah TT 4	≥ 25 Tahun

7. Beri Tablet Tambah Darah (Tablet Besi)

Untuk mencegah anemia gizi besi, setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah (tablet zat besi dan asam folat) minimal 90 tablet selama kehamilan yang diberikan sejak kontak pertama.

8. Periksa Laboratorium (Rutin dan Khusus)

Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada ibu hamil adalah pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus. Pemeriksaan laboratorium rutin adalah pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan pada setiap ibu hamil yaitu golongan darah, hemoglobin darah, dan pemeriksaan spesifik daerah endemis/epidemi (malaria, HIV, dan lain-lain). Sementara pemeriksaan laboratorium khusus adalah pemeriksaan laboratorium lain yang dilakukan atas indikasi pada ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal. Pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat antenatal tersebut meliputi:

a. Pemeriksaan golongan darah

Pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil tidak hanya untuk mengetahui jenis golongan darah ibu melainkan juga untuk mempersiapkan calon pendonor darah yang sewaktu-waktu diperlukan apabila terjadi situasi kegawatdaruratan. Pemeriksaan dilakukan apabila ibu hamil belum diketahui golongan darahnya.

b. Pemeriksaan kadar Hemoglobin darah (Hb)

Pemeriksaan kadar hemoglobin darah ibu hamil dilakukan minimal sekali pada trimester pertama dan sekali pada trimester ketiga. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui ibu hamil tersebut menderita anemia atau tidak selama kehamilannya karena kondisi anemia dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang janin dalam kandungan. Pemeriksaan kadar hemoglobin darah ibu hamil pada trimester kedua dilakukan atas indikasi.

c. Pemeriksaan protein dalam urin

Pemeriksaan protein dalam urin pada ibu hamil dilakukan pada trimester kedua dan ketiga atas indikasi. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui adanya proteinuria pada ibu hamil. Proteinuria merupakan salah satu indikator terjadinya pre-eklampsia pada ibu hamil

d. Pemeriksaan kadar gula darah.

Ibu hamil yang dicurigai menderita diabetes melitus harus dilakukan pemeriksaan gula darah selama kehamilannya minimal sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester kedua, dan sekali pada trimester ketiga.

e. Pemeriksaan darah Malaria

Semua ibu hamil di daerah endemis Malaria (endemis sedang dan tinggi) dilakukan pemeriksaan darah Malaria dalam rangka skrining pada kontak pertama. Ibu hamil di daerah non endemis Malaria (endemis rendah) dilakukan pemeriksaan darah Malaria apabila ada indikasi

f. Pemeriksaan tes Sifilis

Pemeriksaan tes sifilis dilakukan di daerah dengan risiko tinggi dan ibu hamil yang diduga menderita sifilis. Pemeriksaan sifilis sebaiknya dilakukan sedini mungkin pada kehamilan.

g. Pemeriksaan HIV

Di daerah epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib menawarkan tes HIV kepada semua ibu hamil secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan.

9. Tatalaksana / Penanganan Kasus

Berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal di atas dan hasil pemeriksaan laboratorium, setiap kelainan yang ditemukan pada ibu hamil harus ditangani sesuai dengan standar dan kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan

10. Temu Wicara (Konseling)

Temu wicara (konseling) dilakukan pada setiap kunjungan antenatal.

D. Perawatan Sehari-hari Ibu Hamil

1. Menjaga Kebersihan Diri

- a. Rencuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun
- b. Mandi (keramas) dan gosok gigi 2x sehari (pagi dan sore).
- c. Menjaga kebersihan vagina.
- d. Periksa mulut

2. Istirahat yang cukup
3. Pasutri melakukan stimulasi dengan janin (mengajak komunikasi)
4. Selama kehamilan sehat boleh melakukan hubungan suami istri.
5. Makan makanan secara proporsional Aktivitas Fisik yang Harus Dihindari Ibu Hamil (Rachmayani, 2024)

E. Program untuk Menjaga Kesehatan Ibu Hamil

Gizi pada ibu hamil harus terpenuhi agar mencukupi kebutuhan janinnya, dengan status gizi yang baik sebelum merencanakan kehamilan seperti tidak kurus dan tidak anemia. Karena asupan zat gizi bayi dalam kandungan diperoleh zat gizi dari gizi ibunya. Pemantauan pertambahan berat badan ibu selama hamil menjadi penilaian untuk mengetahui janin mendapat asupan gizi cukup. Janin yang kurang mendapat asupan gizi selama kehamilan dapat menghambat tumbuh kembangnya yang dapat mengakibatkan lahir dengan berat badan rendah. IMT (indeks Massa Tubuh) menjadi tolak ukur untuk mengetahui status gizi ibu, dengan cara :

$$\text{IMT} = \frac{\text{BB (kg)}}{\text{TB(m)}^2}$$

Tabel 2 : Pertambahan BB Selama Hamil

IMT sebelum hamil (kg/m²)	Kenaikan BB selama hamil (kg)	Kenaikan BB TM III (rentang rerata kg/minggu)
Gizi Kurang / KEK ($<18,5$)	12,71 – 18,16	0,45 (0,45-0,59)
Normal (18.5-24,9)	11,35 – 15,89	0,45 (0,36-0,45)
Kelebihan BB (25,0-29,9)	6,81 – 11,35	0,27 (0,23-0,32)
Obes ($\geq 30,0$)	4,99 – 9,08	0,23 (0,18-0,27)

a. Gizi Seimbang

Ibu hamil harus mengonsumsi gizi seimbang untuk mencukupi gizinya dan tumbuh kembang janinnya. Gizi seimbang dapat dipenuhi melalui :

- 1) Mengonsumsi berbagai makanan dengan porsi banyak. Makanan beraneka ragam perlu dikonsumsi lebih banyak selama hamil karena adanya peningkatan kebutuhan zat gizi diantaranya :
 - a) Protein

Protein dapat diperoleh dengan konsumsi ikan, telur, susu yang bertujuan pertumbuhan janin dan kesehatan ibu hamil.

b) Zat besi

Sumber zat besi dengan konsumsi ikan, daging, hati dan tempe, selain itu mengonsumsi tablet tambah darah. Zat besi berperan dalam pembentukan hemoglobin (hb) pada sel darah merah, yang dapat mengakibatkan anemia (hb kurang) yang dapat menyebabkan BBLR dan perdarahan pada ibu.

c) Asam folat

Sayuran hijau termasuk sumber asam folat seperti bayam, kacang-kacangan yang berfungsi untuk pembentukan sel dan sistem saraf

d) Vitamin

Apel, avocado, pepaya (buah berwarna) menjadi sumber vitamin dan mengurangi risiko sembelit pada ibu hamil.

e) Kalsium

Sumber kalsium yaitu sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan teri, susu. Kekurangan kalsium pada ibu hamil dapat mengakibatkan pengeroposan tulang dan gigi serta komplikasi (keracunan kehamilan).

f) Iodium

Sumber iodium yaitu makan laut (ikan, udang, kerang, rumput laut). Iodium berfungsi mengatur tumbuh kembang janin, dan merupakan bagian dari hormon tiroksin dan triiodotironin.

2) Makanan yang mengandung garam tinggi dibatasi.

Hal ini untuk menghindari hipertensi selama kehamilan yang dapat memicu kematian janin, pertumbuhan terhambat dan solusio plasenta.

3) Konsumsi air putih yang banyak

2-3 liter/hari kebutuhan yang diperlukan ibu hamil guna mendukung produksi cairan amnion, volume darah dan sirkulasi darah. Selain itu banyak konsumsi air putih membantu pencernaan, mengatur suhu tubuh

4) Konsumsi kafein dikurangi

Sumber kafein yaitu kopi, coklat, teh dan minuman suplemen energi. Kopi merupakan sumber utama kafein, jika tidak dibatasi akan mengakibatkan dehidrasi (selalu BAK), hipertensi dan detak jantung meningkat

b. Pemberian Tablet Tambah Darah

Ibu hamil konsumsi 90 tablet tambah darah selama kehamilan (1 tablet/hari) sebagai upaya pencegahan anemia. Ibu hamil mengalami penurunan hb pada TM I,II dan meningkat pada TM III. Rentan terjadi anemia pada kehamilan karena adanya peningkatan volume darah untuk pembentukan plasenta janin.

c. Pemberian Kalsium

1.500–2.000 mg/oral direkomendasikan pemberian suplemen tablet kalsium pada ibu hamil guna mengurangi risiko preeklamsia.

F. Penutup

Segala puji bagi tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan memberikan nilai dan kesungguhan dalam belajar. Dalam penyusunan buku ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca merupakan yang utama untuk jalan menuju kesuksesan. Akhir tiada kata yang paling indah kecuali puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah diberikan .

Referensi

- Hanifiya Samha Wardhani, Dyah Hariani, Nur Ducha, Nur Anindya Syamsudi, PELATIHAN KONSELING SEBAYA PADA SISWA SMA TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI, SEKS BEBAS DAN PERNIKAHAN DINI , Jurnal Abadimas Adi Buana: Vol. 8 No. 01 (2024): Jurnal Abadimas Adi Buana
- Harnani, B. D. (2022). Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING.
- Linda, Y. S. (2022). Buku Saku Perencanaan Kehamilan Sehat. Purwokerto.
- Rachmayani, A. N. (2024). Dasar Kesehatan Reproduksi. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Wardhani, H. S. (2023). Jurnal Abadimas Adi Buana, 9.

BAB II

EDUKASI TENTANG TANDA BAHAYA KEHAMILAN

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan suatu proses dalam kehidupan seorang wanita yang membawa perubahan besar pada aspek fisik, mental, dan sosialnya. Perubahan tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut meliputi faktor fisik, lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi. Masing-masing faktor saling berkaitan dan berpotensi membentuk hubungan sebab akibat, sehingga saling mempengaruhi (Patiyah et al., 2021).

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah indikator penting yang mencerminkan kesehatan dan kualitas hidup penduduk. Menurut WHO, setiap hari sekitar 830 wanita di seluruh dunia meninggal akibat komplikasi kehamilan atau persalinan, dengan total sekitar 303.000 kematian ibu setiap tahun. Hampir semua kematian ini (99%) terjadi di negara berkembang, dengan angka 239 per 100.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi dibandingkan negara maju yang hanya 12 per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi fokus utama dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), dengan target global untuk menurunkan AKI menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (WHO, 2023).

Menurut Kementerian Kesehatan (2021) kematian ibu masih menjadi masalah di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Salah satu penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah preeklamsia. Preeklamsia merupakan salah satu jenis komplikasi selama kehamilan yang berkelanjutan (Ahmad & Nurdin, 2019).

Menurut Basyiar et al. (2021), Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator buruknya kondisi perekonomian dan fasilitas kesehatan termasuk pelayanan pemeriksaan kehamilan dan persalinan. Preeklampsia merupakan salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas ibu dan janin, angka kejadiannya sekitar 0,5%-38,4%.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kematian ibu pada tahun 2023 mencapai 4.129 kasus, meningkat dari 4.005 kasus pada tahun 2022. Berdasarkan data yang tersedia hingga tahun 2022, Provinsi Jawa Timur mencatat 499 kasus kematian ibu pada tahun tersebut, menurun signifikan dari 1.279 kasus pada tahun 2021. Meskipun data spesifik untuk tahun 2023 belum tersedia.

Pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat, khususnya ibu hamil dalam upaya menurunkan angka kematian ibu. Pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan seperti perdarahan pervaginam, hiperemesis gravidarum, ketuban pecah dini, sakit kepala yang lebih dari biasa, gangguan penglihatan, pembengkakan pada wajah dan tangan, nyeri abdomen serta janin tidak bergerak seperti biasanya ini penting karena apabila tanda-tanda bahaya tersebut diketahui sejak dini, maka penanganan akan lebih cepat. Mendeteksi secara dini tentang tanda bahaya tersebut dengan cara mengetahui apa saja tanda tanda bahaya dari kehamilan tersebut (Maisura, A., & Darmawati, D. 2016) .

B. Penyebab utama kematian ibu hamil di Indonesia pada tahun 2023.

Angka kematian ibu dan bayi merupakan dua indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan di suatu negara. Di Indonesia dua hal ini menjadi perhatian pemerintah karena angka kematian ibu dan bayi di Tanah Air masuk peringkat tiga besar di ASEAN. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, dr. Lovely Daisy, M. K. M., pada acara temu media dalam rangka hari prematur sedunia pada 15 Desember 2023.

Berdasarkan data dari Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), sistem pencatatan kematian ibu Kementerian Kesehatan, jumlah kematian ibu pada tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129. Sementara itu, untuk kematian bayi pada 2022 sebanyak 20.882 dan pada tahun 2023 tercatat 29.945.

Penyebab utama kematian ibu hamil di Indonesia pada tahun 2023 meliputi: Hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia dan eklamsia): Kondisi ini ditandai dengan tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan kejang dan komplikasi serius lainnya.

1. Perdarahan: Perdarahan hebat, terutama saat persalinan, menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu.
2. Infeksi (sepsis): Infeksi yang terjadi selama kehamilan atau setelah melahirkan dapat menyebabkan sepsis, yang berpotensi fatal jika tidak ditangani dengan cepat.
3. Komplikasi persalinan: Masalah seperti persalinan macet atau komplikasi lain selama proses persalinan dapat meningkatkan risiko kematian ibu.
4. Penyakit jantung dan kardiovaskular: Gangguan pada sistem kardiovaskular selama kehamilan juga berkontribusi terhadap angka kematian ibu.

Berdasarkan data yang tersedia hingga tahun 2024, Kabupaten Jombang mencatat 23 kasus kematian ibu pada tahun 2023, meningkat dari 16 kasus pada tahun 2022. Penyebab utama kematian ibu hamil di Kabupaten Jombang pada tahun 2023 meliputi:

1. Komplikasi selama kehamilan: Terdapat 7 kasus kematian ibu yang disebabkan oleh komplikasi seperti perdarahan, infeksi, eklampsia, partus macet, abortus, dan robekan rahim.
2. Komplikasi pasca persalinan: Sebanyak 4 kasus kematian ibu terjadi akibat komplikasi setelah melahirkan.

Penyebab tidak langsung: Terdapat 12 kasus kematian ibu yang disebabkan oleh faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi kesehatan ibu selama kehamilan.

Selain itu, pernikahan dini juga menjadi faktor risiko yang signifikan. Perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan karena kondisi kesehatan yang belum matang. Untuk menurunkan angka kematian ibu, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang telah mengimplementasikan berbagai program, termasuk peningkatan layanan USG di puskesmas. Dengan tersedianya fasilitas USG dan tenaga medis terlatih, diharapkan dapat membantu dalam deteksi dini komplikasi kehamilan dan menurunkan angka kematian ibu.

C. Intervensi Pemerintah untuk Menurunkan AKI.

Penurunan angka kematian ibu dan bayi menjadi salah satu program prioritas yang dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sejumlah program dilakukan Kemenkes, seperti program sebelum kehamilan, saat hamil, dan juga perawatan untuk bayi prematur dan BBLR. Sejumlah masalah kesehatan yang dialami oleh ibu hamil di antaranya adalah 48,9 persen ibu hamil dengan anemia, 12,7 persen dengan hipertensi, 17,3 persen kurang energi kronik (KEK), dan 28 persen dengan risiko komplikasi.

Upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meliputi penguatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, yang memberikan layanan promotif dan preventif untuk mencegah komplikasi kehamilan dan persalinan. Salah satu program penting adalah Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), yang bertujuan memberdayakan masyarakat dengan melibatkan keluarga dan bidan dalam memantau ibu hamil, bersalin, dan nifas. Program P4K bertujuan memastikan persalinan yang aman, mengantisipasi komplikasi, serta merencanakan penggunaan metode Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan (Maryunani, A., & Puspita, 2021).

Untuk mengatasi masalah pada ibu hamil tersebut, Kemenkes, Daisy menerangkan, telah membuat sejumlah kebijakan yang diharapkan menyelamatkan sang ibu dan bayinya. Program tersebut di antaranya adalah pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil yang dulunya hanya dilakukan empat kali kini diubah menjadi enam kali. Dua kali dalam enam pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi risiko komplikasi yang terjadi pada ibu hamil yang mungkin akan berdampak pada sang ibu dan bayi yang dikandungnya.

Kelas ibu hamil merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang kesehatan kehamilan dan disarankan untuk puskesmas agar lebih sering melaksanakan kelas ibu (Imiyani, S. N., Yusuf, N. N., & Susilamayanti, 2020). Ketidak patuhan ibu dalam mengikuti kelas ibu hamil adalah salah satu kendala yang nantinya dapat berdampak global bagi kesehatan ibu (Mardha & Panjaitan, 2020). Masih banyak ibu hamil yang belum mengetahui tanda- tanda bahaya kehamilan sehingga kelas ibu hamil digunakan sebagai sarana yang dipakai untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan dapat disimpulkan bahwa kelas ibu hamil berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tanda dan bahaya kehamilan (Munawarah & Hidayati, 2021).

Faktor penyebab ibu tidak mengikuti salah satu kelas ibu hamil adalah dukungan keluarga. Bentuk dukungan keluarga ada 4 yaitu dukungan instrumental misalnya tidak bisa mengantarkan ke klinik yang dikarenakan jadwal kelas ibu hamil bersamaan dengan jam kerja keluarga, ini dapat disebabkan karena keluarga sudah pergi kerja dan keluarga menganggap ibu mampu untuk pergi sendiri. Dukungan informasi: keluarga kurang mengetahui manfaat kelas ibu hamil, sehingga keluarga tidak begitu mendukung ibu hamil untuk ikut kelas ibu hamil. Dukungan emosional: keluarga menganggap bahwa ibu hamil bisa mandiri dalam kegiatan kelas ibu hamil. Dukungan penilaian: keluarga tidak pernah memuji ibu hamil selama mengikuti senam hamil (Astuti, W. W., Sofiyanti, I., & Widyaningsih, 2016).

Hasil penelitian Yuli Bahriah, menunjukan bahwa kegiatan kelas ibu hamil yaitu menyampaikan pesan atau materi penyuluhan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh ibu hamil, suami atau keluarga. Dengan Kelas ibu hamil dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya kehamilan dan juga memberikan informasi serta memotivasi ibu hamil agar aktif dalam kegiatan kelas ibu hamil (Bahriah et al., 2022).

Pelaksanaan Kelas ibu hamil dilakukan 1 bulan sekali di wilayah kerja Puskesmas Cukir tempat pelaksanaan kegiatan dilakukan di Balai desa Bandung. Dari kegiatan kelas ibu hamil dapat disimpulkan ada perbedaan ibu Hamil yang mengikuti kelas ibu dengan ibu hamil yng tidak mengikuti kelas ibu. Adapun kendala dalam kegiatan kelas ibu hamil yaitu masih adanya ibu hamil yang tidak datang ke

posyandu dengan alasan bekerja serta dukungan keluarga dan suami karena masih banyaknya ibu hamil yang datang ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan antenatal care (ANC) dan kegiatan kelas Ibu hamil tidak didampingi oleh Suami atau Keluarga.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin dan deteksi dini terhadap faktor risiko diharapkan dapat membantu menurunkan angka kematian ibu hamil di Kabupaten Jombang. (*2 Tahun Capai 294 Kasus, Angka Kematian Ibu Dan Bayi Terus Meningkat Sepanjang Tahun Di Jombang _ Desa Kita*, n.d.)

Salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah adalah penyediaan buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA). ibu hamil wajib memiliki Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Buku KIA penting untuk memantau kesehatan ibu dan bayi.

Manfaat Buku KIA

1. Mendapatkan informasi tentang kesehatan ibu dan anak, termasuk nutrisi, perawatan bayi, dan tanda-tanda bahaya.
2. Mencatat pelayanan kesehatan yang diterima, seperti kunjungan ke bidan atau dokter, imunisasi, dan pemberian makanan tambahan.
3. Memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala.
4. Mendeteksi dini risiko dan penyakit yang mungkin terjadi.

Ibu hamil bisa mendapatkan buku KIA saat melakukan pemeriksaan kehamilan yang pertama kali di fasilitas kesehatan terdekat, Ibu hamil wajib membawa buku KIA saat konsultasi setiap bulan selama kehamilan, Ibu wajib membawa buku KIA saat akan kontrol kesehatan bayi baru lahir, imunisasi, atau saat anak sedang sakit.

Semua kebijakan yang diimplementasikan pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa adanya perubahan perilaku ibu-ibu yang menjadi penggerak dalam menurunkan AKI dan AKB, juga perilaku ibu hamil dalam meningkatkan pengetahuan tentang kehamilannya.

D. Peran Perawat dalam Meningkatkan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang tanda dan bahaya kehamilan

Peran Perawat Profesional adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Asuhan Keperawatan

Sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Perawat memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan klien secara holistic, meliputi upaya untuk mengembalikan kesehatan emosi, spiritual dan sosial. Pemberi asuhan memberikan bantuan kepada klien dan keluarga klien dengan menggunakan energy dan waktu yang minimal. Selain itu, dalam perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat memberikan perawatan dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosis keperawatan agar bisa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat dan sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar manusia, kemudian dapat dievaluasi tingkat perkembangannya. Pemberian asuhan keperawatannya dilakukan dari yang sederhana sampai yang kompleks.

2. Membuat Keputusan Klinis

Membuat keputusan klinis adalah inti pada praktik keperawatan. Untuk memberikan perawatan yang efektif, perawat menggunakan keahliannya berfikir kritis melalui proses keperawatan. Sebelum mengambil tindakan keperawatan, baik dalam pengkajian kondisi klien, pemberian perawatan, dan mengevaluasi hasil, perawat menyusun rencana tindakan dengan menetapkan pendekatan terbaik bagi klien. Perawat membuat keputusan sendiri atau berkolaborasi dengan klien dan keluarga. Dalam setiap situasi seperti ini, perawat bekerja sama, dan berkonsultasi dengan pemberi perawatan kesehatan profesional lainnya (Keeling dan Ramos, 1995).

3. Pelindung dan Advokat Klien

Sebagai pelindung, perawat membantu mempertahankan lingkungan yang aman bagi klien dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serta melindungi klien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu tindakan diagnostic atau pengobatan. Contoh dari peran perawat sebagai pelindung adalah memastikan bahwa klien tidak memiliki alergi terhadap obat dan memberikan imunisasi melawat penyakit di komunitas. Sedangkan peran perawat sebagai advokat, perawat melindungi hak klien sebagai manusia dan secara hukum, serta membantu klien dalam menyatakan hak-haknya bila dibutuhkan. Contohnya, perawat memberikan informasi tambahan bagi klien yang sedang berusaha untuk memutuskan tindakan yang terbaik baginya. Selain itu, perawat juga melindungi hak-hak klien melalui cara-cara yang umum dengan menolak aturan atau tindakan yang mungkin

membahayakan kesehatan klien atau menentang hak-hak klien. Peran ini juga dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien, juga dapat berperan mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi hak atas pelayanan sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak untuk menerima ganti rugi akibat kelalaian.

4. 4. Manager Kasus

Dalam perannya sebagai manager kasus, perawat mengkoordinasi aktivitas anggota tim kesehatan lainnya, misalnya ahli gizi dan ahli terapi fisik, ketika mengatur kelompok yang memberikan perawatan pada klien. Berkembangnya model praktik memberikan perawat kesempatan untuk membuat pilihan jalur karier yang ingin ditempuhnya. Dengan berbagai tempat kerja, perawat dapat memilih antara peran sebagai manajer asuhan keperawatan atau sebagai perawat asosiat yang melaksanakan keputusan manajer (Manthey, 1990). Sebagai manajer, perawat mengkoordinasikan dan mendelegasikan tanggung jawab asuhan dan mengawasi tenaga kesehatan lainnya.

5. Rehabilitator

Rehabilitasi adalah proses dimana individu kembali ke tingkat fungsi maksimal setelah sakit, kecelakaan, atau kejadian yang menimbulkan ketidakberdayaan lainnya. Seringkali klien mengalami gangguan fisik dan emosi yang mengubah kehidupan mereka. Disini, perawat berperan sebagai rehabilitator dengan membantu klien beradaptasi semaksimal mungkin dengan keadaan tersebut.

6. Pemberi Kenyamanan

Perawat klien sebagai seorang manusia, karena asuhan keperawatan harus ditujukan pada manusia secara utuh bukan sekedar fisiknya saja, maka memberikan kenyamanan dan dukungan emosi seringkali memberikan kekuatan bagi klien sebagai individu yang memiliki perasaan dan kebutuhan yang unik. Dalam memberi kenyamanan, sebaiknya perawat membantu klien untuk mencapai tujuan yang terapeutik bukan memenuhi ketergantungan emosi dan fisiknya.

7. Komunikator

Keperawatan mencakup komunikasi dengan klien dan keluarga, antar sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya, sumber informasi dan komunitas. Dalam memberikan perawatan yang efektif dan membuat keputusan dengan klien dan keluarga tidak mungkin dilakukan tanpa komunikasi yang jelas. Kualitas

komunikasi merupakan factor yang menentukan dalam memenuhi kebutuhan individu, keluarga dan komunitas.

8. Penyuluh

Sebagai penyuluh, perawat menjelaskan kepada klien konsep dan data-data tentang kesehatan, mendemonstrasikan prosedur seperti aktivitas perawatan diri, menilai apakah klien memahami hal-hal yang dijelaskan dan mengevaluasi kemajuan dalam pembelajaran. Perawat menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan klien serta melibatkan sumber-sumber yang lain misalnya keluarga dalam pengajaran yang direncanakannya.

9. Kolaborator

Peran perawat disini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapi, ahli gizi dan lain-lain dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya.

10. Edukator

Peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkatpengetahuan kesehatan, gejala penyakit bahkan tindakan yang diberikan sehingga terjadi perubahab perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan.

11. Konsultan

Peran disini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan.

12. Pembaharu

Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan.

Perawat merupakan tenaga terbesar di Puskesmas, mempunyai peran yang penting terutama dalam perawatan kesehatan masyarakat. Peran perawat tersebut dapat dilaksanakan antara lain sebagai pendidik/edukator dan konselor. Untuk melaksanakan peran tersebut dengan baik, perawat harus memiliki persepsi yang baik tentang perannya terhadap kesehatan masyarakat dan kemampuan perawat menjalankan peran dan fungsinya secara bertanggungjawab. Peran perawat tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi pelayanan kesehatan dalam bentuk program kerja dengan pihak-pihak terkait.

Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat (Andini et al., 2018);(Wahyudi, 2020). Peraturan Menteri Kesehatan 43 tahun 2019

tentang puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Puskesmas sebagai pemberi layanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui berbagai upaya kesehatan, antara lain penyediaan fasilitas maupun optimalisasi peran petugas kesehatan. Namun hal ini belum berdampak secara signifikan dalam penurunan angka kematian ibu.

Pengetahuan adalah informasi yang ditemukan dan diperoleh oleh manusia melalui pengamatan akal untuk mengenali suatu benda atau kejadian yang belum pernah mereka lihat atau rasakan sebelumnya. Pengetahuan seringkali digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang (Hatimah, Ningsih, and Syahleman 2022). Beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat pengetahuan seseorang meliputi tingkat pendidikan, akses terhadap media massa atau informasi, pengaruh sosial dan budaya, lingkungan sekitar, pengalaman pribadi, serta usia individu (Hatimah, Ningsih, and Syahleman 2022).

E. Asuhan Keperawatan Maternitas pada Ibu Hamil tentang tanda bahaya Kehamilan

Asuhan keperawatan pada masa kehamilan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan janin selama kehamilan sampai bayi dilahirkan dengan selamat. Salah satu kegiatan yang kami laksanakan dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu hamil adalah memberikan edukasi tentang kehamilan risiko tinggi. Hasil penelitian yang kami lakukan di Desa Bandung, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang terhadap 24 Ibu Hamil pada tanggal 1 Maret 2025 adalah sbb:

Tabel 2.1: Data kepemilikan buku KIA

No.	Kepelikan Buku KIA	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Memiliki	24	100
2.	Tidak memiliki	0	0
Jumlah		24	100.00

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa seluruh ibu hamil (100%) telah memiliki buku KIA yang difasilitasi oleh pemerintah melalui bidan Desa. Hal ini

menunjukkan peran tenaga kesehatan dalam membagikan buku KIA sudah mencapai target yang diharapkan, yaitu semua ibu hamil telah memiliki Buku KIA.

Tabel 2.2: Data minat baca

No	Minat baca	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Sudah membaca	20	83,33
2.	Belum membaca	4	16,67
Jumlah		24	100.00

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hampir seluruh ibu hamil (83,33%) telah membaca buku KIA yang difasilitasi oleh pemerintah melalui bidan Desa. Dari data tersebut menunjukkan bahwa meskipun sudah diberi buku KIA, belum ada jaminan bahwa buku KIA tersebut akan dibaca oleh ibu hamil.

Tabel 2.3: Data Kemampuan memahami isi buku KIA

No	Kemampuan memahami	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1.	Paham	12	50
2.	Tidak Paham	12	50
Jumlah		24	100.00

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hanya setengahnya (50%) ibu hamil yang memahami isi dari buku KIA.

Tabel 2.4: Tabulasi silang antara ibu yang sudah membaca buku KIA dengan kemampuan memahami isi buku KIA

NO	Membaca	PAHAM		TIDAK PAHAM		TOTAL	
		f	%	F	%	F	%
1	Sudah membaca	12	60	8	40	20	100
2	Belum membaca	2	50	2	50	4	100

Sumber: Data primer

Berdasarkan tabel tabulasi silang diatas, Ibu yang sudah membaca buku KIA, sebagian besar (60 %) sudah memahami isi buku KIA, sedangkan ibu yang belum

membaca buku KIA setengahnya (50 %) belum memahami isi buku. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Tidak ada perbedaan yang signifikan tentang pemahaman isi buku KIA antara ibu yang sdh membaca dengan ibu yang belum membaca.

TABEL 4.5: Tingkat Pengetahuan ibu hamil sebelum dan sesudah diberi edukasi tentang bahaya kehamilan

NO	PENGETAHUAN	BAIK		CUKUP		KURANG		TOTAL	
		F	%	f	%	f	%	F	%
1	Pre-test	13	54	9	38	2	8	24	100
2	Post-test	19	79	4	17	1	4	24	100

Sumber: Data primer

Sebelum diberi edukasi tentang tanda dan bahaya kehamilan (saat pre-test) tingkat pengetahuan ibu tentang tanda dan bahaya kehamilan yang mempunyai pengetahuan baik sejumlah 13 orang (54%), sedangkan yang mempunyai pengetahuan kurang sebanyak 2 orang (8%). Setelah dilakukan edukasi (post-test) tentang tanda dan bahaya kehamilan, skor tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tanda dan bahaya kehamilan mengalami peningkatan yaitu ibu hamil yang mempunyai pengetahuan baik sejumlah 19 orang (79 %), sedangkan yang mempunyai pengetahuan kurang sebanyak 1 orang (4%). Berarti diperlukan adanya edukasi untuk bisa meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang tanda dan bahaya kehamilan, meskipun ibu sudah membaca buku KIA.

Dari data yang kami peroleh bisa disimpulkan, meskipun ibu telah memiliki buku KIA, tetapi tetap diperlukan adanya suatu kegiatan penyuluhan pada ibu hamil untuk bisa meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang kondisi kehamilannya dan pentingnya periksa kehamilan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ziadatul Munawaroh, di Wilayah Kerja puskesmas Bayumulek, menunjukan bahwa dari 10 ibu hamil yang memeriksa kehamilannya hanya 4 orang yang mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan, peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak ibu hamil yang belum mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan (Munawarah & Hidayati, 2021).

Menurut teori tenaga kesehatan berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, 2014), Tenaga kesehatan adalah individu yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui

pendidikan khusus. Mereka memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat. Hal ini berkontribusi pada pencapaian derajat kesehatan yang tinggi sebagai investasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Tenaga kesehatan terdiri dari berbagai petugas yang saling berkaitan, termasuk dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya. Menurut asumsi peneliti bahwa peran tenaga kesehatan yang memberikan edukasi dan konseling secara rutin kepada ibu hamil memiliki peran dalam meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan. Ibu hamil yang sering berinteraksi dengan tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, dan perawat, memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi tentang tanda bahaya kehamilan dibandingkan dengan ibu hamil yang jarang mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan. Peran tenaga kesehatan bagi ibu hamil dapat meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang pentingnya mengenali tanda bahaya selama kehamilan.

F. Penutup

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang kami lakukan pada ibu hamil, menunjukkan bahwa program pemerintah dalam menurunkan AKI dengan membagikan buku KIA sebagai media informasi bagi ibu Hamil telah dilaksanakan dengan baik oleh bidan desa. Namun ternyata tidak semua ibu hamil membaca buku KIA tersebut, terlebih hanya separo dari ibu hamil yang mengerti tentang Kehamilan risiko tinggi. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan dan kemampuan ibu hamil sangat bervariasi, sehingga pembangunan kesehatan untuk ibu dan bayi masih belum berjalan optimal.

Rekomendasi yang diberikan dalam upaya mengoptimalkan penurunan AKI adalah kegiatan pendampingan kepada ibu hamil dengan memberikan edukasi tentang tanda bahaya dalam kehamilan. Perlu memperkuat peran dan kerjasama lintas sektor, tokoh masyarakat serta kemitraan untuk memotivasi ibu hamil datang ke tempat pelayanan kesehatan.

Referensi

- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 2022. "Profil Kesehatan 2021". Diakses pada 1 April 2023 dari <https://dinkes.jatimprov.go.id/userfile/dokumen/PROFIL%20KESEHATAN%202021%20JATIM.pdf>
- Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. 2021. "Profil kesehatan 2021". Diakses pada 1 April 2023 dari <https://dinkes.jombangkab.go.id/assets/files/Profil%20Kesehatan/2021/Profil%20Kesehatan%20Kab%20Jombang%202021.pdf>
- Kementrian Kesehatan Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan. 2022. Prinsip Etik Pada Tindakan Keperawatan. Diakses pada 8 Desember 2023 dari https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/69/prinsip-etik-pada-tindakan-keperawatan
- Kementrian Kesehatan. 2023. Mengenal Preeklamsia. Diakses pada 8 Desember 2023 dari https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2745/mengenal-preeklampsia
- Adnyani, K. D. W. (2021). Prenatal Yoga Untuk Kondisi Kesehatan Ibu Hamil. *Jurnal Yoga Dan Kesehatan*, 4(1), 35. <https://doi.org/10.25078/jyk.v4i1.2067>
- Ahmad, Z., & Nurdin, S. S. I. (2019). Faktor Risiko Kejadian Preeklamsia Di Rsia Siti Khadijah Gorontalo. *Akademika*, 8(2), 150. <https://doi.org/10.31314/akademika.v8i2.408>
- Basyiar, A., Mamlukah, M., Iswarawanti, D. N., & Wahyuniar, L. (2021). Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Trimester Ii Dan Iii Di Puskesmas Cibeureum Kabupaten Kuningan Tahun 2019. *Journal of Public Health Innovation*, 2(1), 50–60. <https://doi.org/10.34305/jphi.v2i1.331>
- Februari, N., Insani, U., Ni, J., & Ratnaningsih, A. (2024). *Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak bersama Masyarakat Edukasi Tanda Dan Gejala Preeklampsia Serta Pencegahannya Pada Ibu Hamil Education On The Signs And Symptoms Of Preeclampsia And Prevention In Pregnant Women Universitas Bhamada, Slawi P. 2(1)*.
- Julianti, E., 2 : A., & Patimah, S. (2023). Prenatal Yoga Menurunkan Kecemasan Ibu Hamil Trimester Iii. *WOMB Midwifery Journal (WOMB Mid.J)*, 2(1), 1–5.
- Komariah, S., & Nugroho, H. (2020). Hubungan Pengetahuan, Usia Dan Paritas Dengan Kejadian Komplikasi Kehamilan Pada Ibu Hamil Trimester Iii Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Aisyiyah Samarinda. *KESMAS UWIGAMA: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 83–93. <https://doi.org/10.24903/kujkm.v5i2.835>
- Melgarejo, J. D., Yang, W. Y., Thijs, L., Li, Y., Asayama, K., Hansen, T. W., Wei, F. F., Kikuya, M., Ohkubo, T., Dolan, E., Stolarz-Skrzypek, K., Huang, Q. F., Tikhonoff, V., Malyutina, S., Casiglia, E., Lind, L., Sandoya, E., Filipovský, J., Gilis-Malinowska, N., ...

- Zhang, Z. Y. (2021). Association of Fatal and Nonfatal Cardiovascular Outcomes With 24-Hour Mean Arterial Pressure. *Hypertension*, 77(1), 39–48. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14929>
- Patiyah, P., Carolin, B. T., & Dinengsih, S. (2021). Pengaruh Senam Prenatal Yoga Terhadap Kenyamanan Ibu Hamil Trimester III. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 13(2), 174–183. <https://doi.org/10.37012/jik.v13i2.463>
- Pusparini, D. A., Kurniawati, D., & Kurniyawan, E. H. (2021). Hubungan Tingkat Stres dengan Kualitas Tidur pada Ibu Preeklamsi di Wilayah Kerja Puskesmas Tempurejo-Jember. *Pustaka Kesehatan*, 9(1), 16. <https://doi.org/10.19184/pk.v9i1.16139>
- Hatimah, Sanah Hatul, Rastia Ningsih, and Rukmini Syahleman. 2022. "HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN KECEMASAN PADA PASIEN PRE OPERASI DI RUANG MERANTI RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN." *Jurnal Borneo Cendekia* 6(1).
- Maisura, A., & Darmawati, D. (2016). Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Pengetahuan Tanda Bahaya Kehamilan Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Darussalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, 1(1). *Jurnal Cendikia Muda*, Volume 3, Nomer 2, Juni 2023 Wati, Penerapan Pendidikan Kesehatan 228

BAB III

PENGARUH NUTRISI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI IBU HAMIL

A. Pendahuluan

Nutrisi selama kehamilan memainkan peran krusial untuk mempertahankan kesehatan ibu dan perkembangan janin yang optimal. Asupan gizi yang tepat tidak hanya mendukung pertumbuhan fisik janin, tetapi juga mempengaruhi kesehatan reproduksi ibu secara keseluruhan. Kekurangan nutrisi pada masa kehamilan dapat berdampak negatif, seperti meningkatkan risiko stunting pada anak dan komplikasi kehamilan lainnya (Deputy et al., 2016; Mirza et al., 2023). Kesehatan reproduksi ibu yang buruk dan gizi selama kehamilan akan berdampak seumur hidup pada kesehatan bayi yang dilahirkannya. Kondisi gizi pada ibu hamil memiliki akan berkaitan dengan berat bayi yang dilahirkan. Ibu yang mengalami defisiensi gizi akan berisiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), dan dapat mempengaruhi kesehatan bayi yang dilahirkannya (Permatasari et al., 2021).

Pentingnya nutrisi seimbang selama kehamilan selain berdampak pada kesehatan fisik, juga berperan dalam mencegah berbagai komplikasi kehamilan dan memastikan kesejahteraan ibu serta bayi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai kebutuhan nutrisi dan implementasinya dalam pola makan sehari-hari menjadi esensial bagi setiap ibu hamil.

B. Peran Nutrisi dalam Kesehatan Reproduksi Ibu Hamil

Nutrisi merupakan aspek yang mendasar dalam kesehatan reproduksi. Berbagai zat gizi memiliki peranan penting dalam mempertahankan fungsi reproduksi yang optimal. Nutrisi memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita yang tidak dapat diabaikan. Asupan gizi yang seimbang berkontribusi terhadap fungsi optimal ovarium, pengaturan siklus menstruasi, serta meningkatkan kesuburan. Oleh karena itu penting untuk memahami peran gizi dalam menjaga kesehatan reproduksi, serta pemilihan makan yang tepat dalam memberikan manfaat yang signifikan bagi kualitas dan potensi kesuburan (Gaskins & Chavarro, 2018).

Asupan nutrisi yang cukup penting dalam menjaga system reproduksi. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, kualitas sel

telur, dan gangguan perkembangan janin (Ma et al., 2022). Kesehatan reproduksi merupakan proses yang melibatkan diferensiasi seksual, pematangan gametogenesis, pembuahan dan perkembangan embrio yang bertujuan dalam pelestarian keturunan. Faktor nutrisi memainkan peranan penting dalam menentukan kesehatan reproduksi dan dapat mempengaruhi kesuburan pada manusia. Oleh karena itu perlu diketahui jenis makanan apa yang tepat dan bagaimana pengaruhnya terhadap sistem reproduksi (Sharma et al., 2013). Konsumsi makronutrien dan mikronutrien akan berhubungan dengan kesehatan reproduksi wanita, dalam rangka mempersiapkan pembuahan, kehamilan dan menyusui.

Asupan nutrisi yang cukup akan mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Selama masa kehamilan wanita perlu mendapatkan nutrisi yang adekuat untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang optimal. Pola makan ibu sebelum dan masa kehamilan akan berkaitan dengan kelahiran bayi dan kesehatan ibu. Kondisi medis yang berhubungan erat dengan asupan makanan dapat mempengaruhi wanita sebelum atau selama kehamilan yang akan memberikan dampak terhadap munculnya gangguan atau patologi pada bayi baru lahir. Kecukupan gizi sebelum kehamilan akan menentukan bayi yang dilahirkan dan pertumbuhan bayi serta menunjang fungsi alat reproduksi dapat berfungsi secara optimal (Martínez-Galiano et al., 2020).

Persiapan kehamilan dimulai dengan kematangan organ reproduksi, kualitas ovum dan sperma serta gizi yang seimbang dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Beberapa peran zat gizi dalam menjaga kesehatan reproduksi antara lain:

1. Asam Lemak Omega-3

Zat gizi ini berperan dalam menjaga kesehatan ovarium, terutama DHA (*Asam Docosahexaenoic*) dan EPA (*Asam eicosapentaenoic*) berperan dalam menjaga kesehatan ovarium serta mengatur keseimbangan hormon. Omega-3 berkontribusi dalam mengurangi peradangan dan meningkatkan sirkulasi darah ke rahim, sehingga mempengaruhi kesuburan. Asupan Omega-3 yang signifikan meningkatkan tingkat kesuburan dan kehamilan (Trop-Steinberg et al., 2024).

2. Zat Besi

Zat besi adalah mineral esensial yang berperan dalam pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah, dan mendukung transportasi oksigen ke dalam darah. Defisiensi zat besi akan menyebabkan anemia dan akan berdampak pada kesehatan reproduksi wanita. Wanita dengan kadar zat besi yang rendah cenderung mengalami gangguan siklus menstruasi dan perdarahan yang berat. Oleh karena itu, asupan zat besi sangat penting untuk menjaga Kesehatan

reproduksi, siklus menstruasi dan meningkatkan kualitas sel telur (Pibriyanti et al., 2021). Defisiensi zat besi juga berhubungan dengan risiko kesuburan yang rendah pada wanita. Oleh karena itu wanita penting memperhatikan pola makan dengan gizi seimbang untuk menjaga kesehatan reproduksi agar lebih baik.

3. Vitamin D

Vitamin D memiliki peran krusial dalam mendukung kesehatan reproduksi wanita. Nutrisi ini secara tidak langsung mempengaruhi fungsi ovarium dan mengatur siklus menstruasi. Kekurangan vitamin D berkaitan dengan terjadinya gangguan ovulasi dan penurunan Tingkat kesuburan. Sehingga sangatlah penting bagi wanita untuk mendapatkan asupan vitamin D yang memadai agar meningkatkan kesuburan, peluang dalam keberhasilan konsepsi dan kehamilan (Irani & Merhi, 2014).

C. Nutrisi dan Kesehatan Hormonal pada Ibu Hamil

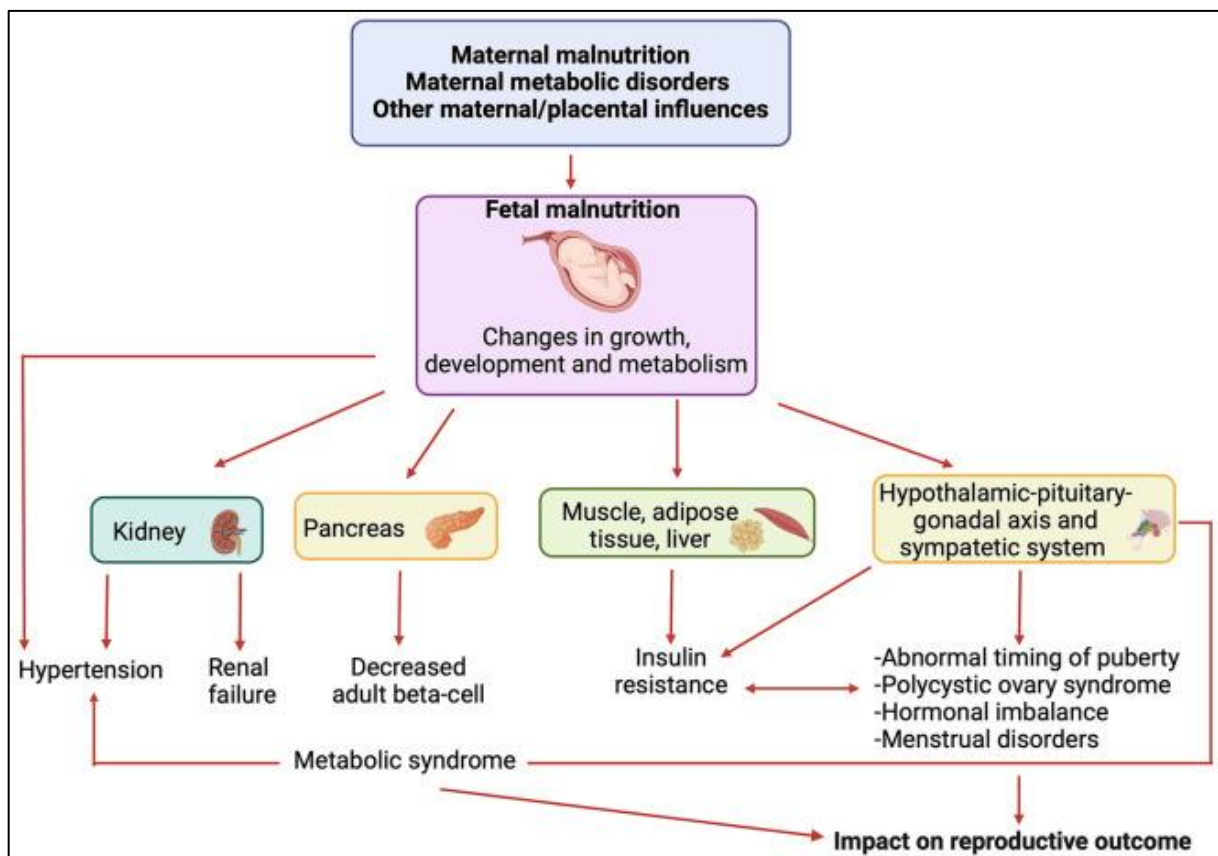
Hormon merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh sistem endokrin untuk mempengaruhi berbagai proses di dalam tubuh. Hormon di dalam tubuh manusia dihasilkan oleh kelenjar pituitary, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal dan sejumlah sel khusus lainnya. Mekanisme kerja hormon dimulai dari hormon yang dihasilkan oleh suatu kelenjar kemudian dibawa melalui aliran darah dengan membawa pesan menuju organ atau jaringan target. Hormon mengatur berbagai fungsi fisiologis seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi dan juga respon stress (Roberto, 2024)

Proses kehamilan mempengaruhi banyak perubahan baik fisiologis maupun psikologis. Perubahan fisiologis pada sistem organ disebabkan perubahan kadar hormon yang dimulai sejak pembuahan dan selama masa kehamilan. Peningkatan kadar estrogen dan progesterone dimulai dalam 12 minggu pertama kehamilan, dan selanjutnya akan disekresikan oleh plasenta. Hal ini akan menyebabkan serangkaian adaptasi yang mempengaruhi semua sistem di dalam tubuh (Gangakhedkar & Kulkarni, 2021).

Hormon memiliki peran dalam mengatur berbagai proses fisiologis di dalam tubuh. Sehingga sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan hormon. Berbagai faktor dapat mempengaruhi produksi dan kerja hormon diantaranya makanan, obat-obatan, stress dan lingkungan. Faktor nutrisi dapat mempengaruhi kadar hormon secara signifikan. Faktor utama nutrisi yang memiliki pengaruh terhadap hormon meliputi gula, karbohidrat olahan, lemak, kekurangan nutrisi esensial dan pola makan yang tidak sehat. Ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan

gangguan metabolisme, gangguan reproduksi, perubahan suasana hati, kecemasan, depresi, dan penurunan kognitif(Chandana & Kumar Maurya, 2020).

Nutrisi memainkan peranan penting dalam menjaga keseimbangan hormonal selama masa kehamilan, yang akan berdampak langsung pada Kesehatan ibu dan perkembangan janin. Perubahan hormonal yang signifikan selama masa kehamilan membutuhkan asupan nutrisi yang tepat untuk mendukung proses fisiologis dan memastikan kesejahteraan ibu dan pertumbuhan janin yang optimal. Kemampuan reproduksi dipengaruhi oleh status gizi ibu melalui jalur berikut:



Gambar 1. Hubungan antara kondisi gizi selama perkembangan janin, penyakit metabolik dan hasil reproduksi (Calcaterra *et al.*, 2024)

Nutrisi selama masa kehamilan dapat mempengaruhi perkembangan system endokrin dan reproduksi janin (Che *et al.*, 2017). Pengangkutan nutrisi dan proses metabolisme di dalam plasenta memainkan peranan penting dalam menentukan berat janin, yang merupakan faktor penting dalam pemograman system endokrin selama fase kritis perkembangan janin. Pertumbuhan prenatal yang kurang baik dapat menyebabkan perubahan permanen pada sistem endokrin dan akan

mempengaruhi pada pematangan seksual dan fungsi reproduksi (Calcaterra et al., 2021).

Kekurangan nutrisi selama periode kritis pertumbuhan janin dapat menyebabkan perubahan struktural dan fungsi pada organ seperti hipotalamus, kelenjar pituitary, tiroid, dan gonad. Perubahan ini dapat menyebabkan waktu pubertas yang tidak normal, *Polycystic ovary syndrome* (PCOS), ketidakseimbangan hormon, dan gangguan menstruasi sehingga dapat mempengaruhi banyak aspek termasuk pertumbuhan dan perkembangan yang akan berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan infertilitas. Selain itu defisiensi gizi tertentu selama masa perkembangan janin dapat mempengaruhi metabolisme dan Kesehatan di masa dewasa, sehingga meningkatkan risiko timbulnya penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2 dan obesitas, sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan tingkat kesuburan (Montagnoli et al., 2022).

Peranan nutrisi dalam kesehatan reproduksi antara lain:

1. Peran Nutrisi dalam Keseimbangan Hormon

Selama masa kehamilan ibu mengalami peningkatan produksi hormon estrogen, progesterone dan *Human Chorionic Gonadotropin* (hCG). Asupan nutrisi yang adekuat dapat membantu dalam sintesis dan regulasi hormon-hormon ini. Sebagai contoh asam lemak Omega-3 berperan dalam produksi hormon dan memiliki efek antiinflamasi yang mendukung Kesehatan ibu dan janin. Sumber Omega-3 dapat diperoleh dari ikan salmon, biji rami dan kacang kenari. Selain faktor asupan nutrisi, pola makan ibu yang sehat pada masa kehamilan akan bermanfaat bagi kesehatan ibu dan bayi. Wanita hamil harus menjaga asupan nutrisi selama kehamilan dan lebih selektif dalam memilih makanan yang mengandung nutrisi yang mengandung vitamin dan mineral (Pratiwi & Hamidiyanti, 2020).

2. Pentingnya Protein dalam Fungsi Hormonal

Protein memiliki peran dalam produksi hormon dan enzim yang mengatur berbagai fungsi tubuh selama kehamilan. Asupan protein yang cukup dapat mendukung pertumbuhan janin, termasuk otak, serta membantu peningkatan suplai darah ibu. Protein bersumber dari daging tanpa lemak, unggas, ikan, telur, produk susu, dan kacang-kacangan.

3. Vitamin & Mineral Pendukung Kesehatan Hormonal

Vitamin juga memiliki peran penting dalam Kesehatan hormonal di dalam tubuh. Vitamin yang berperan tersebut diantaranya:

- a) Vitamin B6

Vitamin ini memiliki peran dalam sintesis neurotransmitter dan membantu mengurangi gejala mual pada trimester pertama. Sumber vitamin B6 terdapat pada pisang, kacang-kacangan, dan biji-bijian.

b) Vitamin D

Vitamin D berperan dalam mendukung penyerapan kalsium dan berperan dalam fungsi imun. Kekurangan vitamin D dapat mempengaruhi keseimbangan hormonal dan kesehatan tulang. Sumber vitamin D berasal dari sinar matahari, ikan berlemak dan produk susu

c) Zat Besi

Zat besi dibutuhkan dalam produksi hemoglobin dan mencegah anemia. Kondisi anemia dapat mempengaruhi suplai oksigen ke janin dan menyebabkan kelelahan pada ibu. Zat Besi bersumber dari daging merah, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Selama kehamilan, kebutuhan zat besi meningkat dibandingkan kondisi tidak hamil karena zat besi diperlukan dalam peningkatan volume darah, pertumbuhan, dan perkembangan janin

4. Dampak Kekurangan Nutrisi terhadap Kesehatan Hormonal ibu Hamil

Kekurangan nutrisi tertentu selama masa kehamilan dapat mengganggu keseimbangan hormonal dan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Sebagai contoh ibu hamil yang mengalami defisiensi asam folat dapat menyebabkan cacat tabung saraf pada janin, kekurangan yodium dapat mengganggu perkembangan otak janin dan fungsi tiroid. Oleh karena itu, ibu hamil perlu mengonsumsi makanan yang seimbang, kaya vitamin dan mineral esensial untuk mencegah komplikasi selama kehamilan.

D. Makronutrien dan Mikronutrien yang Mempengaruhi Kesuburan dan Kehamilan

Asupan zat gizi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia. Selain diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan asupan zat gizi juga memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kesuburan pada reproduksi manusia. Kebutuhan gizi makronutrien dan mikronutrien dalam reproduksi manusia diperlukan untuk menghasilkan kematangan seksual, dan menjaga kesehatan organ reproduksi sehingga akan mempengaruhi tingkat kesuburan seseorang (Dewantari, 2013). Status gizi adalah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya infertilitas. Berat badan yang berlebihan atau kurang akan mempengaruhi keterlambatan konsepsi, risiko keguguran, dan tingkat keberhasilan terapi fertilitas yang lebih rendah. Berat badan lebih dapat mempengaruhi fungsi dan produksi

hormon androgen dan estrogen. Peningkatan androgen dari ovarium dan peningkatan estrogen dari lemak tubuh akan menghambat ovulasi. Berat badan kurang juga membahayakan kesehatan reproduksi dan dapat mempengaruhi produksi hormon androgen dan progesterone (Aritonang et al., 2024).

Selain mempengaruhi pada infertilitas pada wanita, status gizi juga berpengaruh pada wanita selama kehamilan sebab hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatannya dan generasi mendatang. Makanan yang dibutuhkan ibu hamil berbeda dengan yang dibutuhkan wanita yang tidak hamil. Kebutuhan nutrisi pada ibu hamil tidak hanya kebutuhan gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak saja. Namun melibatkan peran penting dari vitamin, mineral dan juga omega-3. Elemen-elemen ini sangat penting dalam perkembangan selama masa kehamilan, membantu ibu mengatasi ketidaknyamanan dan juga mencegah komplikasi dalam kehamilan (Alum et al., 2023). Kehamilan menyebabkan berbagai perubahan fisiologis yang penting untuk perkembangan janin serta kesehatan ibu. Perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu hamil salah satunya adalah peningkatan berat badan yang menunjukkan perubahan awal yang dapat diamati selama kehamilan. Penambahan berat badan dalam masa kehamilan dikaitkan dengan perkembangan konsepsi yang optimal (Deputy et al., 2016).

Kebutuhan nutrisi meliputi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan janin. Kebutuhan zat gizi makro seperti energi dan protein meningkat selama kehamilan untuk menjaga homeostasis ibu sekaligus mendukung pertumbuhan janin. Pembatasan energi dapat mengurangi penambahan berat badan gestasional pada wanita dengan obesitas, namun tidak dengan energi pada kehamilan. Pada wanita yang kekurangan gizi, pemberian suplementasi energi/protein yang seimbang dapat meningkatkan berat lahir. Sedangkan suplementasi protein tinggi dapat berdampak buruk pada pertumbuhan janin. Sehingga perlu mengatur asupan energi/protein yang seimbang untuk mencegah gangguan pada masa kehamilan dan juga gangguan pada janin (Mousa et al., 2019).

Makronutrien adalah nutrisi esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar untuk mendukung berbagai fungsi vital di dalam tubuh. Komponen makronutrien terbagi menjadi tiga yaitu karbohidrat, protein dan lemak. Ketiga nutrisi ini dibutuhkan dalam jumlah besar karena berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Berikut jenis makronutrien yang diperlukan bagi tubuh yaitu:

1. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi sel, jaringan dan organ tubuh untuk menjalankan fungsinya. Karbohidrat sebagai makronutrien akan diubah menjadi glukosa yang akan digunakan secara langsung maupun

disimpan sebagai cadangan energi bagi tubuh. Pada ibu hamil energi merupakan penentu utama dalam penambahan berat badan selama masa kehamilan. Selama kehamilan konsumsi makanan ibu berperan dalam menyediakan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Selain itu, energi tambahan dibutuhkan dalam pembentukan jaringan baru seperti janin, plasenta dan cairan ketuban. Pada trimester pertama, kebutuhan energi umumnya tidak jauh berbeda dengan wanita yang tidak hamil. Namun, kebutuhan ini meningkat pada minggu ke-10 hingga ke -30 kehamilan. Kebutuhan energi wanita pada masa kehamilan sangat bervariasi, hal ini dapat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas, indeks masa tubuh sebelum kehamilan, dan juga metabolisme (Ho et al., 2016).

2. Protein

Protein sebagai makronutrien berperan dalam fungsi biologis struktural seperti keratin dan kolagen dan juga berfungsi dalam transportasi protein dan juga hormon (Biswas, 2021). Protein hewani berasal dari makanan seperti daging, telur, ikan dan susu, sementara protein nabati berasal dari biji-bijian dan kacang-kacangan. Protein hewani dianggap sebagai protein lengkap karena mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Asam amino esensial berperan penting dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan tubuh (Hou & Wu, 2018). Kebutuhan protein pada ibu hamil berkisar antara 60 gram-100 gram per hari, tergantung berat badan, tingkat aktivitas fisik dan juga usia kehamilan.

3. Lemak

Lemak adalah makronutrien yang berfungsi sebagai cadangan energi serta membantu dalam penyerapan vitamin A, D, E, dan K. selain itu, lemak berperan dalam pembentukan membran sel, melindungi organ tubuh, dan mengatur suhu tubuh (Youness et al., 2022).

Pada wanita lemak memiliki peranan penting dalam Kesehatan reproduksi yang dapat mempengaruhi kesuburan. Asam lemak Omega-3 dan asam lemak tak jenuh memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan tubuh terutama dalam perkembangan otak, fungsi sistem kardiovaskuler, menjaga kesuburan wanita yang akan terlibat dalam proses implementasi dan kehamilan. Selain itu juga lemak tak jenuh berkontribusi dalam pematangan oosit dan perkembangan embrio. Sebaliknya asam lemak trans (TFA) memiliki dampak yang negatif terhadap kesuburan yaitu dapat menyebabkan resistensi insulin dan mengganggu fungsi ovarium dan menyebabkan infertilitas ovulasi. Oleh

karena itu, meningkatkan makan makanan yang kaya akan lemak tak jenuh dan omega-3 serta rendah TFA dapat membantu meningkatkan kesuburan pada wanita (Chiu et al., 2018).

Sumber lemak tak jenuh seperti kacang-kacangan, alpukat, minyak zaitun, ikan salmon. Sedangkan Omega-3 seperti telur, ikan salmon, ikan teri, sayuran dan juga buah-buahan. Asam lemak Omega-3 berguna untuk membantu perkembangan otak. WHO merekomendasikan asupan omega-3 bagi ibu hamil sekitar 200-300 mg per hari.

Selain makronutrien yang berperan dalam mempengaruhi kesehatan reproduksi, mikronutrien juga memiliki peran dalam menjaga organ reproduksi dalam menjalankan fungsinya dalam kesuburan maupun kehamilan. Mikronutrien merupakan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah lebih kecil dari makronutrien. Mikronutrien memiliki fungsi yang penting dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Peran yang sangat penting dari mikronutrien adalah berfungsi sebagai katalisator dalam proses metabolisme energi dan juga metabolisme sel dan jaringan dalam tubuh. Kebutuhan mikronutrien pada wanita hamil berbedanya dengan kebutuhan pada wanita tidak hamil. Asupan mikronutrien harian ibu hamil dapat ditentukan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Jenis mikronutrien yang penting bagi tubuh yaitu:

1. Vitamin A

Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak dan berasal dari retinoid yang diperoleh melalui makanan sehari-hari. Retinoid berupa asam retinal dan retinoat bersumber dari makanan hewani seperti susu, hati, dan minyak hati ikan. Sedangkan, karotenoid seperti beta-karoten diperoleh dari sayuran seperti wortel, kangkung, ubi jalar, dan lainnya. Beta-karoten diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh dan disimpan di hati. Vitamin A berperan pada kesehatan mata dalam diferensiasi sel, pemeliharaan integritas mata dan pencegahan xeroftalmia. Selain berperan dalam menjaga kesehatan mata, vitamin A juga berperan dengan perkembangan tulang, perlindungan pada kulit dan mukosa, menjaga kesehatan organ reproduksi, menjaga sistem kekebalan tubuh, pemeliharaan jaringan epitel dan pertumbuhan gigi dan rambut (Carazo et al., 2021). Pada wanita hamil vitamin A berperan untuk perkembangan embrio. Peningkatan kebutuhan vitamin A terjadi pada trimester ketiga, karena pada masa ini terjadi percepatan perkembangan janin. Kebutuhan harian vitamin A pada ibu hamil disarankan tidak lebih dari 8000 IU per hari, dosis yang

berlebihan (> 10.000 IU/hari) dapat menyebabkan kelainan kraniofasial, kelainan jantung, dan menyebabkan teratogenic (Alum et al., 2023).

2. Vitamin D

Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak dan berperan untuk menjaga keseimbangan kalsium serta kesehatan tulang. Fungsi lain dari vitamin D adalah berperan dalam metabolisme glukosa, angiogenesis, peradangan, dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin D bersumber dari paparan sinar matahari serta dari makanan seperti minyak ikan dan produk susu (Dominguez et al., 2021). Vitamin D sangat dibutuhkan pada masa kehamilan, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan berbagai masalah yang serius karena ibu hamil merupakan salah satu kelompok umur berisiko tinggi. Kekurangan vitamin D pada masa kehamilan dapat menyebabkan gangguan pada tulang seperti rachitis, osteomalasia, dan hipokalsemia neonatus. Pada awal kehamilan dianjurkan melakukan pemeriksaan untuk melihat status ibu hamil mengalami defisiensi vitamin D atau tidak dengan melakukan pengukuran terhadap kadar 25 (OH)D (dihidroksi vitamin D) serum dalam darah (Aji, 2016).

3. Vitamin E

Anemia merupakan masalah kesehatan yang mempengaruhi pada wanita hamil dan bersalin. Kejadian anemia ibu hamil mencapai 48,9%, anemia pada ibu hamil didefinisikan sebagai kadar hemoglobin (Hb) <11gr%. Anemia selama kehamilan akan berdampak negatif pada kesehatan ibu dan anak serta meningkatkan risiko kecatatan, kematian ibu dan perinatal (Stephen et al., 2018). Terjadinya anemia sering dikaitkan dengan vitamin E, defisiensi vitamin E dapat menyebabkan kerusakan pada eritrosit sehingga menimbulkan terjadinya anemia.

Vitamin E adalah vitamin yang larut dalam lemak dan memiliki berbagai peran penting dalam tubuh seperti menjaga kesuburan, antioksidan, antipenuaan dini dan meningkatkan kekebalan tubuh. Efek antioksidan dari vitamin E dapat melawan radikal bebas yang berbahaya menjadi asam lemak fosfat dan menjaga kestabilan membran sel. Vitamin E memiliki hubungan erat dengan metabolisme lipid pada wanita hamil dan berhubungan dengan stress oksidatif, preeklamsia, dan gangguan kehamilan lainnya. Defisiensi vitamin E pada wanita hamil dapat menyebabkan peningkatan radikal bebas, peningkatan peroksidasi lipid, kerusakan endotel vascular, dan penuaan plasenta, peningkatan risiko hipertensi gestasional, gawat janin dan pecahnya ketubuh sebelum waktunya. Vitamin E yang berlebihan pada wanita hamil dapat menghambat kerja vitamin lain dan

antikoagulan sehingga meningkatkan risiko hyperbilirubinemia (Wang et al., 2023).

4. Asam Folat

Asam folat adalah bentuk sintetis dari folat, yang merupakan vitamin B9. Vitamin ini banyak ditemukan dalam tanaman serta terdapat dalam sel darah manusia dalam bentuk poliglutamat. Asam folat merupakan nutrisi penting bagi ibu hamil karena berperan dalam replikasi DNA serta berfungsi sebagai substrat pada berbagai reaksi enzimatik yang terlibat dalam sintesis asam amino dan metabolisme vitamin. Kebutuhan asam folat meningkat pada kehamilan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Peningkatan ini terjadi akibat bertambahnya beberapa komponen jaringan ibu, seperti cadangan lemak, volume darah, dan kelenjar susu, serta perkembangan janin, ketuban, dan plasenta (Lipinwati, 2019).

Sekitar 24-60% wanita hamil, tidak menyadari bahwa mereka mengalami kekurangan asam folat dari makanan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, wanita hamil sangat disarankan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung asam folat serta menambah asupan dengan suplemen asam folat dari mulai sebelum terjadi kehamilan dan saat hamil. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan menghindari gangguan pada kehamilan dan kecacatan pada janin (Nisa & Handayani, 2019).

Kebutuhan asam folat pada wanita hamil meningkat dibandingkan wanita normal. Kebutuhan asam folat pada wanita usia subur dan ibu hamil sekitar 400-600 mcg/hari. Asam folat sangat penting pada masa awal kehamilan, karena terjadi pembentukan sistem saraf pada janin. Kekurangan/defisiensi asam folat dapat menimbulkan kelainan pada janin. Kelainan kongenital adalah gangguan yang terjadi selama pertumbuhan janin dalam rahim dan dapat mempengaruhi struktur, fungsi, atau metabolisme tubuh. Kelainan ini dapat terdeteksi sebelum kelahiran maupun saat bayi dilahirkan (Yuandry et al., 2023). Adapun kelainan kongenital yang dikaitkan dengan defisiensi asam folat antara lain:

a) Spina bifida

Spina bifida adalah kelainan bawaan yang terjadi sejak dalam kandungan akibat kegagalan penutupan tabung saraf selama tahap awal perkembangan embrio. Kondisi ini menyebabkan tulang belakang tidak menutup sempurna di sekitar sumsum tulang belakang yang sedang berkembang.

b) Anensefalus dan Omfalokel

Anensefalus adalah kondisi Dimana Sebagian tulang tengkorak dan otak tidak terbentuk. Kelainan ini terjadi akibat gangguan pada tabung saraf pada tahap awal perkembangan janin, yang menyebabkan kerusakan jaringan pembentuk otak. Sementara itu, omfalokel adalah kelainan bawaan Dimana organ dalam rongga perut menonjol keluar melalui dinding perut di sekitar area umbilicus, namun tetap terbungkus dalam membran pelindung.

c) Kelainan Jantung

Cacat jantung merupakan kelainan bawaan yang terjadi akibat gangguan dalam proses pembentukan dan perkembangan jantung sejak masa janin di dalam kandungan.

d) Bibir Sumbing

Bibir sumbing (*labioschisis*) adalah kelainan bawaan yang ditandai dengan adanya celah pada bibir akibat kegagalan penyatuan jaringan pembentuk bibir selama perkembangan janin.

e) Anemia megaloblastic

Anemia megaloblastic adalah jenis anemia yang ditandai dengan pembesaran eritoblas di sumsum tulang yang menghambat pematangan inti sel serta pembelahan sel eritrosit. Kondisi ini umumnya disebabkan karena terjadi defisiensi vitamin B-12 dan asam folat yang mengganggu sintesis DNA.

f) *Down Syndrom*

Down syndrom merupakan Kelainan genetic yang menyebabkan kelainan fisik yang khas dan rendahnya tingkat kecerdasan.

g) Kelahiran Prematur dan Berat Bayi Lahir Rendah

Kelahiran prematur adalah kelahiran yang terjadi sebelum cukup bulan atau mencapai 37 minggu dengan berat bayi kurang dari 2500 gram.

5. Kalsium

Kalsium adalah mineral yang paling melimpah dalam tubuh manusia, sekitar 99% kandungannya tersimpan dalam tulang. Mineral ini sangat penting pada berbagai fungsi fisiologis yang terjadi di dalam tubuh, seperti pada proses pembekuan darah, menjaga potensi membran sel bersama dengan natrium dan

kalium, mengatur transmisi sinyal dari reseptor hormon, mendukung eksibilitas neuromuskuler, mempertahankan integritas membran sel, membantu pembentukan struktur tulang, serta berfungsi sebagai cadangan kalsium di dalam tubuh. Sumber makanan yang mengandung kalsium meliputi produk susu, susu kedelai, yogurt, keju, serta sayuran seperti kubis, dan brokoli. Selain itu, kalsium juga dapat diperoleh dari almond, sarden, salmon, dan jus jeruk (Cormick & Belizán, 2019).

Kalsium memiliki peran penting dalam berbagai proses tubuh, termasuk pembentukan tulang, kontraksi otot, serta fungsi hormon dan enzim. Asupan kalsium yang tidak mencukupi pada ibu hamil dapat menimbulkan berbagai efek samping, seperti osteopenia, tremor, parestesia, kram otot, tetanus, gangguan pertumbuhan janin, dan berat badan lahir rendah. Selama masa kehamilan janin membutuhkan kalsium dalam jumlah besar untuk pertumbuhannya. Janin menyimpan sekitar 28,2 gram kalsium dengan 80% dari jumlah tersebut diperoleh pada trimester ketiga. Sekresi kalsium selama kehamilan meningkat dua kali lipat dibandingkan wanita tidak hamil, sebagai bentuk kompensasi terhadap kebutuhan janin dan peningkatan sekresi kalsium. Kadar kalsium dalam plasma darah dipengaruhi proses absorpsi kalsium pada saluran cerna, reabsorpsi kalsium dari tulang, serta sekresi melalui tinja, urine, dan keringat. Regulasi keseimbangan kalsium dalam tubuh dikendalikan oleh hormon seperti paratiroid, kalsitonin dan vitamin D (Gustirini, 2019).

Asupan kalsium yang direkomendasikan bervariasi antara negara satu dengan lainnya mulai dari 900-1200 mg/hari. *World Health Organization* (WHO) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO) merekomendasikan asupan kalsium 1200 mg per hari bagi wanita hamil, sementara untuk orang dewasa yang tidak hamil (usia 19-50 tahun), kebutuhan kalsium yang disarankan adalah 1000 mg per hari (Willemse et al., 2020).

6. Besi

Zat besi adalah mineral yang berperan penting untuk mencegah anemia defisiensi besi. Sumber zat besi dapat diperoleh dari berbagai makanan seperti sayuran hijau, daging merah, kuning telur, ikan, kacang-kacangan dan buah-buahan kering. Zat besi sangat penting sebagai kofaktor dalam proses sintesis hemoglobin dan transportasi oksigen, peningkatan volume darah, pertumbuhan plasenta, perkembangan janin, regulasi gen dan enzim. Kebutuhan zat besi meningkat pada ibu hamil (22-27 mg/hari). Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kapasitas penyerapan zat besi di dalam usus yang meningkat 10-40% pada akhir kehamilan. Proses penyerapan zat besi melibatkan vitamin C,

sedangkan kopi dan teh menghambat dalam penyerapan zat besi karena memiliki kandungan polifenol (Mousa et al., 2019).

Kekurangan zat besi dapat disebabkan oleh ketidakcukupan asupan atau ketidakmampuan tubuh memenuhi kebutuhan zat besi. Anemia defisiensi zat besi sering kali terjadi pada wanita hamil karena meningkatnya kebutuhan zat besi selama kehamilan. Anemia dikategorikan sebagai anemia berat jika kadar Hemoglobin < 7 gr/dL, sedangkan anemia sedang jika kadar Hb 7-9 gr/dL. Ambang batas dalam menentukan anemia defisiensi besi jika kadar feritin < 15 µg/L, dan kadar Hb < 11 gr/dL pada trimester pertama dan < 10,5 gr/dL pada trimester kedua (Patel & Balanchivadze, 2021).

Defisiensi zat besi pada kehamilan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), kecacatan, kejadian preeklamsia, gangguan perkembangan kognitif pada anak dan kematian bayi. Oleh karena itu, wanita hamil dianjurkan untuk mengonsumsi suplemen zat besi untuk memenuhi kecukupan kebutuhan zat besi bagi ibu dan janin. Bagi wanita hamil dengan defisiensi zat besi (feritin < 15 µg/L), penambahan zat besi sebesar 60-120 mg per hari dapat meningkatkan hemoglobin sebesar 2 gr/dL dalam satu bulan. Konsumsi suplemen zat besi menimbulkan efek samping seperti ketidaknyamanan pada perut, sembelit, mual dan muntah (Obeagu & Uzoma, 2018).

7. Zink

Zink atau seng adalah komponen katalitik dari enzim serta bagian dari beberapa nukleotida, protein dan hormon. Mineral ini berperan penting dalam berbagai fungsi biokimia termasuk sintesis protein, metabolisme asam nukleat, pembelahan sel, ekspresi gen, penyembuhan luka, aktivitas antioksidan, fungsi neurologis dan sistem imun. Zink terdapat dalam makanan seperti daging, makanan laut, susu, dan kacang-kacangan. Kadar zink dalam tubuh dapat diketahui melalui pengukuran kadar zink plasma atau serum, serta ekskresi zink dalam urin 24 jam. Kadar nilai zink sangat bervariasi menurut usia, jenis kelamin, waktu, faktor fisiologi seperti stres atau infeksi.

Kekurangan zink pada kehamilan dapat mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan janin, berat badan lahir rendah (BBLR), cacat bawaan, dan kelahiran prematur. Kebutuhan zink pada wanita hamil sekitar 11 mg/hari. Selain dari tambahan suplemen, zink juga didapatkan dari konsumsi daging, beras merah, yogurt, keju, kuning telur dan oatmeal (Iqbal & Ali, 2021).

E. Nutrisi yang Mendukung Kehamilan Sehat

Masa kehamilan merupakan fase krusial dalam siklus kehidupan seorang wanita, Dimana ibu tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisinya sendiri, tetapi juga menyediakan nutrisi bagi janin yang dikandungnya. Selama kehamilan, seorang diperlukan tambahan kalori sekitar 400 kkal per hari, atau sekitar 15% lebih tinggi dari asupan biasanya. Total kebutuhan kalori ini, sekitar 40% dialokasikan untuk janin, sementara 60% digunakan oleh ibu. Oleh karena itu, ibu hamil perlu memperhatikan kualitas serta keseimbangan nutrisi dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi, bukan sekadar jumlahnya. Asupan nutrisi yang cukup dan seimbang akan mendukung kesehatan ibu dan juga perkembangan janin secara optimal. Jika kebutuhan gizi selama kehamilan tidak terpenuhi, ibu berisiko mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK), yang dapat berdampak buruk pada pertumbuhan janin, bahkan berpotensi menyebabkan kelainan atau kecacatan (Seymour et al., 2019).

Ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan, termasuk sumber protein hewani dan nabati. Mengingat keterbatasan kandungan zat gizi tertentu dalam pangan nabati, seperti asam amino esensial, sementara zat gizi ini sangat penting dibutuhkan bagi janin, maka ibu hamil dianjurkan untuk mencukupi asupan protein hewani. Protein hewani kaya akan zat besi, mengandung asam amino esensial yang lengkap, serta lebih mudah dicerna oleh tubuh, sehingga dapat mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin secara optimal. Anjuran jumlah makan dan minum yang direkomendasikan menurut kebutuhan energi untuk Ibu Hamil dibandingkan wanita usia subur yang dikonsumsi satu hari menurut Buku KIA, 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kecukupan Kebutuhan Energi untuk Ibu Hamil dibandingkan WUS untuk konsumsi dalam satu hari menurut Buku KIA, 2020)

PORSI MAKAN DAN MINUM IBU HAMIL UNTUK KEBUTUHAN SEHARI			
Bahan Makanan	Ibu Hamil trimester 1	Ibu Hamil Trimester 2 dan 3	Keterangan
Nasi atau Makanan Pokok	5 porsi 	6 porsi 	1 porsi = 100 gr atau 3/4 gelas nasi
Protein hewani seperti: Ikan, telur, ayam, dan lainnya	4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 50 gr atau 1 potong sedang ikan 1 porsi = 55 gr atau 1 butir telur Ayam
Protein nabati seperti: tempe, tahu, dan lainnya	4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 50 gr atau 1 potong sedang tempe 1 porsi = 100 gr atau 2 potong sedang tahu
Sayur-sayuran	4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 100 gr atau 1 mangkuk sayur matang tanpa kuah
Buah-buahan	4 porsi 	4 porsi 	1 porsi = 100 gr atau 1 potong sedang pisang 1 porsi = 100-190 gr atau 1 potong besar pepaya
Minyak/ lemak	5 porsi 	5 porsi 	1 porsi = 5 gr atau 1 sendok teh bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis, santan, kemiri, mentega dan sumber lemak lainnya
Gula	2 porsi 	2 porsi 	1 porsi = 10 gr atau 1 sendok makan bersumber dari kue-kue manis, minum teh manis dan lain-lainnya

Minum Air Putih: 8 - 12 gelas per hari
Catatan:
 Konsultasikan porsi makan kepada tenaga kesehatan, perhatikan indeks massa tubuh

F. Penutup

Kebutuhan nutrisi dalam menjaga kesehatan reproduksi selama kehamilan harus disesuaikan secara signifikan untuk mendukung kesehatan ibu serta pertumbuhan dan perkembangan janin. Kondisi fisiologis kehamilan yang unik menuntut asupan nutrisi yang mencakup makronutrien dan mikronutrien penting. Mikronutrien seperti zat besi, kalsium, magnesium, yodium, seng, asam folat, serta omega-3 berperan penting dalam perkembangan saraf janin, pertumbuhan optimal, dan kesehatan ibu secara keseluruhan.

Konseling gizi menjadi bagian penting dalam perawatan prenatal, karena membantu ibu hamil memahami kebutuhan nutrisi yang tepat. Program edukasi nutrisi telah terbukti memberikan manfaat signifikan terhadap penambahan berat badan selama kehamilan dan hasil kehamilan yang lebih baik. Oleh karena itu, integrasi konseling nutrisi dalam perawatan prenatal standar sangat diperlukan

Referensi

- Aji, A. S. (2016). Vitamin D pada Kehamilan. *Jurnal Arsip Gizi Dan Pangan*, 1(2), 73–90. https://doi.org/10.3920/9789086867653_035
- Alum, E. U., Obeagu, E. I., C, U. O. P., & Uti, D. (2023). Nutritional requirements during pregnancy: a comprehensive. *International Journal of Innovative and Applied Research*, 11(12), 26–34. <https://doi.org/10.58538/IJAR/2058>
- Aritonang, S. M., Doloksaribu, T. H., & Doloksaribu, L. G. (2024). *makronutrien , dan berat badan pasangan program bayi tabung*. 21(1), 32–41. <https://doi.org/10.22146/ijcn.89487>
- Biswas, S. (2021). Protein. In *Basic Food Chemistry* (Issue January, pp. 25–45). Ocean Publishing House.
- Calcaterra, V., Cena, H., Regalbuto, C., Vinci, F., Porri, D., Verduci, E., Chiara, M., & Zuccotti, G. V. (2021). The role of fetal, infant, and childhood nutrition in the timing of sexual maturation. *Nutrients*, 13(2), 1–15. <https://doi.org/10.3390/nu13020419>
- Calcaterra, V., Verduci, E., Stagi, S., & Zuccotti, G. (2024). How the intricate relationship between nutrition and hormonal equilibrium significantly influences endocrine and reproductive health in adolescent girls. *Frontiers in Nutrition*, 11(8), 8–11. <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1337328>
- Carazo, A., Macáková, K., Matoušová, K., Krčmová, L. K., Protti, M., & Mladěnka, P. (2021). Vitamin a update: Forms, sources, kinetics, detection, function, deficiency, therapeutic use and toxicity. *Nutrients*, 13(5), 1–36. <https://doi.org/10.3390/nu13051703>
- Chandana, S. C., & Kumar Maurya, N. (2020). Nutritional influences on hormonal homeostasis: Exploring mechanisms and implications. *International Journal of Food Science and Nutrition*, 9(2), 1–5. <https://www.researchgate.net/publication/380362086>
- Che, L., Yang, Z. G., Xu, M. M., Xu, S. Y., Che, L. Q., Lin, Y., Fang, Z. F., Feng, B., Li, J., Chen, D. W., & Wu, D. (2017). Maternal nutrition modulates fetal development by inducing placental efficiency changes in gilts. *BMC Genomics*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12864-017-3601-1>
- Chiu, Y. H., Chavarro, J. E., & Souter, I. (2018). Diet and female fertility: doctor, what should I eat? *Fertility and Sterility*, 110(4), 560–569. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2018.05.027>
- Cormick, G., & Belizán, J. M. (2019). Calcium intake and health. *Nutrients*, 11(7), 1–16. <https://doi.org/10.3390/nu11071606>

- Deputy, N. P., Sharma, A. J., & Kim, S. Y. (2016). Gestational Weight Gain — United States, 2012 and 2013. *HHS Public Access*, 64(43), 1215–1220. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6443a3.Gestational>
- Dewantari, N. M. (2013). Peranan gizi dalam kesehatan reproduksi. *Jurnal Skala Husada*, 10(2), 219–224. <http://www.poltekkes-denpasar.ac.id/files/JSH/JSHV10N2.pdf#page=84>
- Dominguez, L. J., Farruggia, M., Veronese, N., & Barbagallo, M. (2021). Vitamin d sources, metabolism, and deficiency: Available compounds and guidelines for its treatment. *Metabolites*, 11(4), 1–33. <https://doi.org/10.3390/metabo11040255>
- Gangakhedkar, G. R., & Kulkarni, A. P. (2021). Physiological Changes in Pregnancy. *Indian Journal of Critical Care Medicine*, 25(S3), S189–S192. <https://doi.org/10.5005/jp-journals-10071-24039>
- Gaskins, A. J., & Chavarro, J. E. (2018). Diet and Fertility: A Review. *Physiology & Behavior*, 218(4), 379–389. <https://doi.org/10.1177/0022146515594631.Marriage>
- Gustirini, R. (2019). Suplementasi Kalsium Pada Ibu Hamil Untuk Mengurangi Insidensi Preeklampsia Di Negara Berkembang. *Jurnal Kebidanan*, 8(2), 151–160. <https://doi.org/10.26714/jk.8.2.2019.151-160>
- Ho, A., Flynn, A. C., & Pasupathy, D. (2016). Nutrition in pregnancy. *Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine*, 26(9), 259–264. <https://doi.org/10.1016/j.ogrm.2016.06.005>
- Hou, Y., & Wu, G. (2018). Nutritionally essential amino acids. *Advances in Nutrition*, 9(6), 849–851. <https://doi.org/10.1093/ADVANCES/NMY054>
- Iqbal, S., & Ali, I. (2021). Effect of maternal zinc supplementation or zinc status on pregnancy complications and perinatal outcomes: An umbrella review of meta-analyses. *Heliyon*, 7(7), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07540>
- Irani, M., & Merhi, Z. (2014). Role of vitamin D in ovarian physiology and its implication in reproduction: A systematic review. *Fertility and Sterility*, 102(2), 460–468. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.04.046>
- Lipinwati. (2019). Perbandingan Efek Pemberian Bioinsektisida dan Eks. *Jambi Medical Journal*, 7(2), 179–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jmj.v7i2.8021>
- Ma, X., Wu, L., Wang, Y., Han, S., El-Dalatony, M. M., Feng, F., Tao, Z., Yu, L., & Wang, Y. (2022). Diet and human reproductive system: Insight of omics approaches. *Food Science and Nutrition*, 10(5), 1368–1384. <https://doi.org/10.1002/fsn3.2708>
- Martínez-Galiano, J. M., Cano-Ibáñez, N., Hernández-Martínez, A., & Delgado-Rodríguez, M. (2020). Nutrition in Reproductive Health: Nutritional Conditioning Factors during Pregnancy and Its Impact on Health. *Reproductive Medicine*, 1(3),

169–180. <https://doi.org/10.3390/reprodmed1030013>

- Mirza, M. M., Sunarti, S., & Handayani, L. (2023). Pengaruh Status Gizi Ibu Hamil terhadap Kejadian Stunting: Studi Literatur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(2), 22. <https://doi.org/10.26714/jkmi.18.2.2023.22-27>
- Montagnoli, C., Santoro, C. B., Buzzi, T., & Bortolus, R. (2022). Maternal periconceptional nutrition matters. A scoping review of the current literature. *Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine*, 35(25), 8123–8140. <https://doi.org/10.1080/14767058.2021.1962843>
- Mousa, A., Naqash, A., & Lim, S. (2019). Macronutrient and micronutrient intake during pregnancy: An overview of recent evidence. *Nutrients*, 11(2), 1–20. <https://doi.org/10.3390/nu11020443>
- Nisa, S., & Handayani, T. (2019). Konsumsi Suplemen Asam Folat oleh Ibu Hamil di Puskesmas Naras Tahun 2017. *Jurnal Endurance*, 4(3), 570–577. <https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.3215>
- Obeagu, E. I., & Uzoma, O. G. (2018). An update on Anaemia, Iron, Folic acid and Vitamin B 12 in Pregnancy and Postpartum. *International Journal of Current Research in Medical Sciences*, 4(5), 62–70. <http://dx.doi.org/10.22192/ijcrms.2018.04.05.010>
- Patel, P., & Balanchivadze, N. (2021). Hematologic Findings in Pregnancy: A Guide for the Internist. *Cureus*, 13(5), 1–8. <https://doi.org/10.7759/cureus.15149>
- Permatasari, T. A. E., Rizqiya, F., Kusumaningati, W., Suryaalsah, I. I., & Hermiwahyoeni, Z. (2021). The effect of nutrition and reproductive health education of pregnant women in Indonesia using quasi experimental study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03676-x>
- Pibriyanti, K., Nufus, N. T., & Luthfiya, L. (2021). of Menstruation , and Physical Activities With the Incident of Anemia in. *Journal Of Nutrition College*, 10, 112–119. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnc/>
- Pratiwi, I. G., & Hamidiyanti, Y. F. (2020). Gizi dalam Kehamilan : Studi Literatur. *Jurnal Gizi Prima (Prime Nutrition Journal)*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.32807/jgp.v5i1.171>
- Roberto, C. (2024). Endocrine Physiology: Hormonal Regulation and Metabolism. *International Journal of Anatomical Variations*, 17(7), 621–622. [https://doi.org/10.37532/1308-4038.17\(7\).418](https://doi.org/10.37532/1308-4038.17(7).418)
- Seymour, J. V. de, Beck, K. L., & Conlon, C. A. (2019). Nutrition in pregnancy. *Obstetric Gynecology and Reproductive Medicine*, 29(8), 219–224.

- Sharma, R., Biedenharn, K. R., Fedor, J. M., & Agarwal, A. (2013). Lifestyle factors and reproductive health: Taking control of your fertility. *Reproductive Biology and Endocrinology*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/1477-7827-11-66>
- Stephen, G., Mgongo, M., Hussein Hashim, T., Katanga, J., Stray-Pedersen, B., & Msuya, S. E. (2018). Anaemia in Pregnancy: Prevalence, Risk Factors, and Adverse Perinatal Outcomes in Northern Tanzania. *Anemia*, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/1846280>
- Trop-Steinberg, S., Gal, M., Azar, Y., Kilav-Levin, R., & Heifetz, E. M. (2024). Effect of omega-3 supplements or diets on fertility in women: A meta-analysis. *Heliyon*, 10(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29324>
- Wang, S., Shi, M., Zhou, L., Huang, H., & Mo, S. (2023). Correlation of vitamin E level during pregnancy with maternal and neonatal health outcomes: a meta-analysis and systematic review. *American Journal of Translational Research*, 15(6), 3838. [/pmc/articles/PMC10331675/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10331675/)[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10331675/](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10331675/?report=abstract)
- Willemse, J. P. M. M., Meertens, L. J. E., Scheepers, H. C. J., Achten, N. M. J., Eussen, S. J., van Dongen, M. C., & Smits, L. J. M. (2020). Calcium intake from diet and supplement use during early pregnancy: the Expect study I. *European Journal of Nutrition*, 59(1), 167–174. <https://doi.org/10.1007/s00394-019-01896-8>
- Youness, R. A., Dawoud, A., ElTahtawy, O., & Farag, M. A. (2022). Fat-soluble vitamins: updated review of their role and orchestration in human nutrition throughout life cycle with sex differences. *Nutrition and Metabolism*, 19(1), 1–21. <https://doi.org/10.1186/s12986-022-00696-y>
- Yuandry, S., Dewi, R. C., & Atifah, Y. (2023). Literatur Review: Pengaruh Konsumsi Asam Folat Bagi Ibu Hamil Terhadap Kelahiran Anak Dengan Kelainan Kongenital. *Prosiding Seminar Nasional BIO*, 1051–1062. <https://semnas.biologi.fmipa.unp.ac.id/index.php/prosiding/article/view/675>

Glosarium

A

AKG : Angka Kecukupan Gizi

B

BBB: adalah

C

CCC: adalah

D

DHA : *Docosahexaenoic Acid*

DNA : *Deoksiribonukleat Acid*

E

EPA : *Eicosapentaenoic Acid*

F

FAO : *Agriculture Organization*

H

Hb : Hemoglobin

hCG : *Human Chorionic Gonadotropin*

K

KEK : Kurang Energi Kronis

KIA : Kesehatan Ibu dan Anak

P

PCOS : *Polycystic ovary syndrome*

T

TFA : *Trans Fat Acid*

W

WHO : *World Health Organization*

WUS : Wanita Usia Subur

BAB IV

STRATEGIS KOMUNITAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN KESEHATAN REPRODUKSI

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, yang mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan individu, khususnya bagi perempuan dan laki-laki dalam rentang usia produktif. Kesehatan reproduksi mencakup berbagai masalah yang berkaitan dengan sistem reproduksi, seperti penyakit menular seksual, gangguan kesuburan, serta pemahaman tentang hak-hak reproduksi, dan lainnya. Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan reproduksi, tantangan besar masih dihadapi oleh masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kesadaran yang rendah. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini adalah melalui pendekatan berbasis komunitas. Pendekatan berbasis komunitas atau yang lebih dikenal dengan istilah "strategis komunitas" merupakan suatu upaya yang melibatkan anggota masyarakat dalam memecahkan masalah bersama. Dalam konteks kesehatan reproduksi, strategi ini dapat memberikan dampak yang signifikan, karena komunitas sebagai unit sosial memiliki peran yang besar dalam membentuk perilaku individu dan mengubah norma sosial yang ada. Komunitas yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran serta memperbaiki pola hidup masyarakat dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka.

Di Indonesia, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam upaya peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi. Beberapa di antaranya termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan informasi kesehatan, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, serta adanya tabu sosial yang membatasi pembicaraan tentang topik-topik sensitif seperti kesehatan reproduksi, seksualitas, dan kontrasepsi. Selain itu, masih banyak anggapan yang menganggap masalah kesehatan reproduksi sebagai hal yang hanya berkaitan dengan perempuan saja, padahal hak dan kewajiban menjaga kesehatan reproduksi merupakan hal yang sama pentingnya bagi laki-laki. Oleh karena itu, strategi berbasis komunitas menjadi sangat relevan, karena komunitas dapat mengatasi masalah ini dengan cara yang lebih partisipatif dan lebih sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pentingnya peran komunitas dalam meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi didukung

oleh banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku dan pemahaman kesehatan reproduksi dapat terjadi lebih efektif jika dilakukan dalam konteks sosial yang melibatkan interaksi antar individu. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam komunitas adalah pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang hak-hak reproduksi, penyuluhan tentang penyakit menular seksual, penggunaan alat kontrasepsi yang tepat, serta pendidikan mengenai kehamilan yang sehat dan kelahiran yang aman. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk individu, tetapi juga dapat memperbaiki kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, dalam mengimplementasikan strategi komunitas ini, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti pendekatan yang berbasis pada konteks budaya dan sosial yang ada di masyarakat. Misalnya, program-program yang dilakukan di masyarakat urban dengan masyarakat pedesaan mungkin akan berbeda pendekatannya. Di daerah perkotaan, akses terhadap informasi dan layanan kesehatan lebih mudah, tetapi di daerah pedesaan seringkali masih ada hambatan sosial yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, seperti masalah bahasa, ketidaktahuan, serta pandangan konservatif terhadap isu-isu kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal, serta melibatkan berbagai pihak dalam komunitas, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi juga dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang melibatkan anggota komunitas dalam kegiatan-kegiatan yang memberikan informasi dan keterampilan praktis tentang kesehatan reproduksi. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh tenaga medis, konselor kesehatan, atau oleh anggota komunitas yang sudah teredukasi, sehingga informasi yang diberikan tidak hanya bersifat teori tetapi juga aplikatif. Misalnya, mengajarkan cara melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara mandiri atau memberikan informasi mengenai tanda-tanda penyakit menular seksual yang perlu diwaspadai. Selain itu, program pendidikan dalam komunitas juga harus melibatkan pasangan laki-laki dan perempuan, agar kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi tidak hanya dipahami oleh satu pihak saja, melainkan dapat dibagi bersama sebagai tanggung jawab bersama dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk melakukan pendekatan yang melibatkan media massa, baik media tradisional seperti radio dan televisi, maupun media sosial, yang kini semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Penyuluhan melalui media massa ini dapat menjangkau lebih banyak orang, bahkan mereka yang berada di daerah-daerah terpencil sekalipun. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dan media dalam strategi komunitas sangat

penting untuk mengoptimalkan penyebaran informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

B. Definisi Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu komponen penting dari kesehatan secara keseluruhan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan definisi yang jelas dan komprehensif mengenai kesehatan reproduksi, yang menggarisbawahi pentingnya keseimbangan fisik, mental, dan sosial dalam menjaga sistem reproduksi yang sehat. Definisi ini mencakup lebih dari sekedar bebas dari penyakit, tetapi juga menekankan pada hak setiap individu untuk memiliki kontrol penuh atas aspek-aspek yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi mereka.

1. Pengertian Kesehatan Reproduksi Menurut WHO

Menurut WHO, kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai "keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang sepenuhnya baik dalam semua hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan proses-prosesnya." Ini berarti bahwa kesehatan reproduksi tidak hanya tentang bebas dari penyakit atau gangguan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menjalani kehidupan reproduksi secara sehat dan bertanggung jawab, yang mencakup proses-proses fisiologis dan emosional yang terjadi sepanjang siklus hidup individu. WHO lebih lanjut menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi yang baik melibatkan hak setiap individu untuk memiliki kehidupan seks yang aman dan menyenangkan, tidak mengalami diskriminasi, serta memiliki akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Hal ini juga mencakup hak untuk memiliki atau menunda kehamilan, serta hak untuk mengakses pendidikan yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat terkait dengan reproduksi dan kesehatan seksual.

2. Aspek-Aspek Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi melibatkan tiga aspek utama yang saling terkait, yaitu fisik, mental, dan sosial. Ketiga aspek ini membentuk dasar dari pendekatan komprehensif dalam menjaga kesehatan reproduksi yang optimal, yang penting dipahami agar masyarakat dapat menjaga kesejahteraan reproduksinya.

- a. Aspek Fisik Aspek fisik dalam kesehatan reproduksi mencakup keadaan fisik yang baik terkait dengan organ-organ reproduksi dan fungsi-fungsinya. Ini termasuk: Kesehatan organ reproduksi: Pemeliharaan kesehatan sistem reproduksi (seperti rahim, ovarium, penis, dan testis) agar berfungsi dengan baik tanpa adanya penyakit atau gangguan. Penyakit menular seksual (PMS): Pencegahan dan pengobatan terhadap PMS yang dapat memengaruhi fungsi reproduksi dan kesehatan secara keseluruhan. Kesehatan kehamilan

dan persalinan: Menjamin bahwa proses kehamilan, kelahiran, dan pasca-persalinan dilakukan dengan aman dan sehat, serta mengurangi risiko komplikasi seperti preeklamsia, kelahiran prematur, atau infeksi. Penggunaan alat kontrasepsi: Akses terhadap metode kontrasepsi yang aman dan efektif untuk memungkinkan perencanaan keluarga yang sehat dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan.

- b. Aspek Mental Kesehatan reproduksi juga melibatkan aspek mental, yang berfokus pada kondisi emosional dan psikologis individu terkait dengan isu-isu seksual dan reproduksi. Ini mencakup: Kesejahteraan emosional: Kemampuan untuk mengelola perasaan dan emosi yang muncul dalam konteks hubungan seksual dan reproduksi, serta kemampuan untuk menikmati kehidupan seksual yang sehat dan bebas dari tekanan atau kekerasan. Penyuluhan dan pendidikan seksual: Pentingnya mendapatkan informasi yang benar dan edukasi terkait dengan kesehatan seksual, yang dapat mengurangi kebingungan, kecemasan, dan ketidakpastian dalam membuat keputusan reproduktif yang sehat. Perlindungan terhadap kekerasan seksual: Mencegah dan mengatasi masalah terkait kekerasan seksual yang dapat memiliki dampak emosional jangka panjang bagi korban. Ini juga mencakup pemberian dukungan psikologis bagi mereka yang mengalami trauma akibat kekerasan seksual.
- c. Aspek Sosial Aspek sosial dari kesehatan reproduksi menekankan pentingnya konteks sosial, budaya, dan ekonomi dalam membentuk keputusan dan perilaku terkait dengan reproduksi. Ini mencakup: Akses terhadap layanan kesehatan: Memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, baik itu di tingkat lokal maupun nasional. Ini termasuk akses ke konseling, pemeriksaan medis, dan pengobatan. Norma dan nilai sosial: Pengaruh nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku terhadap kesehatan reproduksi, seperti pandangan tentang kontrasepsi, kehamilan, dan peran gender dalam keputusan reproduksi. Pemberdayaan perempuan dan hak-hak reproduksi: Memberikan perempuan kontrol penuh atas tubuh mereka sendiri dan keputusan reproduksi mereka, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dari diskriminasi atau kekerasan berbasis gender. Keseluruhan aspek ini – fisik, mental, dan sosial – membentuk landasan penting untuk menjaga

kesehatan reproduksi yang optimal. Sebagai bagian dari upaya global untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, kesehatan reproduksi yang baik adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang ketiga aspek ini akan memungkinkan kita untuk merancang program atau kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan reproduksi di berbagai komunitas

3. Pendekatan Komunitas dalam Kesehatan Reproduksi

Pendekatan komunitas merupakan strategi yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya perbaikan dan peningkatan kesadaran terhadap isu-isu kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Pendekatan ini mengakui bahwa perubahan perilaku yang efektif dan berkelanjutan dapat dicapai jika masyarakat diberdayakan untuk terlibat aktif dalam merancang dan melaksanakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka. Dalam konteks kesehatan reproduksi, pendekatan komunitas memberikan kesempatan bagi individu dan kelompok untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat, mengubah sikap, dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

a. Definisi dan Prinsip Strategis Komunitas

- 1) Definisi Komunitas dalam Kesehatan Reproduksi: Komunitas dalam konteks ini merujuk pada sekelompok orang yang tinggal dalam wilayah atau lingkungan yang sama dan memiliki kepentingan bersama terkait isu kesehatan reproduksi. Komunitas berperan sebagai unit sosial yang dapat memberikan dukungan, berbagi informasi, serta berkolaborasi untuk meningkatkan kesehatan reproduksi anggotanya.
- 2) Prinsip Strategis Komunitas: Prinsip-prinsip yang mendasari pendekatan komunitas dalam kesehatan reproduksi antara lain: Partisipasi aktif: Anggota komunitas diharapkan aktif dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Pendekatan berbasis kebutuhan lokal: Setiap komunitas memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan konteks lokal.

b. Keunggulan Strategis Komunitas dalam Kesehatan Reproduksi

Pendekatan berbasis komunitas memiliki sejumlah keunggulan strategis, antara lain:

- 1) Aksesibilitas: Komunitas sering kali lebih mudah diakses oleh individu yang mungkin tidak dapat atau tidak mau mengakses fasilitas kesehatan formal. Oleh karena itu, informasi dan layanan kesehatan reproduksi dapat lebih mudah diterima dan diterapkan.
- 2) Pemahaman Konteks Lokal: Komunitas lebih memahami kebutuhan, kebiasaan, dan tantangan lokal, sehingga solusi yang diberikan lebih relevan dan efektif.
- 3) Sumber Daya Lokal: Komunitas memiliki sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan promosi kesehatan, seperti tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan relawan.
- 4) Kemandirian: Komunitas yang diberdayakan dapat lebih mandiri dalam mengelola masalah kesehatan reproduksi mereka, tanpa terlalu bergantung pada pihak eksternal.
- 5) Sustainable atau Berkelanjutan: Dengan melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan, program kesehatan reproduksi cenderung lebih berkelanjutan karena masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberlanjutannya.

c. Peran Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Reproduksi

Komunitas memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang kesehatan reproduksi, di antaranya:

- 1) Edukasi dan Penyuluhan: Komunitas bisa menjadi agen perubahan yang efektif dalam memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi.
- 2) Penyuluhan dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan komunitas, kelompok diskusi, media lokal, atau kegiatan pendidikan lainnya.
- 3) Mendorong Perubahan Sosial: Komunitas dapat memengaruhi norma dan perilaku sosial yang terkait dengan kesehatan reproduksi, seperti menikah di usia muda atau praktik yang merugikan kesehatan reproduksi.
- 4) Peningkatan Akses ke Layanan Kesehatan: Komunitas dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk meningkatkan akses anggotanya pada layanan kesehatan reproduksi, seperti pemeriksaan kesehatan, kontrasepsi, atau layanan kesehatan ibu dan anak
- 5) **Dukungan Sosial:** Komunitas berperan penting dalam memberikan dukungan sosial kepada individu atau keluarga yang menghadapi masalah kesehatan reproduksi, seperti ketidaksuburan atau masalah kehamilan.

- 6) **Advokasi:** Komunitas dapat mengadvokasi perubahan kebijakan atau peningkatan alokasi sumber daya untuk kesehatan reproduksi di tingkat lokal atau nasional.

d. Strategi untuk Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Reproduksi melalui Komunitas

1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Pendidikan kesehatan reproduksi adalah komponen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terutama di negara berkembang, banyak tantangan yang dihadapi dalam mengakses informasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi, baik di kalangan remaja, perempuan, maupun laki-laki. Salah satu pendekatan yang efektif dalam menyebarkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam segala aspek pendidikan kesehatan reproduksi, dengan mengandalkan peran mereka sebagai agen perubahan. Buku ini membahas bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan kesehatan reproduksi dapat diimplementasikan, serta menguraikan berbagai metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dengan fokus pada pelatihan komunitas, penggunaan peer education, dan pemberdayaan perempuan serta laki-laki.

2) Pelatihan Komunitas sebagai Agen Perubahan

Pelatihan komunitas merupakan metode yang efektif dalam mengubah paradigma masyarakat terhadap isu-isu kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Dalam konteks ini, komunitas lokal dilatih untuk menjadi agen perubahan yang dapat menyebarkan informasi kesehatan yang relevan kepada anggota komunitas lainnya.

- **Prinsip Pelatihan Komunitas**

Pelatihan komunitas tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas anggota komunitas dalam mengelola isu-isu kesehatan di tingkat lokal. Pelatihan ini melibatkan pendekatan yang partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam mendidik dan menyebarkan pengetahuan kepada orang lain.

- **Metode Pelatihan yang Efektif**

Pelatihan untuk komunitas dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti workshop, diskusi kelompok, atau seminar. Selain itu, pelatihan berbasis praktik—misalnya, simulasi atau role play—dapat membantu peserta lebih memahami situasi nyata yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendampingi teman atau keluarga yang menghadapi masalah kesehatan reproduksi.

- **Dampak Pelatihan Komunitas dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi**

Pelatihan komunitas dapat mempengaruhi perubahan perilaku dalam hal pengelolaan kesehatan reproduksi. Sebagai agen perubahan, individu yang terlatih dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan terpercaya, serta mengurangi stigma atau kesalahan persepsi tentang topik-topik kesehatan reproduksi seperti alat kontrasepsi, kehamilan, atau penyakit menular seksual.

3) Penggunaan Peer Education dalam Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

Peer education atau pendidikan sebaya adalah strategi yang melibatkan individu dari kelompok usia atau latar belakang yang sama untuk menyebarkan informasi kepada teman sebaya mereka. Dalam konteks kesehatan reproduksi, peer education menjadi metode yang efektif untuk menjangkau kelompok remaja atau dewasa muda, yang mungkin merasa lebih nyaman berdiskusi dengan teman sebaya mereka daripada orang dewasa atau profesional medis.

- **Prinsip Peer Education dalam Kesehatan Reproduksi**

Peer education berfokus pada pembelajaran yang bersifat non-formal dan berbasis komunikasi antar teman sebaya. Dengan menggunakan bahasa yang lebih akrab dan relevan dengan pengalaman sehari-hari, peer educators mampu menjelaskan topik-topik kesehatan reproduksi dengan cara yang mudah dipahami. Pendekatan ini juga mengurangi hambatan komunikasi yang sering terjadi antara generasi muda dan orang dewasa mengenai masalah yang terkait dengan kesehatan reproduksi.

- **Pengembangan Peer Educators**

Untuk memastikan efektivitas pendidikan sebaya, penting untuk melatih peer educators secara menyeluruh. Mereka tidak hanya diberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tetapi juga keterampilan komunikasi dan strategi untuk menghadapi

pertanyaan atau masalah sensitif yang mungkin muncul dalam percakapan mereka dengan teman sebaya.

- **Dampak Penggunaan Peer Education dalam Penyuluhan**

Penyuluhan melalui peer education telah terbukti efektif dalam mengurangi perilaku berisiko di kalangan remaja dan dewasa muda. Misalnya, program pendidikan sebaya tentang penggunaan kontrasepsi atau pencegahan penyakit menular seksual dapat membantu mengurangi angka kehamilan remaja dan penularan HIV/AIDS di kalangan remaja.

4) Pemberdayaan Perempuan dan Laki-laki dalam Pengelolaan Kesehatan Reproduksi

Pemberdayaan perempuan dan laki-laki dalam mengelola kesehatan reproduksi adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan setara. Meskipun perempuan sering menjadi fokus utama dalam pendidikan kesehatan reproduksi, peran laki-laki juga sangat krusial. Keberhasilan program kesehatan reproduksi tidak hanya bergantung pada pengetahuan dan sikap perempuan, tetapi juga pada pemahaman dan partisipasi aktif laki-laki dalam mendukung kesehatan reproduksi.

- **Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan kesehatan reproduksi dapat dilakukan dengan memberi mereka pengetahuan tentang hak-hak kesehatan mereka, serta menyediakan akses ke layanan kesehatan yang memadai. Pendidikan kesehatan reproduksi yang inklusif, yang mengakui pentingnya kontrol perempuan terhadap tubuh mereka, dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan gender.

- **Pemberdayaan Laki-laki**

Sama halnya dengan perempuan, laki-laki juga perlu diberi pendidikan yang memadai mengenai kesehatan reproduksi. Pemberdayaan laki-laki dalam pengelolaan kesehatan reproduksi tidak hanya membantu mereka memahami pentingnya peran mereka dalam keputusan-keputusan terkait kesehatan keluarga, tetapi juga dalam pencegahan masalah seperti kehamilan yang tidak direncanakan dan penyebaran penyakit menular seksual.

- **Kolaborasi antara Perempuan dan Laki-laki**

Kolaborasi antara perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan kesehatan reproduksi sangat penting untuk menciptakan perubahan

sosial yang berkelanjutan. Misalnya, program-program yang melibatkan laki-laki dalam mendukung keputusan kesehatan reproduksi pasangan mereka, seperti penggunaan kontrasepsi bersama atau keputusan untuk melakukan tes HIV, dapat meningkatkan efektivitas program tersebut.

C. Membangun Kerja Sama Antar-Sektor

1. Peran Sektor Kesehatan dalam Mendukung Komunitas

Sektor kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung komunitas, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa peran utama sektor kesehatan dalam mendukung komunitas adalah:

- a. **Peningkatan Akses Kesehatan:** Sektor kesehatan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Ini termasuk rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), dan tenaga medis yang terlatih.
- b. **Pencegahan Penyakit:** Melalui program-program pencegahan, seperti imunisasi, kampanye kesehatan, dan deteksi dini, sektor kesehatan dapat membantu mengurangi angka kejadian penyakit menular dan tidak menular di komunitas.
- c. **Penyuluhan Kesehatan:** Sektor kesehatan juga memiliki peran dalam menyebarkan informasi yang relevan mengenai gaya hidup sehat, pola makan, olahraga, dan pencegahan penyakit, yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan.
- d. **Kesehatan Reproduksi:** Melibatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang mendukung kesehatan reproduksi masyarakat, termasuk perawatan ibu hamil, persalinan yang aman, serta pemberdayaan dalam perencanaan keluarga.

2. Kerja Sama dengan Sektor Pendidikan, Agama, dan Pemerintah

Membangun kerja sama antar-sektor sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah pentingnya kerja sama dengan sektor pendidikan, agama, dan pemerintah dalam mendukung sektor kesehatan:

a. Kerja Sama dengan Sektor Pendidikan:

- 1) **Pendidikan Kesehatan:** Sektor pendidikan berperan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kesehatan kepada generasi muda, yang bisa dimulai dari pendidikan dasar hingga

pendidikan tinggi. Melalui kurikulum yang mengintegrasikan pelajaran kesehatan, generasi muda bisa lebih sadar akan pentingnya kesehatan.

- 2) **Kolaborasi Penelitian:** Sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi, bisa bekerja sama dengan sektor kesehatan untuk melakukan penelitian yang berfokus pada masalah kesehatan yang ada di masyarakat, seperti penyakit endemik atau masalah kesehatan mental.

b. Kerja Sama dengan Sektor Agama:

- 1) **Penyuluhan Kesehatan melalui Pengajaran Agama:** Lembaga agama dapat digunakan sebagai saluran untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada umat. Misalnya, khutbah Jumat, ceramah agama, atau kelas-kelas agama yang menyertakan pesan-pesan kesehatan yang relevan dengan ajaran agama.
- 2) **Penguatan Peran Agama dalam Kesehatan Mental:** Agama memiliki pengaruh yang besar dalam membantu individu mengatasi masalah kesehatan mental. Kerja sama dengan sektor agama dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesejahteraan mental dan dukungan sosial dalam menjaga kesehatan.

c. Kerja Sama dengan Pemerintah:

- 1) **Kebijakan Kesehatan:** Pemerintah memainkan peran utama dalam penyusunan kebijakan kesehatan, pengalokasian anggaran untuk sektor kesehatan, serta penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah juga berperan dalam mengatur regulasi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.
- 2) **Program Kesehatan Nasional:** Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor lain, termasuk pendidikan dan agama, untuk melaksanakan program kesehatan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, seperti program imunisasi, gizi seimbang, dan sanitasi.

3. Mengintegrasikan Kebijakan Kesehatan Reproduksi dalam Program Pembangunan Lokal

Kebijakan kesehatan reproduksi sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, integrasi kebijakan ini dalam program pembangunan lokal akan membawa dampak positif yang besar. Berikut adalah cara untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan reproduksi dalam program pembangunan lokal:

a. Penyusunan Kebijakan Lokal yang Mendukung Kesehatan Reproduksi:

Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan yang mendukung aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan reproduksi, seperti pelayanan

KB (Keluarga Berencana), perawatan ibu hamil, dan pendidikan seksual yang sehat bagi remaja.

b. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan:

Pemerintah daerah bersama sektor kesehatan dapat menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga medis lokal agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas.

c. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Komunitas:

Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatan reproduksi sangat penting. Masyarakat perlu diajak untuk berpartisipasi aktif dalam merencanakan dan melaksanakan program kesehatan reproduksi, baik melalui forum-forum diskusi komunitas maupun kegiatan edukasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi perempuan dan tokoh agama.

d. Kolaborasi dengan Sektor Pendidikan:

Program pendidikan seksualitas yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan agama harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kesehatan reproduksi, serta mengurangi angka kehamilan remaja dan risiko penyakit menular seksual.

e. Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Reproduksi:

Setiap program pembangunan lokal yang melibatkan kesehatan reproduksi perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini dilakukan untuk menilai dampaknya terhadap masyarakat dan membuat penyesuaian jika diperlukan.

D. Menggunakan Media Massa dan Teknologi dalam Penyuluhan

Pemanfaatan media massa dan teknologi dalam penyuluhan kesehatan memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Media sosial, radio, televisi, dan film adalah beberapa alat yang dapat digunakan untuk penyuluhan yang efektif.

1. Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Kesadaran Kesehatan Reproduksi

Media sosial merupakan salah satu platform yang paling efektif dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Dengan adanya media sosial, kampanye kesadaran tentang kesehatan reproduksi dapat dijalankan dengan biaya yang relatif rendah dan dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat,

terutama generasi muda yang lebih aktif menggunakan platform ini. Berikut adalah cara-cara pemanfaatan media sosial:

- a. Penyuluhan melalui Konten Visual: Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan penyuluhan disampaikan melalui konten visual, seperti infografis, gambar, video, dan cerita singkat. Konten visual ini dapat lebih menarik dan mudah dipahami oleh audiens dari berbagai latar belakang, terutama untuk menjelaskan topik kesehatan reproduksi yang kompleks.
- b. Kolaborasi dengan Influencer dan Public Figure: Mengajak influencer atau tokoh publik untuk ikut serta dalam kampanye kesadaran kesehatan reproduksi dapat memperluas jangkauan pesan yang disampaikan. Mereka memiliki audiens yang besar dan dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran tentang isu ini.
- c. Diskusi dan Interaksi Langsung dengan Audiens: Melalui fitur-fitur live streaming, komentar, dan pesan langsung, media sosial memungkinkan interaksi langsung dengan audiens. Kampanye dapat dilengkapi dengan sesi tanya jawab atau diskusi mengenai topik-topik terkait kesehatan reproduksi, sehingga masyarakat bisa lebih aktif terlibat dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam.
- d. Hashtag Campaigns: Penggunaan hashtag yang relevan, seperti #KesehatanReproduksi atau #PendidikanSeksual, bisa meningkatkan visibilitas kampanye di platform media sosial. Dengan menggunakan hashtag yang tepat, pesan dapat lebih mudah ditemukan dan diikuti oleh orang-orang yang tertarik dengan topik tersebut.
- e. Platform Spesifik: Setiap platform media sosial memiliki karakteristik audiens dan jenis konten yang lebih populer. Misalnya, Twitter lebih cocok untuk berbagi informasi singkat atau opini, Instagram untuk visual dan cerita, serta TikTok untuk video edukasi yang menyenangkan. Menyesuaikan format konten dengan platform akan meningkatkan efektivitas kampanye.

Pemanfaatan media massa dan teknologi dalam penyuluhan kesehatan memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Media sosial, radio, televisi, dan film adalah beberapa alat yang dapat digunakan untuk penyuluhan yang efektif.

2. Penggunaan Radio, Televisi, dan Film untuk Mencapai Audiens yang Lebih Luas

Selain media sosial, radio, televisi, dan film masih merupakan alat penyuluhan yang sangat efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Berikut adalah cara penggunaan media massa ini dalam kampanye kesehatan reproduksi:

a. Radio:

Penyuluhan dengan Program Khusus: Program kesehatan di radio dapat mencakup diskusi tentang topik-topik kesehatan reproduksi yang relevan, seperti perencanaan keluarga, pencegahan penyakit menular seksual, dan kesehatan ibu hamil. Radio juga bisa menayangkan wawancara dengan ahli kesehatan atau tokoh masyarakat yang berkompeten. Call-in Shows: Radio dapat menyediakan kesempatan bagi pendengar untuk menelepon dan bertanya langsung tentang isu kesehatan reproduksi. Ini bisa menciptakan interaksi yang lebih personal dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi langsung. Jingle dan Iklan Radio: Iklan atau jingle yang menarik tentang kesehatan reproduksi dapat disebarluaskan melalui berbagai stasiun radio, terutama di jam-jam sibuk. Iklan ini harus singkat, padat, dan mudah diingat untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

b. Televisi:

Program Edukasi dan Talkshow: Televisi memiliki audiens yang sangat luas, dan program edukasi di stasiun televisi dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi. Talkshow dengan tema kesehatan reproduksi, yang melibatkan dokter, tokoh masyarakat, atau selebritas, bisa menarik perhatian banyak orang. Iklan Layanan Masyarakat: Pemerintah atau lembaga kesehatan dapat menayangkan iklan layanan masyarakat yang berisi pesan-pesan penting terkait kesehatan reproduksi. Misalnya, iklan tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin atau pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Drama atau Serial TV dengan Tema Kesehatan: Drama atau serial televisi yang mengangkat tema kesehatan reproduksi dapat membantu membuka wawasan masyarakat, terutama dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Cerita yang menggambarkan kisah kehidupan nyata dapat membantu audiens merasa lebih dekat dan memahami isu tersebut dengan lebih baik.

c. Film:

Film Dokumenter: Film dokumenter yang mengangkat isu kesehatan reproduksi, seperti perencanaan keluarga, perawatan ibu hamil, dan dampak dari kurangnya pendidikan seksualitas, dapat menjadi alat penyuluhan yang kuat. Film ini dapat diputar di berbagai platform, baik televisi, bioskop, maupun streaming online. Penyuluhan melalui Film Fiksi:

Film fiksi yang mengangkat tema kesehatan reproduksi dengan cara yang menghibur dan menyentuh perasaan dapat mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku audiens. Karakter-karakter yang relatable dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu seperti pernikahan usia dini, kesehatan mental, dan kesehatan seksual. Festival Film atau Diskusi Pasca-Tayang: Film-film yang berfokus pada kesehatan reproduksi bisa diputar dalam festival film atau acara diskusi yang melibatkan audiens untuk berdiskusi tentang tema film tersebut. Ini membuka kesempatan untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada audiens dan menjawab pertanyaan yang muncul

E. Penyuluhan dan Edukasi Berbasis Kasus di Komunitas

Penyuluhan dan edukasi berbasis kasus di komunitas merupakan metode yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kesehatan atau topik lainnya. Pendekatan berbasis kasus memungkinkan individu atau kelompok dalam komunitas untuk mengaitkan teori dengan pengalaman nyata, serta memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan belajar bersama. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan studi kasus dan pengalaman nyata dalam penyuluhan, serta pelaksanaan workshop dan diskusi kelompok dalam komunitas.

1. Menggunakan Studi Kasus dan Pengalaman Nyata dalam Penyuluhan Studi kasus dan pengalaman nyata adalah metode yang efektif dalam penyuluhan karena pendekatan ini membuat topik lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah cara-cara penggunaan studi kasus dan pengalaman nyata dalam penyuluhan:

- a. Mengenalkan Studi Kasus Terkait Isu Terkini: Penggunaan studi kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang relevan, seperti masalah kesehatan reproduksi, gizi, atau kebiasaan hidup sehat, dapat membuat peserta penyuluhan lebih paham dan terlibat. Misalnya, mengangkat kasus tentang seseorang yang mengalami masalah kesehatan akibat pola hidup yang tidak sehat atau mengangkat kasus kehamilan remaja sebagai contoh studi kasus.
- b. Pembahasan Masalah Nyata: Dalam penyuluhan, membahas masalah nyata yang dihadapi oleh komunitas dapat meningkatkan pemahaman. Misalnya, menyampaikan pengalaman seseorang yang berhasil mengatasi masalah kesehatan melalui pola makan sehat atau berolahraga. Pengalaman-

pengalaman ini dapat memberikan motivasi dan solusi yang praktis untuk masalah yang dihadapi oleh audiens.

- c. Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari: Dengan menggunakan studi kasus, peserta dapat mempelajari cara-cara yang sudah diterapkan dalam kasus nyata dan dapat langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Hal ini juga dapat membuka wawasan tentang bagaimana masalah yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan cara yang sudah terbukti efektif.
 - d. Stimulasi atau Role-Playing: Menggunakan role-playing atau simulasi berdasarkan studi kasus yang telah dibahas memungkinkan peserta untuk berperan langsung dalam situasi tersebut. Misalnya, dalam pendidikan seksual atau kesehatan reproduksi, peserta bisa bermain peran sebagai konselor atau pasien untuk memahami kedua sisi dalam situasi tersebut.
 - e. Analisis Kasus dan Solusi: Setelah menyajikan studi kasus, lakukan diskusi untuk menganalisis penyebab masalah, dampaknya, serta solusi yang bisa diterapkan. Hal ini akan membantu peserta untuk memahami lebih mendalam tentang bagaimana mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang tepat.
2. Pelaksanaan Workshop dan Diskusi Kelompok dalam Komunitas
- Workshop dan diskusi kelompok adalah metode penyuluhan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif dan kolaborasi di antara anggota komunitas. Kegiatan ini memungkinkan peserta untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan menemukan solusi bersama. Berikut adalah cara-cara pelaksanaan workshop dan diskusi kelompok dalam komunitas:
- a. Workshop Tematik: Mengadakan workshop dengan tema tertentu yang relevan dengan kebutuhan komunitas. Misalnya, workshop tentang kesehatan mental, pencegahan penyakit menular seksual, atau parenting sehat. Workshop ini bisa melibatkan berbagai ahli atau praktisi di bidang terkait yang memberikan pengetahuan dan keterampilan langsung kepada peserta.
 - b. Pendekatan Praktis: Dalam workshop, penting untuk tidak hanya memberikan teori, tetapi juga mengajarkan keterampilan praktis yang bisa langsung diterapkan oleh peserta. Misalnya, dalam workshop kesehatan reproduksi, peserta dapat diajarkan cara memeriksa kesehatan diri atau cara melakukan self-care yang benar.
 - c. Diskusi Kelompok: Diskusi kelompok memberikan kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain. Dalam konteks kesehatan, misalnya, peserta dapat berbicara tentang kebiasaan hidup sehat

mereka atau tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga kesehatan, kemudian mencari solusi bersama. Ini juga bisa mengurangi rasa malu atau kekhawatiran untuk membicarakan masalah kesehatan pribadi.

- d. Pemecahan Masalah Kolaboratif: Selama diskusi kelompok, fasilitator bisa memberikan masalah nyata yang dihadapi oleh komunitas dan meminta peserta untuk bekerja sama dalam mencari solusi. Misalnya, mengatasi rendahnya kesadaran tentang penyakit menular seksual di komunitas, atau mencari cara untuk meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan untuk ibu hamil.
- e. Kelompok Belajar atau Kelompok Dukungan: Kelompok belajar atau kelompok dukungan bisa dibentuk untuk mengatasi masalah tertentu, seperti masalah kesehatan mental atau mengelola stres. Dalam kelompok ini, anggota dapat saling memberi dukungan, berbagi pengalaman, dan saling memberikan motivasi untuk menerapkan perilaku yang sehat.
- f. Evaluasi dan Refleksi: Setelah workshop atau diskusi, penting untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif kegiatan tersebut dalam meningkatkan pemahaman peserta. Refleksi dari peserta tentang apa yang telah dipelajari dan bagaimana mereka akan mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan sangat penting untuk memastikan penyuluhan dan edukasi berbasis kasus memberikan dampak yang positif.

Referensi

- Sari, R. P. (2022). Peran Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Reproduksi Remaja di Perkotaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(2), 112-125.
- Putri, L. & Rahayu, T. (2021). Strategi Penyuluhan Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Reproduksi di Kalangan Remaja. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(1), 45-60.
- Susanto, F. (2020). Pengaruh Program Intervensi Komunitas terhadap Kesadaran Kesehatan Reproduksi di Daerah Rawan Pernikahan Dini. *Jurnal Epidemiologi Indonesia*, 5(3), 78-91.
- Wahyuni, E. & Prasetyo, H. (2019). Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Komunitas sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Menular Seksual. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 14(4), 212-225.
- Fauziah, R. (2018). Efektivitas Program Kader Posyandu dalam Sosialisasi Kesehatan Reproduksi bagi Ibu Rumah Tangga. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 10(2), 98-110.
- Rahmawati, S. (2017). Analisis Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Reproduksi di Pedesaan. *Jurnal Sosial dan Kesehatan*, 9(3), 134-148.
- Yusuf, A. & Permana, D. (2016). Intervensi Berbasis Komunitas dalam Meningkatkan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja Putri. *Jurnal Kesehatan Remaja*, 7(1), 55-70.
- BKKBN. (2020). *Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Keluarga Berencana*. Jakarta: BKKBN.
- Departemen Kesehatan RI. (2019). *Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarwono, W. (2017). *Kesehatan Reproduksi untuk Remaja dan Dewasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2016). *Health Promotion Planning: An Educational and Ecological Approach*. New York: McGraw-Hill.
- Denny, G., & Young, M. (2015). *Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Global*. London: Oxford University Press.
- Hidayat, A. A. (2015). *Pengantar Ilmu Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Salemba Medika.

- Kottke, T. E., & Trapp, M. A. (2014). *Community-Based Interventions for Health Promotion*. New York: Routledge.
- Sari, R. P. (2022). Peran Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Reproduksi Remaja di Perkotaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(2), 112-125.
- Putri, L., & Rahayu, T. (2021). Strategi Penyuluhan Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Reproduksi di Kalangan Remaja. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(1), 45-60.
- Susanto, F. (2020). Pengaruh Program Intervensi Komunitas terhadap Kesadaran Kesehatan Reproduksi di Daerah Rawan Pernikahan Dini. *Jurnal Epidemiologi Indonesia*, 5(3), 78-91.
- Wahyuni, E., & Prasetyo, H. (2019). Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Komunitas sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Menular Seksual. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 14(4), 212-225.
- Fauziah, R. (2018). Efektivitas Program Kader Posyandu dalam Sosialisasi Kesehatan Reproduksi bagi Ibu Rumah Tangga. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 10(2), 98-110.
- MAYANTI, Andi, et al. BEHAVIORAL COUNSELING MODEL FOR IMPROVING HEMOGLOBIN LEVELS IN ADOLESCENT GIRLS WITH ANEMIA. *INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING AND MIDWIFERY SCIENCE (IJNMS)*, 2024, 8.3: 375-384.
- PATMAHWATI, Patmahwati, et al. KONSELING KB DENGAN MEMANFAATKAN AUDIO VISUAL PADA IBU HAMIL TM III TERHADAP MOTIVASI IBU MEMILIH (MKJP) PASCA PERSALINAN. *Jurnal JKFT*, 2023, 8.2: 43-49.
- Rahmawati, S. (2017). Analisis Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Kesadaran Kesehatan Reproduksi di Pedesaan. *Jurnal Sosial dan Kesehatan*, 9(3), 134-148.
- Yusuf, A., & Permana, D. (2016). Intervensi Berbasis Komunitas dalam Meningkatkan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja Putri. *Jurnal Kesehatan Remaja*, 7(1), 55-70.
- Umrah, Andi Sitti, and Israini Suriati. "Peningkatan Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Usia Subur." *Jurnal EMPATI (Edukasi Masyarakat, Pengabdian dan Bakti)* 3.3 (2022): 218-222.

Glosarium

Advokasi: Upaya mempengaruhi kebijakan atau keputusan melalui pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi.

Aspek Sosial: Faktor sosial yang memengaruhi perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi.

Berbasis Komunitas: Strategi atau pendekatan yang melibatkan komunitas dalam proses edukasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Capaian Kesehatan: Indikator keberhasilan suatu program kesehatan dalam meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat.

Cakupan Program: Luasnya jangkauan program kesehatan reproduksi di masyarakat.

Dukungan Sosial: Bantuan atau dorongan dari individu, kelompok, atau organisasi dalam meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi.

Edukasi Kesehatan: Proses pemberian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi.

Evaluasi Program: Penilaian efektivitas strategi komunitas dalam meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi.

Faktor Risiko: Hal-hal yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya masalah kesehatan reproduksi, seperti pernikahan dini atau kurangnya edukasi seksual.

Kesehatan Reproduksi: Kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial dalam semua aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi.

Kampanye Kesadaran: Serangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi.

Kader Kesehatan: Individu dari komunitas yang dilatih untuk memberikan edukasi dan layanan kesehatan reproduksi.

Mobilisasi Masyarakat: Proses melibatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi.

Penyuluhan Kesehatan: Proses komunikasi yang bertujuan memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat.

Peran Komunitas: Keterlibatan kelompok masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran dan akses terhadap kesehatan reproduksi.

BAB V

PEMANFAATAN APLIKASI KESEHATAN UNTUK IBU HAMIL

A. Pendahuluan

Kesehatan ibu dan bayi harus diutamakan selama kehamilan karena ini merupakan peristiwa penting dalam hidup wanita. Dalam era digital, teknologi telah banyak digunakan untuk mendukung kesehatan ibu hamil, salah satunya melalui aplikasi kesehatan. Pemanfaatan aplikasi kesehatan dapat membantu ibu hamil dalam memantau perkembangan kehamilan, mengakses informasi medis, serta mendapatkan konsultasi dengan tenaga medis secara online.

Namun, masih banyak calon ibu yang tidak menyadari atau belum memanfaatkan aplikasi kesehatan secara maksimal. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana ibu hamil memanfaatkan aplikasi kesehatan dan bagaimana hal itu memengaruhi kesehatan ibu dan bayi yang belum lahir.

B. PEMANFAATAN APLIKASI KESEHATAN UNTUK IBU HAMIL

1. Pengertian Kehamilan

Proses fisiologis yang dikenal sebagai kehamilan dimulai setelah pembuahan dan berlanjut selama sekitar 40 minggu saat sel telur tumbuh di rahim. Demi kesehatan ibu dan janin, diperlukan pemantauan ketat selama prosedur ini.

2. Teknologi dalam Kesehatan Ibu Hamil

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia medis, termasuk dalam hal pemantauan kesehatan ibu hamil. Berbagai aplikasi kesehatan kini tersedia untuk membantu ibu hamil mengakses informasi dan layanan kesehatan dengan lebih mudah. Salah satu teknologi yang sangat membantu akses informasi adalah aplikasi. Aplikasi yang terus berkembang di era digital ini telah membuat berbagai sumber daya pendidikan menjadi mudah diakses. Industri kesehatan hanyalah satu dari sekian banyak industri yang telah terdampak positif oleh perluasan dan peningkatan dunia digital.

Maraknya aplikasi terkait kesehatan untuk ponsel pintar dan PC merupakan salah satu contoh bagaimana dunia digital telah memberikan

dampak nyata pada pengobatan kontemporer. Tentu saja, masyarakat umum merasa lebih mudah karena aplikasi kesehatan semakin canggih dan canggih. Dengan menggunakan program ini, dokter dan bidan dapat mengatasi kendala geografis dan temporal untuk segera menyiapkan terapi yang diperlukan jika terjadi keadaan darurat. Berikut ini adalah ide dasar tentang cara menggunakan aplikasi:

- a. Aplikasi dapat menyatukan informasi penting yang dibutuhkan ibu hamil
- b. Aplikasi dapat membantu ibu hamil dalam mendapatkan informasi tentang kehamilannya
- c. Aplikasi dapat membantu bidan dan petugas puskesmas dalam memonitoring ibu hamil

Berikut adalah fungsi dan seberapa penting aplikasi untuk bidang kesehatan:

- a. Akses edukasi dan informasi

Dalam hal memberikan informasi kesehatan yang akurat, aplikasi kesehatan dapat menjadi sumber yang bagus. Dengan begitu, lebih banyak orang akan belajar tentang kesehatan dan peduli terhadapnya. Pemahaman masyarakat umum tentang pentingnya kesehatan dapat ditingkatkan dengan penggunaan beberapa aplikasi kesehatan yang menyediakan berbagai artikel yang berkaitan dengan hidup sehat, mengasuh anak, dan kehamilan.

- b. Diagnosa Awal

Untuk memberikan pertolongan pertama, aplikasi kesehatan juga dapat membantu diagnosis dini. Selain itu, ada aplikasi kesehatan yang memungkinkan pengguna berbicara dengan tenaga medis, seperti bidan atau dokter, untuk tujuan konsultasi atau pemeriksaan jarak jauh. Juga dapat berkonsultasi, berbicara, dan berkomunikasi dengan dokter menggunakan obrolan dokter. Fitur ini dapat membantu jikalau ibu hamil mengalami tanda-tanda persalinan dan langsung menanyakannya kepada bidan, dengan begitu bidan bisa langsung menyiapkan keperluan bersalin dan menganjurkan ibu untuk datang ke fasilitas kesehatan.

- c. Fitur support pasien

Fitur bantuan pasien tersedia di banyak aplikasi kesehatan. Pasien dapat menggunakan alat ini sebagai asisten virtual untuk memantau kesehatan mereka, mendapatkan pengingat minum obat, dan mengatur pemeriksaan atau pemeriksaan kehamilan. Karena pesatnya evolusi perawatan kesehatan, pembuatan aplikasi baru kini menjadi keharusan mutlak.

3. Manfaat Aplikasi Kesehatan bagi Ibu Hamil

- a. Akses Informasi Medis
Aplikasi kesehatan menyediakan informasi mengenai nutrisi, olahraga, dan perkembangan janin yang dapat diakses kapan saja.
- b. Pemantauan Kehamilan
Memungkinkan ibu hamil untuk memantau berat badan, tekanan darah, dan perkembangan janin secara berkala.
- c. Pengingat Jadwal Kontrol Kehamilan
Fitur ini membantu ibu hamil untuk tidak melewatkan jadwal pemeriksaan ke dokter atau bidan.
- d. Konsultasi dengan Tenaga Medis
Aplikasi tertentu memungkinkan konsultasi langsung dengan dokter atau bidan secara daring
- e. Manajemen Kesehatan Mental
Beberapa aplikasi memiliki fitur untuk mengelola stres dan kecemasan selama kehamilan.
- f. Fitur-Fitur dalam Aplikasi Kesehatan untuk Ibu Hamil
Berdasarkan data yang diperoleh, fitur yang paling sering digunakan adalah:
 - 1) Kalender Kehamilan
 - 2) Kalkulator Perkiraan Persalinan
 - 3) Forum dan Komunitas Ibu Hamil
 - 4) Video Edukasi dan Artikel Kesehatan
 - 5) Rekam Medis Digital
- g. Tantangan dalam Pemanfaatan Aplikasi Kesehatan
 - 1) Kurangnya Literasi Digital di Kalangan Ibu Hamil
 - 2) Ketergantungan pada Teknologi
 - 3) Validitas dan Keakuratan Informasi
 - 4) Biaya Aplikasi Berbayar

4. Dampak Penggunaan Aplikasi terhadap Kesehatan Ibu dan Janin

Manfaat Aplikasi dalam Kesehatan :

- a. Peningkatan Keterlibatan Pasien
Salah satu keuntungan utama Health Application adalah kemampuannya untuk meningkatkan keterlibatan pasien. Aplikasi ini menawarkan wawasan kesehatan yang dipersonalisasi, memungkinkan pasien memantau kesejahteraan mereka secara aktif. Pasien dapat dengan

mudah melacak gejala, mematuhi rejimen pengobatan, dan menerima pengingat janji temu penting serta pembaruan kesehatan

b. Peningkatan Efisiensi bagi Penyedia Layanan Kesehatan

Aplikasi kesehatan seluler merupakan terobosan dalam meningkatkan efisiensi bagi penyedia layanan kesehatan. Mereka menyederhanakan proses dan mengurangi beban administratif. Profesional layanan kesehatan dapat menggunakan aplikasi ini untuk menjadwalkan janji temu, mengakses informasi penting pasien, dan terlibat dalam komunikasi jarak jauh dengan pasien. Pendekatan yang disederhanakan ini memberdayakan penyedia layanan kesehatan untuk mengelola beban kerja mereka dengan lebih efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan pasien

c. Peningkatan Pengumpulan dan Analisis Data

Aplikasi memberdayakan penyedia layanan kesehatan dengan wawasan data berharga yang mendorong keputusan pengobatan dan meningkatkan hasil pasien. Dengan mengumpulkan data tentang gejala pasien, kepatuhan pengobatan, dan hasil pengobatan, profesional kesehatan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesehatan pasien, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data. Komunikasi yang efisien tidak hanya menguntungkan konsumen kesehatan tetapi juga penyedia layanan kesehatan. Dokter dapat memberikan instruksi medis melalui konsultasi virtual dari mana saja di dunia.

Lebih khusus lagi, aplikasi kesehatan seluler memungkinkan dokter memantau pasien setelah operasi, memfasilitasi pemulangan pasien lebih cepat, dan melakukan tindak lanjut virtual untuk meningkatkan pemulihan pasca operasi dan meningkatkan kepuasan pasien. Keberadaan Aplikasi sangat membantu dalam proses pelayanan kesehatan dan meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan pasien mengenai kesehatannya. Dengan penggunaan aplikasi pasien akan lebih mudah mengakses informasi dan melakukan deteksi dini kesehatan.

5. Fungsi Aplikasi

- a. Menyediakan informasi penting bagi ibu hamil
- b. Membantu ibu hamil dalam mengecek hasil pemeriksaan
- c. Membantu bidan dan petugas puskesmas dalam memonitoring ibu hamil
- d. Memberikan panduan untuk menjalani kehamilan dan mengasuh anak

6. Jenis Aplikasi

- a. Aplikasi yang dapat menghitung profil kehamilan, seperti tanggal prediksi kelahiran, umur kehamilan, dan umur janin
- b. Kenaikan berat badan mingguan yang ideal untuk ibu hamil, menurut sebuah aplikasi
- c. Aplikasi yang dapat memberikan informasi pengetahuan seputar kehamilan
- d. Aplikasi yang dapat memberikan wawasan minggu demi minggu tentang perkembangan bayi.
- d. Aplikasi Android

Sejak Open Handset Alliance pertama kali memperkenalkan sistem operasi Android pada akhir tahun 2007, sistem ini telah ada dan berkembang pesat. Android, yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Google, adalah sistem operasi sumber terbuka. Sistem operasi Android mendukung banyak perangkat seluler di beberapa negara. Android kini menjadi standar pada banyak perangkat elektronik lainnya, termasuk mobil, dekoder, tablet, dan netbook (Steele & To, 2010).

Aplikasi yang memungkinkan mobilitas melalui penggunaan perangkat seperti ponsel dan asisten digital pribadi dikenal sebagai aplikasi seluler. Berbagai macam aktivitas manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada: hiburan, perdagangan, pendidikan, pekerjaan kantor, penjelajahan web, mengobrol, mengirim email, dan sebagainya, dapat dilakukan dengan relatif mudah melalui penggunaan aplikasi seluler (Yonarisa, 2012).

Persentase penduduk Indonesia yang memiliki telepon pintar mencapai 24 persen pada tahun 2013, menurut penelitian dari Roy Morgan Research. Sekitar 13 juta perangkat telepon pintar terjual di Indonesia pada tahun 2012, menurut survei oleh GFK. Pada bulan Juni 2012, jempol.com mensurvei pengguna telepon pintar dan menemukan bahwa 17,2% dari mereka menggunakan OS Android. Kominfo menemukan pada tahun 2017 bahwa 50% penduduk Indonesia telah memiliki telepon seluler (Wibowo et al., 2014). Karena banyaknya pengguna telepon pintar Android, para peneliti berencana untuk membuat aplikasi yang mengajarkan wanita hamil cara menghindari anemia.

Untuk memahami informasi kesehatan dan mengatasi kesulitan terkait kehamilan, literasi kesehatan sangat penting bagi ibu hamil. Kesehatan ibu dan anak dapat terpengaruh secara negatif oleh kurangnya literasi kesehatan, yang dapat menyebabkan kesulitan seperti diabetes gestasional, stres, depresi, berat badan lahir rendah, lahir mati, dan kelainan bawaan (Meldgaard et al., 2022). Karena membantu dalam diagnosis faktor risiko kehamilan, penerapan gaya

hidup sehat, dan jaminan nutrisi optimal selama kehamilan, literasi kesehatan ibu sangatlah penting. Mengurangi angka kematian ibu, bayi, dan perinatal serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak adalah hasil yang mungkin dari akses ke perawatan prenatal berkualitas tinggi (Karamolahi et al., 2021).

Kini, ada lebih banyak cara daripada sebelumnya untuk menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat umum, terutama ibu hamil, berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. "Kesehatan digital" atau "telehealth" mengacu pada penerapan TI pada layanan kesehatan. Di antara beberapa aspek positif kesehatan digital adalah sebagai berikut: peningkatan efisiensi dalam akses kesehatan dan komunikasi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan; biaya layanan kesehatan yang lebih rendah; dan layanan kesehatan yang membantu diagnosis diferensial (Sunjaya, 2019). Penggunaan ponsel dan internet untuk mengakses catatan medis dan informasi kesehatan lainnya sedang meningkat. Hal ini membuka jalan bagi pengelolaan kesehatan individu yang lebih baik dan akses yang lebih mudah ke catatan medis (Frid et al., 2021).

Pendidikan kesehatan menggunakan aplikasi seluler menawarkan beberapa keuntungan, khususnya dalam hal kesehatan ibu. Salah satu dari banyak keuntungan menggunakan aplikasi seluler adalah bahwa aplikasi merupakan media yang ampuh untuk menyampaikan informasi, menawarkan bantuan, dan menarik perhatian pada kebutuhan perawatan prenatal. Aksesibilitas dan keramahan pengguna aplikasi telah menjadikannya alat yang hebat untuk memberikan informasi kesehatan kepada ibu hamil. Ibu hamil dapat menggunakan aplikasi untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang kehamilan, persalinan, dan perawatan pascapersalinan mereka. Lebih jauh lagi, aplikasi juga dapat membantu ibu hamil berinteraksi dengan tenaga kesehatan profesional mereka, memungkinkan mereka untuk mengatur janji temu, mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan saran serta dukungan dari jarak jauh. Ibu hamil harus memprioritaskan keamanan dan reputasi aplikasi, serta fitur, kualitas konten, kegunaan, dan ulasan pengguna (Frid et al., 2021).

7. Selain menggunakan aplikasi, ibu hamil juga dapat menjaga kesehatannya dengan:

- a. Memenuhi kebutuhan nutrisi harian
- b. Mencapai penambahan berat badan yang sehat
- c. Minum vitamin prenatal

- d. Olahraga
- e. Mengubah kebiasaan hidup menjadi lebih sehat
- f. Perawatan diri saat sakit
- g. Rutin memeriksakan kehamilan pada dokter kandungan

8. Penggunaan Aplikasi

Salah satu perkembangan terkini yang berpotensi memberikan manfaat besar bagi kesehatan ibu hamil adalah penggunaan perangkat lunak edukasi kesehatan. Indikasi penting kesehatan dan kualitas hidup suatu negara adalah angka kematian ibu (AKI), menurut WHO dalam Suryoputro et al. (2020). SDGs terutama bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Untuk setiap 100.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu (AKI) adalah jumlah semua kematian ibu yang terjadi selama dan setelah melahirkan (Yulianti et al., 2021). Ibu hamil dan menyusui dapat menggunakan aplikasi ini sebagai sumber informasi (Puspaningrum et al., 2020).

Menurut Sari et al. (2013) Kurangnya konselor menyusui, bersama dengan instruksi dan konseling yang tidak memadai, turut menyebabkan tantangan yang terkait dengan cakupan pemberian ASI eksklusif, seperti juga rendahnya tingkat informasi tentang pemberian ASI di kalangan keluarga dan perempuan. Ahli gizi dan bidan belum melakukan pekerjaan yang baik dalam melaksanakan program pemberian ASI karena tidak ada instrumen yang menarik untuk membantu mereka.

Akses terhadap informasi promosi kesehatan dipermudah dengan teknologi M-Health, yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia dijelaskan sebagai praktik medis yang menggunakan perangkat seluler (Asiodu et al., 2015). Menurut banyak penelitian, pengetahuan ibu hamil dan menyusui sangat ditingkatkan dengan aplikasi edukasi kesehatan. Aplikasi "Mama ASIX", yang dikembangkan oleh Dewi et al. (2019), memiliki berbagai fitur yang bermanfaat, seperti materi pemberian ASI eksklusif, tes pra dan pasca, serta saran menyusui.

Penelitian Lestari et al. (2021) Penelitian menggunakan aplikasi berbasis Android untuk mendidik dan memberdayakan ibu hamil tentang gizi defisit energi kronis (KEK) telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Aplikasi ini digunakan delapan kali seminggu dan memberikan data tentang KEK, kejadian, penyebab, efek, dan gizi penting.

Penelitian Sandborg et al. (2021) mengulas aplikasi Healthy Moms, yang mendorong ibu hamil untuk menjaga berat badan yang sehat dengan mempromosikan nutrisi yang baik dan olahraga teratur. Perangkat lunak ini membantu wanita yang kelebihan berat badan atau obesitas, tetapi tidak

banyak berpengaruh pada peningkatan berat badan total. Dalam penelitian mereka, Lee et al. (2022) menciptakan perangkat lunak perawatan diri yang membantu orang meningkatkan kebiasaan sehat mereka hanya dalam dua minggu. Aplikasi ini mencakup fitur-fitur termasuk makan sehat, latihan fisik, istirahat yang cukup, dan manajemen stres. Van Dijk et al. (2020) menemukan bahwa penggunaan aplikasi nutrisi seluler meningkatkan perilaku diet dan meningkatkan kepatuhan.

Ada penelitian lain yang membahas aplikasi kesehatan ibu yang membahas tentang tanda-tanda peringatan dan masalah yang mungkin timbul selama kehamilan. Perdarahan (5%), muntah dan pembengkakan ekstrem (3%), pecahnya ketuban dini (2%), demam tinggi (8%), solusio plasenta (6%), plasenta previa (6%), dan anemia (15-20%) termasuk di antara masalah yang dialami oleh 81% ibu hamil menurut data SDKI 2017. Komplikasi selama kehamilan memengaruhi 89% wanita, dengan pendarahan sebagai gejala yang paling umum. Wanita dan anak yang belum lahir sama-sama berisiko mengalami bahaya serius atau kematian jika faktor risiko tidak teridentifikasi selama kehamilan. Preeklamsia, gerakan janin berkurang, mual dan muntah ekstrem, pendarahan hebat, dan pecahnya ketuban dini merupakan indikasi peringatan.

Penelitian Winancy et al. (2022) berbicara tentang bagaimana aplikasi TABAMIL (Sinyal Bahaya Kehamilan) membantu ibu hamil mempelajari lebih lanjut tentang tanda-tanda peringatan kehamilan. Berbeda dengan format ceramah tanya jawab pada kelompok kontrol, kelompok intervensi menggunakan pendekatan ceramah dan program TABAMIL. Kedua kelompok berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah intervensi, menurut temuan tersebut. Aplikasi sinyal risiko kehamilan diterima dengan baik dan membantu ibu hamil mempelajari lebih lanjut, menurut penelitian oleh Sayekti et al. (2020).

Penelitian Arianti et al. (2023) Aplikasi Asian Parent, yang juga menekankan kesiapan untuk melahirkan dan mengenali indikator risiko prenatal, memberikan kepercayaan pada penemuan ini. Ibu hamil memerlukan perhatian khusus untuk sistem reproduksinya selain mengetahui tanda-tanda peringatan kehamilan dan menjaga kebiasaan makan yang sehat. Untuk mengurangi angka kematian ibu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik masyarakat tentang kesehatan reproduksi (Wiweko et al., 2018).

Perawatan selama kehamilan, cara menghindari kanker serviks, ibu hamil berisiko tinggi, dan metode pengendalian kelahiran semuanya tercakup dalam aplikasi Jakpros. Pengetahuan pengguna ditingkatkan oleh perangkat lunak ini, tetapi apakah hal itu juga memengaruhi perilaku baik masih belum pasti. Berbeda dengan aplikasi pesaing, Health-e Babies merinci pertumbuhan janin,

perubahan kondisi fisik ibu, tes dan prosedur kehamilan, potensi masalah, dan solusinya. Berdasarkan data ilmiah, program ini mendorong ibu hamil untuk makan sehat, berolahraga secara teratur, dan bersantai untuk mengurangi kemungkinan kecemasan dan kesedihan (Dalton et al., 2018).

Singkatnya, aplikasi kesehatan ibu hamil mencakup semua hal mendasar terkait pengetahuan kehamilan, mulai dari pola makan dan perawatan diri hingga indikator bahaya dan banyak lagi. Dengan menyediakan informasi di ujung jari pengguna, aplikasi ini memberdayakan ibu hamil untuk memprioritaskan kesehatan mereka sendiri dan anak-anak mereka yang belum lahir.

C. Penutup

Ibu hamil bisa mendapatkan informasi yang lebih personal dengan aplikasi ini tentang berbagai topik termasuk pilihan gaya hidup sehat, indikasi risiko kehamilan, pemberian ASI eksklusif, perilaku ibu yang terkait dengan kekurangan energi kronis, dan banyak lagi. Saat ini, ada jawaban lain yang diberikan oleh penggunaan aplikasi, khususnya bagi ibu hamil. Ibu khawatir tentang anak mereka yang belum lahir ketika mereka menghadapi hambatan dalam mengakses unit perawatan kritis selama kehamilan. Akibatnya, ibu hamil harus mengurus diri mereka sendiri di rumah. Aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan akses ibu hamil terhadap informasi terkait kesehatan dan memberdayakan mereka untuk merawat diri mereka sendiri dengan lebih baik telah dibuat di sejumlah negara.

Referensi

- Arianti, G. A. P. Y., Ruspawan, I. D. M., Hartati, N. N., & Runiari, N. (2023). Effects Of Educational Media Applications Of The Asian Parent On The Implementation Of Birth Preparedness And Complication Readiness For Third Trimester Pregnant Women. *International Conference On Multidisciplinary Approaches In Health Science*,
- Asiodu, I. V., Waters, C. M., Dailey, D. E., Lee, K. A., & Lyndon, A. (2015). Breastfeeding And Use Of Social Media Among First- Time African American Mothers. *Journal Of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 44(2), 268-278.
- Dalton, J. A., Rodger, D., Wilmore, M., Humphreys, S., Skuse, A., Roberts, C. T., & Clifton, V. L. (2018). The Health-E Babies App For Antenatal Education: Feasibility For Socially Disadvantaged Women. *Plos One*, 13(5), E0194337.
- Dewi, M. M., Djamil, M., & Anwar, M. C. (2019). Education M-Health Android-Based Smartphone Media Application" Mama Asix" For Third Trimester Pregnant Women As Preparation For Exclusive Breastfeeding. *Journal Of Health Promotion And Behavior*, 4(2), 98-109.
- Frid, G., Bogaert, K., & Chen, K. T. (2021). Mobile Health Apps For Pregnant Women: Systematic Search, Evaluation, And Analysis Of Features. *Journal Of Medical Internet Research*, 23(10), E25667.
- Karamolahi, P. F., Khalesi, Z. B., & Niknami, M. (2021). Efficacy Of Mobile App-Based Training On Health Literacy Among Pregnant Women: A Randomized Controlled Trial Study. *European Journal Of Obstetrics & Gynecology And Reproductive Biology*: X, 12, 100133.
- Lee, Y., Choi, S., & Jung, H. (2022). Self-Care Mobile Application For South Korean Pregnant Women At Work: Development And Usability Study. *Risk Management And Healthcare Policy*, 997-1009.
- Lestari, W. O. S. W., Syarif, S., Hidayanty, H., Aminuddin, A., & Ramadany, S. (2021). Nutrition Education With Android-Based Application Media To Increase Knowledge, Attitudes, And Behaviors Of Pregnant Women About Chronic Energy Deficiency (Kek). *International Journal Of Health And Medical Sciences*, 4(1), 15-22.
- Meldgaard, M., Gamborg, M., & Maindal, H. T. (2022). Health Literacy Levels Among Women In The Prenatal Period: A Systematic Review. *Sexual & Reproductive Healthcare*, 34, 100796.
- Notoadmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan, Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Penerbit Rieneka Cipta. In: Jakarta.

- Puspaningrum, A. S., Firdaus, F., Ahmad, I., & Anggono, H. (2020). Perancangan Alat Deteksi Kebocoran Gas Pada Perangkat Mobile Android Dengan Sensor MQ-2. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Tertanam*, 1(1), 1-10.
- Sandborg, J., Söderström, E., Henriksson, P., Bendtsen, M., Henström, M., Leppänen, M. H., Maddison, R., Migueles, J. H., Blomberg, M., & Löf, M. (2021). Effectiveness Of A Smartphone App To Promote Healthy Weight Gain, Diet, And Physical Activity During Pregnancy (Healthymoms): Randomized Controlled Trial. *Jmir Mhealth And Uhealth*, 9(3), E26091.
- Sari, I., Mulyono, B., & Andarsari, W. (2013). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Bekerja Dengan Pemberian Asi Eksklusif Di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2011. *Jurnal Kebidanan*, 1(1), 41-46.
- Sayekti, W. N., Syarif, S., Ahmad, M., Nurkhayati, E., & Suciati, S. (2020). Media Edukasi Tanda Bahaya Kehamilan Berbasis Android Untuk Meningkatkan Pengetahuan Ibu Hamil. *Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 7(2), 76-86.
- Sunjaya, A. P. (2019). Potensi, Aplikasi Dan Perkembangan Digital Health Di Indonesia. *Journal Of The Indonesian Medical Association*, 69(4), 167-169.
- Suryoputro, A., Budiyantri, R. T., & Notri, M. (2020). Evaluasi "Sayang Ibu": Aplikasi Kegawatdaruratan Ibu Hamil. *Cermin Dunia Kedokteran*, 47(7), 510-514.
- Van Dijk, M. R., Koster, M. P., Oostingh, E. C., Willemsen, S. P., Steegers, E. A., & Steegers-Theunissen, R. P. (2020). A Mobile App Lifestyle Intervention To Improve Healthy Nutrition In Women Before And During Early Pregnancy: Single-Center Randomized Controlled Trial. *Journal Of Medical Internet Research*, 22(5), E15773.
- Who. (2021). Maternal Mortality: Estimates By Country. Global Health Observatory. <https://apps.who.int/gho/data/view/main.1370?lang=en>
- Who. (2024). Promoting Healthy Pregnancy. <https://www.who.int/activities/promoting-healthy-pregnancy>
- Pratiwi, S. A., & Aticeh, A. (2022). Efektivitas Aplikasi Tanda Bahaya Kehamilan (Tabamil) Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil. *Jurnal Kesehatan Poltekkes Kemenkes Ri Pangkalpinang*, 10(2), 90-98.
- Wiweko, B., Riyanti, A., Olivia, S., Priangga, M., Silvana, V., Pertiwi, I. P., Wibawa, Y. S., Febri, R. R., Putro, A. L. R., & Agung, P. G. (2018). Jakpros: Reproductive Health Education Application For Pregnant Women. 2018 International Conference On Advanced Computer Science And Information Systems (Icacsis), Y
- ulianti, D. T., Damayanti, D., & Prastowo, A. T. (2021). Pengembangan Digitalisasi Perawatan Kesehatan Pada Klinik Pratama Sumber Mitra Bandar Lampung. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 32-39.

BAB VI

DUKUNGAN PSIKOLOGIS BAGI IBU HAMIL DENGAN KOMPLIKASI

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan proses reproduksi yang dialami oleh setiap perempuan dalam siklus maturase kehidupannya. Dalam perjalanannya tidak selalu kehamilan berjalan secara normal dan seringkali terjadi masalah atau komplikasi. Diagnosis komplikasi menyebabkan ibu hamil rentan mengalami stres, kecemasan berlebih, depresi, hingga rasa bersalah yang mendalam. Kondisi ini diperparah jika ibu harus menjalani rawat inap dalam jangka waktu lama atau mengalami pembatasan dalam beraktivitas secara drastis (Turkmen et al., 2024). Rasa ketidakberdayaan atas diri dan kondisi yang dialaminya dapat menyebabkan penurunan kepercayaan diri dalam menjalani transisi peran sebagai calon ibu dan bahkan dapat menjadi psikiatrik distress pada periode post partum (Basirat et al., 2022).

Prevalensi kehamilan dengan komplikasi cukup besar yaitu sebesar 61,6% kehamilan masuk dalam kategori kehamilan berisiko tinggi dengan berbagai macam komplikasi yang dialami (Maria et al., 2025). Komplikasi yang terjadi pada kehamilan meliputi anemia, pre eklamsi/ eklamsi. Persalinan premature, dan bayi dengan berat badan lahir rendah (Abate et al., 2025). Dari sejumlah kondisi, Hipotiroid merupakan kondisi yang paling banyak mempengaruhi kehamilan yaitu sebanyak 182 wanita hamil (9,6%), diikuti oleh hipertensi akibat kehamilan (6,5%), anemia berat (3,2%), dan inkompatibilitas Rh (2,8%). Kondisi berisiko tinggi lainnya yang perlu diperhatikan termasuk diabetes melitus gestasional (GDM) (2,5%), kehamilan kembar (0,7%), oligohidramnion (0,6%), dan hipertiroidisme (0,5%). Kondisi berisiko tinggi lain yang jumlahnya lebih kecil seperti polihidramnion, plasenta previa, HBsAg positif, gangguan kejang, retardasi pertumbuhan intrauterin, inkompetensi serviks, HIV positif, kista ovarium, kolelitiasis, hipertensi kronis, sindrom ovarium polikistik, dan poliomyelitis (Johnson et al., 2024).

Faktor penyebab dari komplikasi pada kehamilan adanya “tiga terlambat” yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat mendapat pelayanan yang dibutuhkan di fasilitas kesehatan, terbukti sebanyak 64,61% ibu lebih memilih untuk melakukan pengobatan sendiri jika terjadi masalah (Noviani et al., 2024). Fenomena ini didukung dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa masalah pada kehamilan terbesar adalah ANC yang kurang akibat kurangnya pengetahuan dan status sosial ekonomi yang rendah sehingga

menyebabkan ibu menunda untuk memeriksakan kehamilannya (Safhira & Ermi, 2024). Komplikasi yang terjadi akibat keterlambatan pada pengelolaan kehamilan memunculkan rasa cemas, stress kronis, depresi pada periode antenatal, rasa bersalah pada diri sendiri yang dapat berlanjut pada isolasi sosial dan depresi pada periode post partum (Ariasih et al., 2024).

Dukungan emosional dari keluarga, pasangan, dan tenaga medis sangat penting untuk membantu ibu menjalani masa kehamilan yang sulit ini. Intervensi psikologis dini, seperti konseling atau terapi, sangat dianjurkan untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental ibu maupun perkembangan janin (Mane et al., 2024). Dukungan yang berpusat pada keluarga menjadi suatu hal paling penting, pemberian dukungan emosional membantu ibu merasa aman, mengurangi stres, dan menjaga kestabilan mental yang penting bagi kesehatan janin. Sementara itu, dukungan fisik seperti bantuan dalam aktivitas harian, pengaturan jadwal kontrol, atau penyediaan nutrisi yang tepat membantu ibu fokus pada pemulihan dan kehamilan yang sehat (Indriyani et al., 2025). Tenaga medis juga berperan penting dengan memberikan informasi yang jelas dan penanganan yang responsive dengan pelayanan berkelanjutan yang diberikan mampu untuk menurunkan komplikasi pada kehamilan risiko tinggi (Mar et al., 2025).

B. Konsep Kehamilan Risiko Tinggi

Kehamilan risiko tinggi adalah kondisi kehamilan yang disertai satu atau lebih faktor yang dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan janin selama kehamilan, persalinan, hingga masa nifas (Ratnaningtyas & Indrawati, 2023). Kehamilan ini membutuhkan perhatian dan penanganan khusus untuk mencegah dampak kesehatan yang serius, baik selama masa kehamilan, persalinan, maupun pasca-persalinan (Rukina & Pangastuti, 2022).

Kehamilan dengan risiko tinggi dapat menimbulkan dampak psikologis seperti kecemasan akut, stres emosional, dan rasa kehilangan kontrol yang dapat mengganggu kestabilan mentalnya. Ibu hamil mungkin juga mengalami gangguan dalam membentuk ikatan emosional dengan janin, yang dapat menghambat perkembangan hubungan ibu dan anak setelah kelahiran. Selain itu, stres yang tinggi selama kehamilan risiko tinggi juga meningkatkan risiko depresi postpartum, gangguan stres pascatrauma (PTSD), serta penurunan kepercayaan diri sebagai ibu (Pratiwi & Khairani, 2023).

Dampak secara fisik yang dapat ditimbulkan akibat ibu hamil dengan risiko tinggi antara lain keguguran, partus macet, perdarahan antepartum, dan janin mati dalam kandungan. Selain berdampak pada kehamilan dan persalinan, kehamilan risiko tinggi berdampak pula pada masa nifas yaitu ibu mengalami perdarahan

postpartum dan kematian pada ibu ataupun bayi. Adapun dampak kehamilan resiko tinggi terhadap bayi baru lahir yaitu bayi lahir prematur, dan berat badan rendah ataupun berat badan lebih (Utama, 2021).

Komplikasi kehamilan resiko tinggi merupakan kondisi yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin, baik selama masa kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Kehamilan resiko tinggi berisiko menimbulkan berbagai komplikasi seperti preeklamsia, kelahiran prematur, pertumbuhan janin terhambat, hingga kematian perinatal. Oleh karena itu, identifikasi dini dan pemantauan intensif sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi serius dan meningkatkan luaran kehamilan yang sehat bagi ibu dan janin (Prajapati et al., 2022).

Kehamilan resiko tinggi memerlukan perhatian dan pemantauan khusus, karena bila tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan morbiditas (kesakitan) dan mortalitas (kematian) maternal dan neonatal. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sejak dini faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi jalannya kehamilan agar tindakan pencegahan dan intervensi medis dapat dilakukan secara tepat (Kuppusamy & Prusty, 2023). Kehamilan dikategorikan sebagai risiko tinggi jika ibu mengalami satu atau lebih dari kondisi berikut :

1. Faktor Demografis

Kehamilan pada usia terlalu muda (<18 tahun) atau terlalu tua (>35 tahun) memiliki kaitan erat dengan meningkatnya risiko komplikasi seperti kelahiran prematur, kelainan genetik, dan preeklamsia. Usia ekstrem juga dikaitkan dengan tingginya angka morbiditas dan mortalitas perinatal (O'Kelly et al., 2022).

2. Faktor Medis

Ibu dengan kondisi medis kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, anemia berat, penyakit autoimun, atau gangguan ginjal berisiko tinggi mengalami komplikasi serius selama kehamilan dan persalinan. Penyakit-penyakit ini dapat memengaruhi aliran darah ke plasenta dan mengganggu pertumbuhan janin (Pearce & Ellis, 2022).

3. Faktor Obstetri

Riwayat obstetri seperti keguguran berulang, preeklamsia, perdarahan antepartum, persalinan prematur, atau kehamilan ektopik meningkatkan risiko terjadinya komplikasi pada kehamilan berikutnya. Oleh karena itu, ibu dengan riwayat tersebut harus menjalani pemantauan kehamilan yang lebih intensif (Diabelkova et al., 2023).

4. Faktor Janin

Kehamilan yang melibatkan lebih dari satu janin (kembar), gangguan pertumbuhan intrauterin (IUGR), atau adanya kelainan kongenital pada janin

juga tergolong sebagai kehamilan risiko tinggi. Kondisi ini membutuhkan evaluasi dan intervensi dini untuk mencegah komplikasi serius, seperti kelahiran prematur atau kematian janin dalam kandungan (Turesheva et al., 2023).

5. Faktor Sosial dan Ekonomi

Faktor-faktor sosial seperti malnutrisi, kemiskinan, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kehamilan. Perempuan dengan kondisi ini seringkali mengalami keterlambatan dalam mendapatkan perawatan prenatal yang adekuat (Barakat et al., 2023).

Penanganan kehamilan risiko tinggi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memastikan keselamatan ibu dan janin. Langkah pertama adalah edukasi yang intensif kepada ibu hamil mengenai tanda bahaya, gaya hidup sehat, serta pengelolaan faktor risiko seperti hipertensi ataupun diabetes (Anandita & Gustina, 2021). Dukungan psikologis menjadi komponen penting dari manajemen kehamilan risiko tinggi. Dukungan dapat diberikan melalui pendekatan profesional seperti konseling psikologis, terapi perilaku kognitif, serta dukungan informal dari keluarga dan lingkungan sosial. Keterlibatan keluarga, terutama suami dalam pengambilan keputusan dan penyediaan dukungan emosional, terbukti membantu mengurangi beban psikologis ibu (Ogueji, 2021). Kolaborasi antara dokter kandungan, dan tenaga medis lainnya juga sangat penting untuk memastikan perawatan yang optimal bagi ibu dan bayi. Rencana persalinan juga harus dipersiapkan dengan matang, melibatkan fasilitas kesehatan yang memiliki peralatan lengkap dan tenaga medis terlatih (Siahaan & Maghfirah, 2023).

Tenaga kesehatan memegang peranan sentral dalam pemberian dukungan psikologis. Melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek bio-psiko-sosial, mereka dapat mengidentifikasi tanda-tanda tekanan emosional, memberikan edukasi yang menenangkan, serta merancang intervensi sederhana seperti teknik relaksasi dan latihan pernapasan (Davis et al., 2021). Dukungan psikologis dalam kehamilan risiko tinggi bukan sekadar tambahan, melainkan bagian integral dari keseluruhan asuhan kehamilan. Ketika aspek emosional ibu diperhatikan dan ditangani secara tepat, hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup ibu selama masa kehamilan, tetapi juga meningkatkan hasil kehamilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, integrasi dukungan psikologis ke dalam pelayanan antenatal terutama untuk kasus risiko tinggi sangat penting untuk menciptakan pengalaman kehamilan yang lebih aman, sehat, dan bermakna bagi ibu dan keluarganya (Law et al., 2021).

C. Dampak Komplikasi Kehamilan Terhadap Kesehatan Mental Ibu

Kehamilan dengan komplikasi dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan psikologis ibu, seperti stres dan kecemasan. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang dan kesehatan anak. Berikut dampak komplikasi kehamilan pada ibu dan anak, sebagai berikut :

1. Dampak Psikologis Pada Ibu

a. Dampak Jangka Pendek

1) Kecemasan Akut dan Stres Emosional

Ibu hamil setelah menerima diagnosis kehamilan risiko tinggi mengalami reaksi emosional mendadak seperti syok, ketakutan, dan rasa panik yang dapat mengganggu kestabilan kondisi mentalnya. Perasaan cemas yang berlebihan ini dapat berpengaruh terhadap pola tidur, selera makan, serta kemampuan konsentrasi ibu selama menjalani masa kehamilan. Gangguan psikologis tersebut dapat memperburuk kondisi fisik ibu dan menghambat proses adaptasi terhadap kehamilan yang sedang dijalani (Alves et al., 2021). Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan dukungan emosional dan informasi yang memadai guna membantu ibu dalam menghadapi tantangan kehamilan risiko tinggi dengan lebih tenang dan terarah.

2) Kehilangan Rasa Kontrol dan Ketidakberdayaan

Kondisi medis yang kompleks serta intervensi yang bersifat mendesak dan sering kali ditentukan oleh tenaga kesehatan membuat ibu merasa tidak memiliki kendali atas tubuhnya maupun atas proses kehamilan yang sedang dijalani. Ketidakmampuan untuk menentukan pilihan secara bebas dalam pengambilan keputusan medis dapat menimbulkan perasaan tidak percaya diri, keraguan terhadap kemampuan diri sebagai calon ibu, serta kekhawatiran berlebih terhadap hasil kehamilan. Perasaan ini dapat mengganggu kesiapan emosional ibu dalam menjalani masa kehamilan hingga persalinan (Khadivzadeh et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang empatik dan partisipatif dalam pengambilan keputusan, agar ibu tetap merasa dihargai dan memiliki peran aktif dalam proses kehamilannya.

3) Gangguan Ikatan Emosional dengan Janin

Ibu hamil dengan komplikasi dapat mengalami gangguan dalam membentuk ikatan emosional dengan janin yang dikandungnya. Ketakutan akan kemungkinan kehilangan janin, risiko keguguran, atau komplikasi lainnya secara tidak sadar mendorong ibu untuk menjaga jarak secara emosional sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri.

Keadaan ini dapat menghambat proses pembentukan ikatan prenatal yang seharusnya terbentuk secara alami selama masa kehamilan. Hambatan dalam membangun kedekatan emosional tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan psikologis ibu, tetapi juga berpotensi memengaruhi perkembangan hubungan ibu-anak setelah kelahiran (Navon & Taubman, 2023).

b. Dampak Jangka Panjang

1) Risiko Depresi Postpartum

Kehamilan yang disertai komplikasi tidak hanya menimbulkan dampak psikologis jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko terjadinya depresi pada masa postpartum. Stres berat yang dialami selama kehamilan risiko tinggi dapat memperlemah ketahanan psikologis ibu setelah persalinan. Depresi postpartum yang timbul sering kali ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, kelelahan emosional, dan kehilangan minat dalam merawat diri maupun bayi. Kondisi ini dapat mengganggu proses menyusui, pola pengasuhan, serta membentuk jarak emosional dalam hubungan antara ibu dan anak (Urbanova et al., 2021). Oleh karena itu, deteksi dini dan pendampingan psikologis bagi ibu dengan kehamilan berisiko tinggi sangat penting untuk mencegah gangguan psikologis yang lebih lanjut setelah persalinan.

2) Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD)

Pengalaman traumatis yang dialami selama kehamilan dengan komplikasi, seperti perawatan intensif, kehilangan janin, atau proses persalinan darurat, dapat meninggalkan dampak psikologis jangka panjang berupa gangguan stres pascatrauma (PTSD). Ibu dengan riwayat kejadian tersebut berisiko mengalami gejala PTSD yang meliputi kilas balik terhadap peristiwa traumatis, mimpi buruk yang berulang, serta penghindaran terhadap situasi atau tempat yang mengingatkan pada kejadian tersebut. Gangguan ini dapat memengaruhi kualitas hidup ibu secara keseluruhan, termasuk dalam menjalani peran sebagai orang tua, berinteraksi dengan lingkungan sosial, dan menjaga kesehatan mental jangka panjang (Martinez et al., 2021). Oleh karena itu, penting dilakukan pemantauan dan intervensi psikologis berkelanjutan bagi ibu yang mengalami kejadian traumatis selama kehamilan atau persalinan, guna mencegah gangguan psikologis yang menetap.

3) Penurunan Kepercayaan Diri sebagai Ibu

Pengalaman kehamilan yang penuh risiko sering kali membuat ibu merasa tidak mampu menjalani proses kehamilan dan persalinan secara ideal, sehingga menimbulkan perasaan gagal dan rendah diri. Perasaan tersebut dapat menetap hingga masa pascapersalinan dan memengaruhi hubungan emosional antara ibu dan anak, serta menurunkan kualitas pola pengasuhan yang diberikan. Ketidakpercayaan terhadap kemampuan diri ini juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap gangguan psikologis lainnya, seperti kecemasan berkepanjangan atau gangguan suasana hati (Teskereci et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan dukungan psikologis yang berkelanjutan dan pendekatan empatik guna membantu ibu membangun kembali kepercayaan diri dalam menjalani peran keibuannya.

2. Dampak Jangka Panjang Pada Anak

a. Kelahiran Prematur dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Kehamilan dengan risiko tinggi sering kali berhubungan dengan kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR). Bayi yang lahir dengan BBLR atau prematur berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan serius, seperti gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, dan infeksi. Bayi-bayi ini juga memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami keterlambatan perkembangan fisik dan kognitif, serta memiliki harapan hidup yang lebih pendek dibandingkan dengan bayi yang lahir cukup bulan dengan berat badan normal (Diabelkova et al., 2023). Oleh karena itu, perawatan intensif sejak dini dan pengawasan medis yang ketat diperlukan untuk mengurangi risiko komplikasi jangka panjang yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak.

b. Gangguan Sistem Saraf dan Kesehatan Mental di Masa Depan

Paparan stres yang dialami ibu selama kehamilan dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan sistem saraf janin, yang meningkatkan risiko gangguan neurologis dan masalah kesehatan mental di masa depan. Stres yang menyebabkan peningkatan hormon kortisol dalam tubuh ibu dapat memengaruhi perkembangan otak janin, yang berpotensi menyebabkan gangguan seperti Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) serta gangguan perilaku lainnya. Perubahan dalam struktur otak yang terjadi akibat paparan hormon stres ini dapat memengaruhi kemampuan anak dalam belajar, beradaptasi, dan mengatur emosi, sehingga meningkatkan kerentanannya terhadap masalah psikologis di masa kanak-kanak dan dewasa (Horsch et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk

meminimalkan stres pada ibu hamil guna mendukung perkembangan otak janin yang sehat dan mencegah gangguan neurologis jangka panjang.

c. Kekebalan Tubuh Rendah dan Risiko Gangguan Kardiovaskular

Paparan stres ibu selama kehamilan dapat memengaruhi perkembangan sistem kekebalan tubuh janin, yang berpotensi mengakibatkan kekebalan tubuh yang lebih rendah pada anak. Anak yang terpapar stres prenatal lebih rentan terhadap infeksi dan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan kardiovaskular, seperti hipertensi dan penyakit jantung, karena perubahan dalam perkembangan sistem vaskular dan hormonal yang terjadi selama kehamilan. Penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh dan peningkatan risiko gangguan kardiovaskular ini dapat memengaruhi kualitas hidup anak dalam jangka panjang (Cederlof et al., 2022). Oleh karena itu, menjaga kesehatan fisik dan mental ibu selama kehamilan sangat penting untuk mendukung perkembangan kesehatan tubuh anak yang optimal.

d. Gangguan Perkembangan Emosional dan Sosial

Stres yang dialami ibu selama kehamilan dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosial janin, yang berpotensi menyebabkan gangguan pada interaksi sosial dan pengelolaan emosi anak di masa depan. Bayi yang terpapar stres prenatal cenderung lebih mudah terangsang dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial serta mengelola emosi. Hal ini dapat menyebabkan anak memiliki masalah dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan stabil, baik di lingkungan keluarga maupun sosial. Selain itu, paparan stres prenatal dapat meningkatkan kerentanannya terhadap gangguan kecemasan dan depresi di masa kanak-kanak dan remaja (Briege et al., 2022). Oleh karena itu, pengelolaan stres yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mendukung perkembangan emosional dan sosial anak secara optimal.

D. Jenis Dukungan Psikologis yang Diperlukan

Kehamilan dengan komplikasi merupakan pengalaman yang penuh tantangan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Dukungan psikologis menjadi esensial dalam menjaga kesejahteraan mental dan hasil kehamilan yang optimal. Dukungan psikologis yang komprehensif mampu mengurangi gejala stres dan kecemasan, serta berkontribusi terhadap adaptasi ibu terhadap kondisi komplikasi yang dihadapi (Ogueji, 2021). Jenis dukungan yang diperlukan untuk memperkuat ketahanan mental ibu dan meningkatkan kualitas hidup selama masa kehamilan, yaitu sebagai berikut :

1. Dukungan Emosional

Dukungan emosional adalah bentuk bantuan psikologis yang diberikan melalui sikap penuh kasih sayang, empati, perhatian, dan penciptaan rasa aman. Dukungan emosional bersumber dari pasangan, anggota keluarga, maupun orang-orang terdekat yang memiliki keterikatan emosional dengan ibu hamil. Kehamilan dengan komplikasi, seperti hiperemesis gravidarum, preeklamsia, diabetes gestasional, risiko kelahiran premature tidak hanya membawa tantangan medis, tetapi juga tekanan emosional yang signifikan (Shoib et al., 2022). Oleh karena itu, peran lingkungan sosial dalam memberikan dukungan emosional sangat dibutuhkan untuk mengurangi rasa cemas, khawatir, dan ketidakpastian yang kerap dialami oleh ibu hamil dalam kondisi tersebut. Dukungan emosional pada ibu hamil dengan komplikasi merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas kondisi psikologis selama kehamilan. Dukungan emosional berkontribusi dalam menurunkan tingkat stres dan gangguan kecemasan yang umum dialami oleh ibu hamil dengan komplikasi (Law et al., 2021).

2. Dukungan Informasional

Dukungan informasional adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk penyampaian data, pengetahuan, serta saran yang relevan untuk membantu individu memahami kondisi yang dialami serta membuat keputusan yang tepat sesuai kebutuhan mengenai kondisi kesehatan ibu dan janin. Ibu hamil dengan komplikasi sering kali mengalami kecemasan dan ketidakpastian akibat kurangnya pemahaman mengenai kondisi yang dialami. Oleh karena itu, pemberian informasi yang jelas dan akurat mengenai diagnosis, perkembangan kondisi kesehatan, serta langkah-langkah perawatan yang harus dijalani sangat penting (Conrad, 2024).

Dukungan informasional dapat memperkuat kesiapan psikologis ibu hamil dalam menghadapi berbagai kemungkinan selama kehamilan dan persalinan. Penelitian oleh menunjukkan bahwa ibu hamil yang mendapatkan informasi secara konsisten dan responsif dari tenaga kesehatan memiliki tingkat kepuasan dan kesiapan persalinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan dukungan informasi memadai. Dengan demikian, penyediaan informasi yang efektif bukan hanya sebagai bentuk komunikasi, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan ibu hamil dalam menjaga kesehatan diri dan janinnya (Glick et al., 2021).

3. Dukungan Instrumental

Dukungan instrumental adalah bentuk dukungan nyata yang diberikan kepada individu dalam bentuk bantuan praktis dan langsung, seperti pelayanan kesehatan, dukungan finansial, bantuan transportasi, serta bantuan dalam aktivitas harian. Dukungan ini sangat krusial bagi ibu hamil dengan komplikasi untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan ibu maupun janin. Bantuan praktis seperti pendampingan ke fasilitas kesehatan, penyediaan akses terhadap layanan medis, serta dukungan logistik selama pemeriksaan kehamilan dapat meringankan beban fisik dan emosional yang dihadapi ibu hamil (Hijazi et al., 2021).

4. Dukungan Sosial

Dukungan sosial merupakan bantuan emosional yang diberikan oleh lingkungan terdekat, seperti keluarga, pasangan, dan teman sebaya, yang dapat berupa empati, perhatian, rasa aman, serta kenyamanan emosional. Keberadaan lingkungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan ibu hamil berperan penting dalam menciptakan rasa diterima dan mengurangi beban psikologis akibat kondisi kehamilan yang kompleks. Dukungan sosial yang adekuat berkaitan erat dengan penurunan tingkat kecemasan, stres, serta gejala depresi selama masa kehamilan, sekaligus meningkatkan kemampuan ibu dalam beradaptasi terhadap tekanan yang ditimbulkan oleh komplikasi kehamilan (Kazemi et al., 2021).

Dukungan sosial dapat meningkatkan ketahanan psikologis ibu dan membentuk persepsi yang lebih positif terhadap proses kehamilan. Melalui interaksi interpersonal yang sehat, seperti komunikasi terbuka, berbagi pengalaman, serta pemberian motivasi dari orang-orang terdekat, ibu hamil memperoleh dorongan emosional yang memperkuat kepercayaan dirinya. Bentuk dukungan sederhana seperti menjadi tempat berbagi perasaan atau memberikan pendampingan saat kunjungan ke fasilitas kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas emosional ibu (Khoury et al., 2021).

5. Dukungan Spiritual

Dukungan spiritual adalah bentuk bantuan yang berfokus pada aspek spiritual atau keagamaan seseorang, yang bertujuan untuk memberikan ketenangan batin, dan kekuatan emosional (Insani & Supriatun, 2021). Bentuk dukungan spiritual meliputi doa, meditasi, konseling spiritual, atau keterlibatan dalam kegiatan keagamaan yang dapat membantu individu mengatasi stres, kecemasan, dan tantangan hidup. Dukungan spiritual berperan penting dalam membantu ibu menghadapi komplikasi kehamilan dengan memberikan rasa

harapan, kedamaian, dan kekuatan batin untuk melalui masa-masa yang penuh ketidakpastian dan tekanan (Piccinini et al., 2021).

Ibu hamil yang terlibat dalam kegiatan spiritual atau mendapat dukungan menunjukkan peningkatan rasa percaya diri dan ketenangan batin. Praktik-praktik ini tidak hanya memberikan harapan, tetapi juga memperkuat ketahanan psikologis ibu dalam menghadapi ketidakpastian yang terkait dengan kehamilan berisiko tinggi. Oleh karena itu, pendekatan yang menggabungkan aspek spiritual dalam perawatan kesehatan ibu hamil tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mendukung proses pemulihan emosional yang lebih baik selama masa kehamilan (Moafi et al., 2021).

6. Dukungan Profesional

Dukungan profesional pada ibu hamil merupakan bantuan yang diberikan dari tenaga medis yang terlatih dan berkompeten untuk memenuhi kebutuhan medis dan psikologis ibu hamil yang menghadapi kondisi kehamilan berisiko tinggi atau komplikasi. Tujuan dari dukungan profesional adalah untuk memberikan perawatan yang holistik, memastikan keselamatan ibu dan janin, serta mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran yang sering dihadapi oleh ibu hamil dengan komplikasi, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesiapan ibu menghadapi persalinan. Dukungan ini meliputi konsultasi medis yang mendalam, pengawasan rutin terhadap kondisi kesehatan ibu, serta pemberian terapi atau intervensi medis yang disesuaikan dengan jenis komplikasi (Brown et al., 2022).

Dukungan profesional mencakup bantuan psikologis yang sangat penting dalam mengelola stres dan kecemasan yang sering dialami oleh ibu hamil dengan komplikasi. Psikolog atau konselor kesehatan mental dapat membantu ibu mengatasi perasaan cemas, takut, atau depresi yang muncul akibat perubahan kondisi fisik dan emosional selama kehamilan. Dukungan psikologis yang diberikan oleh tenaga profesional dapat menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu. Pendekatan yang holistik yang melibatkan tenaga medis baik medis maupun psikologis, sangat diperlukan dalam mendukung ibu hamil dengan komplikasi, agar ibu merasa lebih tenang, terkontrol, dan siap menghadapi proses kehamilan serta persalinan (van et al., 2021).

Pemenuhan dukungan psikologis yang mencakup aspek emosional, informasional, instrumental, sosial, spiritual, dan profesional merupakan fondasi penting dalam mendampingi ibu hamil dengan komplikasi kehamilan. Kombinasi dukungan yang saling melengkapi ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi

tekanan mental, tetapi juga meningkatkan kapasitas ibu dalam menghadapi tantangan kehamilan yang kompleks. Pendekatan interdisipliner yang melibatkan tenaga kesehatan, keluarga, dan lingkungan sosial perlu diterapkan secara terpadu untuk menjamin dukungan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi ibu hamil dalam kondisi tersebut (Wicaksana et al., 2024).

E. Peran Tenaga Kesehatan dan Keluarga

1. Peran Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan berperan penting dalam memberikan pelayanan medis yang komprehensif kepada ibu hamil dengan komplikasi guna mencegah risiko yang lebih berat. Tenaga kesehatan bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan rutin serta memberikan edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan. Berikut merupakan macam-macam uraian peran tenaga kesehatan :

a. Deteksi Dini Komplikasi

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan deteksi dini komplikasi pada ibu hamil melalui pemeriksaan rutin kehamilan atau *antenatal care* (ANC). Pemeriksaan ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan janin serta mengidentifikasi risiko komplikasi sejak tahap awal kehamilan (Brown et al., 2022). Komplikasi yang umum ditemukan meliputi hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia, perdarahan, dan infeksi. Dengan pelaksanaan ANC yang teratur dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, intervensi medis dapat diberikan sedini mungkin sebelum komplikasi berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Langkah ini terbukti efektif dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi selama masa kehamilan dan persalinan (Anvarovich, 2025).

b. Edukasi dan Konseling

Tenaga kesehatan memiliki peranan dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil, terutama yang mengalami komplikasi kehamilan. Edukasi ini mencakup informasi mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan, pentingnya pola makan yang seimbang, pemenuhan istirahat yang cukup, serta perencanaan persalinan yang tepat dan aman. Pengetahuan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan ibu hamil terhadap kondisi kesehatannya, sehingga diharapkan mampu mengenali perubahan yang mencurigakan secara dini dan mengambil langkah yang sesuai (Azizah et al., 2024).

Tenaga kesehatan juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan konseling psikologis kepada ibu hamil yang mengalami gangguan emosional,

seperti kecemasan, ketakutan, dan stres. Konseling ini tidak hanya bertujuan memberikan dukungan emosional, tetapi juga untuk membantu ibu mengembangkan kemampuan adaptif dalam menghadapi kehamilan yang penuh tantangan. Ibu hamil diarahkan untuk mengenali emosi negatifnya dan memperoleh strategi pengelolaan stres yang sehat melalui pendekatan konseling. Upaya ini sangat penting karena kondisi psikologis ibu yang stabil akan berdampak langsung terhadap kesehatan janin dan keberhasilan proses persalinan (Aryaneta, 2024).

c. Koordinasi Rujukan dan Tindakan Medis

Proses rujukan yang tepat dan cepat menjadi salah satu kunci utama untuk mencegah kondisi ibu dan janin semakin memburuk. Tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan penilaian yang cermat terhadap kondisi medis ibu hamil, dan jika diperlukan merujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki layanan spesialisik atau ICU maternal. Proses rujukan ini harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti stabilisasi kondisi ibu, pengaturan transportasi yang aman, serta penyertaan tenaga kesehatan terlatih untuk mendampingi ibu hamil dalam perjalanan menuju fasilitas rujukan (Baso & Boimau, 2024).

Ketepatan dan ketepatan waktu dalam merujuk sangat mempengaruhi keberhasilan penanganan komplikasi. Keterlambatan dalam proses rujukan sering kali berakibat fatal bagi ibu dan bayi, yang dapat menyebabkan tingkat kematian yang lebih tinggi. Sistem rujukan yang baik dan responsif dapat meningkatkan hasil kesehatan bagi ibu hamil dengan komplikasi, serta mengurangi angka kematian maternal dan neonatal. Oleh karena itu, peran tenaga kesehatan dalam koordinasi rujukan dan tindakan medis sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan ibu hamil selama masa kehamilan dan persalinan (Olii et al., 2022).

2. Peran Keluarga

Keluarga berperan sebagai pendukung utama dalam memberikan perhatian, bantuan emosional, serta dukungan fisik kepada ibu hamil. Dukungan keluarga yang optimal dapat meningkatkan kepatuhan ibu terhadap anjuran medis dan mempercepat pemulihan kondisi. Peran keluarga dalam dukungan psikologis ibu hamil yaitu sebagai berikut :

a. Dukungan Emosional

Kehadiran suami dan anggota keluarga lainnya sebagai pendukung emosional memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepercayaan diri, ketenangan, dan kesiapan ibu dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Dukungan ini dapat berupa pendampingan saat pemeriksaan kehamilan,

membantu dalam mempersiapkan kebutuhan bayi, memberikan semangat dan motivasi, serta mendengarkan keluhan ibu. Dengan adanya dukungan emosional yang kuat, ibu hamil dengan komplikasi akan merasa lebih aman, nyaman, dan termotivasi untuk menjaga kesehatan diri dan janinnya (Febriati & Zakiyah, 2022).

Dukungan emosional yang diberikan oleh keluarga juga berkontribusi pada pengurangan tingkat stres yang dialami oleh ibu hamil. Ketika anggota keluarga aktif terlibat dalam proses kehamilan, mereka dapat membantu ibu hamil untuk berbagi perasaan dan kekhawatiran, serta memberikan dorongan positif yang diperlukan. Dukungan emosional yang kuat dapat meningkatkan kesejahteraan mental ibu hamil dan berpengaruh positif terhadap hasil kehamilan, termasuk kesehatan janin. Oleh karena itu, peran keluarga dalam memberikan dukungan emosional sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi ibu hamil dengan komplikasi, sehingga mereka dapat menjalani kehamilan dengan lebih baik dan lebih percaya diri (Kinser et al., 2021).

b. Pengambilan Keputusan Medis

Pengambilan keputusan medis menjadi proses yang harus dilakukan secara cepat dan tepat, terutama dalam situasi kegawatdaruratan seperti perdarahan antepartum, kejang akibat preeklampsia, atau tanda-tanda kegagalan organ. Keputusan untuk segera membawa ibu ke rumah sakit atau menerima tindakan medis darurat harus diambil dengan segera. Keluarga, khususnya suami atau wali terdekat, memiliki tanggung jawab untuk segera merespons situasi dengan membawa ibu ke fasilitas kesehatan serta menyetujui tindakan medis yang diperlukan demi keselamatan ibu dan janin (Dewitt et al., 2023).

Kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan ini dapat menjadi faktor penentu yang menyelamatkan nyawa ibu dan janin, mengingat bahwa setiap detik sangat berharga dalam situasi kritis. Keterlibatan keluarga dalam pengambilan keputusan medis berhubungan erat dengan percepatan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan keberhasilan intervensi obstetri. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi dan informasi yang memadai kepada keluarga tentang tanda-tanda bahaya kehamilan dan prosedur penanganan medis yang mungkin diperlukan, sehingga keluarga dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat saat keadaan darurat terjadi (D'Souza et al., 2022).

c. Pemenuhan Kebutuhan Fisik Ibu

Pemenuhan kebutuhan fisik ibu hamil dengan komplikasi merupakan aspek krusial dalam menjaga kestabilan kondisi kesehatan ibu maupun janin. Bentuk dukungan tersebut meliputi pemberian asupan nutrisi yang adekuat sesuai dengan kondisi medis ibu, memastikan ibu memperoleh waktu istirahat yang cukup, serta membantu pelaksanaan aktivitas sehari-hari yang berpotensi menimbulkan kelelahan. Dukungan fisik yang optimal dapat memperkuat daya tahan tubuh ibu, menjaga kestabilan metabolisme, dan menekan risiko perburukan komplikasi yang terjadi selama masa kehamilan (Okafor & Goon, 2021).

Pendampingan keluarga dalam proses pemeriksaan kehamilan secara berkala turut berperan penting dalam meningkatkan kesadaran ibu terhadap pentingnya kontrol antenatal yang teratur. Partisipasi aktif keluarga dalam mendukung kepatuhan ibu terhadap jadwal pemeriksaan dan terapi medis terbukti dapat meningkatkan luaran kehamilan yang lebih baik. Keterlibatan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan fisik ibu hamil berisiko tinggi berkorelasi positif terhadap peningkatan status kesehatan ibu serta pencegahan komplikasi lanjutan (Barnett et al., 2021).

F. Strategi Implementasi Dukungan Psikologis

Strategi implementasi dukungan psikologis pada ibu hamil dengan komplikasi mencakup pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dukungan psikologis yang tepat dapat membantu ibu mengelola stres, meningkatkan rasa aman, dan memperkuat kesiapan menghadapi proses kehamilan hingga persalinan. Berikut adalah strategi implementasi dukungan psikologis untuk ibu hamil dengan komplikasi yang meliputi :

1. Pendidikan Kesehatan Berbasis Psikoedukasi

Pendidikan kesehatan berbasis psikoedukasi adalah strategi yang sangat efektif dalam memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi medis, termasuk komplikasi yang terjadi selama kehamilan, prosedur medis yang harus dijalani, dan langkah-langkah penanganan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko. Psikoedukasi bertujuan untuk mengurangi kecemasan ibu dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai situasi yang dihadapi. Hal ini menjadikan ibu merasa lebih siap dan lebih mampu menghadapi kondisi kesehatan yang berisiko tinggi (Ningsih & Sakinah, 2021).

Psikoedukasi melibatkan keluarga dalam proses pendidikan, yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung secara emosional dan kognitif. Melalui edukasi keluarga, anggota keluarga, terutama suami dan ibu kandung, dapat lebih memahami kondisi kesehatan ibu hamil serta cara-cara

untuk memberikan dukungan yang tepat. Keterlibatan keluarga yang aktif dalam pemberian dukungan psikologis dapat memperkuat daya tahan mental ibu dan membantu ibu dalam mengelola stres dan kecemasan yang muncul (Fithriany et al., 2020),.

2. Penerapan Model Perawatan Kolaboratif

Penerapan model perawatan kolaboratif merupakan strategi yang bertujuan untuk memberikan dukungan psikologis secara menyeluruh kepada ibu hamil dengan komplikasi melalui kerja sama antarprofesional. Pendekatan ini melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai tenaga kesehatan, seperti dokter spesialis obstetri dan ginekologi, perawat, bidan, serta psikolog klinis, untuk menciptakan suatu sistem dukungan yang komprehensif. Kolaborasi lintas disiplin ini memungkinkan adanya intervensi yang lebih holistik, tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek psikologis yang berperan penting dalam kesejahteraan ibu selama masa kehamilan (Hertati et al., 2022).

Intervensi yang diterapkan dalam model kolaboratif ini meliputi konseling suportif, pelatihan teknik mindfulness, serta wawancara motivasional. Pendekatan ini berkontribusi dalam mengatasi hambatan struktural, seperti stigma terhadap gangguan psikologis pada ibu hamil dan keterbatasan akses ke layanan psikiatri di fasilitas kesehatan primer. Fasilitas pelayanan yang lebih terintegrasi dan mudah dijangkau, model kolaboratif ini meningkatkan kontinuitas perawatan serta memperkuat peran tenaga kesehatan dalam mendukung kesehatan mental ibu hamil dengan komplikasi (Hapsari & Salim, 2023).

3. Pelatihan Strategi Koping Adaptif

Pelatihan strategi koping adaptif merupakan salah satu pendekatan yang dirancang untuk membantu ibu hamil dalam mengembangkan mekanisme koping yang efektif guna mengelola stres dan kecemasan yang muncul akibat komplikasi kehamilan. Ibu hamil diajarkan berbagai teknik koping yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi yang menekan, seperti pemecahan masalah, keterampilan komunikasi yang efektif, dan teknik relaksasi. Dengan menguasai strategi koping yang adaptif, ibu hamil dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis untuk mengurangi risiko gangguan mental selama kehamilan. Pelatihan ini tidak hanya membantu dalam mengurangi tingkat stres, tetapi juga meningkatkan kemampuan ibu untuk menghadapi tantangan yang dihadapi selama masa kehamilan (Chapuis et al., 2022).

Pelatihan strategi koping adaptif dapat dukungan sosial yang penting bagi ibu hamil melalui interaksi dengan sesama peserta pelatihan, ibu hamil dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan emosional yang diperlukan. Lingkungan yang suportif berkontribusi pada pengembangan rasa percaya diri

dan ketahanan mental ibu hamil. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan stres, tetapi juga pada pembentukan jaringan dukungan sosial yang dapat membantu ibu hamil merasa lebih terhubung dan didukung selama masa kehamilan yang penuh tantangan (Yan et al., 2024).

4. Pelaksanaan Konseling Psikologis Terstruktur

Pelaksanaan konseling psikologis terstruktur merupakan salah satu strategi yang efektif dalam memberikan dukungan kepada ibu hamil yang mengalami komplikasi. Konseling secara sistematis dan berkelanjutan dapat membantu ibu hamil dalam mengatasi kecemasan dan depresi yang mungkin muncul selama masa kehamilan. Ibu hamil diberikan ruang untuk mengekspresikan perasaan, dan mendapatkan bimbingan dari profesional yang berpengalaman. Intervensi ini tidak hanya berfokus pada pengurangan gejala psikologis, tetapi juga berupaya untuk meningkatkan keterikatan prenatal antara ibu dan janin, yang merupakan aspek penting dalam perkembangan emosional ibu dan kesehatan janin (Herawati et al., 2023).

Konseling psikologis terstruktur berkontribusi pada perbaikan kesejahteraan emosional secara keseluruhan bagi ibu hamil. Dukungan psikologis yang konsisten menjadikan ibu hamil dapat merasa lebih diperhatikan dan didukung dalam menghadapi tantangan yang dihadapi selama kehamilan. Konseling yang terencana dengan baik dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu, mengurangi perasaan terasing, dan memperkuat hubungan antara ibu dan janin. Intervensi konseling pada masa kehamilan dapat berfungsi sebagai tindakan preventif terhadap depresi postpartum, dan memperbaiki kualitas hubungan ibu-anak di masa mendatang (Reviani et al., 2025).

5. Pemberdayaan Kader Kesehatan

Pemberdayaan kader kesehatan berfokus pada edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin. Kader kesehatan dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai tanda-tanda bahaya selama kehamilan, serta mendorong ibu untuk mematuhi jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan. Kader menjadi sumber informasi terpercaya dalam komunitas dan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perawatan antenatal yang holistik, termasuk aspek psikologis (Sunaryo et al., 2022).

Kader kesehatan berfungsi sebagai jembatan antara ibu hamil dan layanan kesehatan, membantu dalam deteksi dini masalah kesehatan yang mungkin timbul. Pendampingan yang dilakukan oleh kader kesehatan yang terlatih, ibu hamil dapat merasa lebih didukung dan terawasi selama masa kehamilan mereka. Dengan adanya kader yang aktif, ibu hamil dapat lebih mudah mengakses

informasi dan dukungan yang diperlukan, sehingga dapat mengurangi kecemasan yang sering kali menyertai kehamilan dengan komplikasi (Meo et al., 2024).

G. Studi Kasus atau Data Penunjang

Studi Kasus pada Ny. D dengan Hiperemesis Gravidarum Berat dan Kecemasan Tinggi.

1. Kasus

Ny. D, seorang ibu hamil berusia 27 tahun, sedang mengandung anak pertama pada usia kehamilan 8 minggu. Ny.D mengalami hiperemesis gravidarum yang berat, dengan mual dan muntah yang terjadi lebih dari 5 kali sehari. Kondisi ini menyebabkan Ny. D merasa sangat lemas, tidak nafsu makan, mengalami dehidrasi, dan penurunan berat badan. Ny. D juga merasa sangat cemas dan takut akan keselamatan bayinya karena ia tidak dapat makan dengan baik dan khawatir akan kekurangan nutrisi. Ny.D juga merasa terisolasi karena tidak dapat beraktivitas seperti biasa dan harus terus-menerus beristirahat.

2. Identifikasi Kasus

- a. Nama : Ny. D
- b. Usia : 27 tahun
- c. Usia Kehamilan : 8 minggu
- d. Riwayat Obstetri : G1P0A0
- e. Keluhan : Mual dan muntah yang berlebihan, penurunan berat badan, dehidrasi, kelelahan, kecemasan tinggi.

3. Data Penunjang

- a. Pemeriksaan Fisik : Tanda-tanda dehidrasi (mata cekung, turgor kulit menurun), penurunan berat badan 7 kg dalam 2 minggu terakhir, tekanan darah rendah (90/60 mmHg), denyut nadi meningkat (110 bpm).
- b. Pemeriksaan Laboratorium : Ketidakseimbangan elektrolit (hipokalemia, hipokloremia), ketonuria, peningkatan kadar BUN (Blood Urea Nitrogen) dan kreatinin.
- c. Skrining Kecemasan : Beck Anxiety Inventory (BAI) skor 32 (kecemasan berat).
- d. Wawancara Psikologis : Ny. D mengungkapkan perasaan cemas yang berlebihan tentang keselamatan bayinya, ketidakmampuan untuk menikmati kehamilan, perasaan bersalah karena tidak dapat makan dengan baik, dan perasaan terisolasi karena tidak dapat beraktivitas seperti biasa.

4. Diagnosa Medis

Hiperemesis Gravidarum Berat dan Gangguan Kecemasan

5. Implementasi

a. Peran Tenaga Kesehatan

1) Deteksi Dini Komplikasi :

- Dokter melakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk menilai tingkat dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan fungsi ginjal.
- Psikolog melakukan skrining kecemasan menggunakan BAI dan wawancara psikologis untuk mendeteksi gangguan kecemasan dan mengidentifikasi faktor-faktor pemicu.

2) Edukasi Dini dan Konseling :

- Dokter, bidan dan perawat memberikan edukasi tentang hiperemesis gravidarum, penyebabnya, perjalanan penyakit, dan pilihan-pilihan penanganan yang tersedia.
- Ahli gizi memberikan konseling tentang diet yang mudah dicerna, tinggi nutrisi, dan strategi untuk mengatasi mual dan muntah (misalnya, makan sedikit tapi sering, menghindari makanan yang berlemak dan pedas, mengonsumsi jahe).
- Psikolog memberikan konseling tentang teknik relaksasi (misalnya, pernapasan dalam, visualisasi), manajemen stres, dan mengatasi pikiran-pikiran negatif (misalnya, *cognitive restructuring*).

3) Koordinasi Rujukan Dan Tindakan Medis :

- Dokter memberikan resep obat antiemetik yang aman untuk kehamilan (misalnya, doksilamin dan piridoksin).
- Dokter merujuk Ny. D untuk rawat inap dan pemberian cairan intravena untuk mengatasi dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit.
- Psikolog memberikan terapi kognitif perilaku (CBT), untuk mengatasi gangguan kecemasan, dengan fokus pada identifikasi dan modifikasi pikiran-pikiran negatif serta pengembangan strategi coping yang adaptif.

b. Peran Keluarga

1) Dukungan emosional :

- Suami Ny. D selalu mendampingi istrinya dalam setiap kunjungan ke dokter dan memberikan dukungan verbal yang positif dan meyakinkan.
- Keluarga (terutama suami dan orang tua) memberikan dukungan emosional, mendengarkan keluhan Ny. D tanpa menghakimi, dan meyakinkan bahwa Ny. D tidak sendirian dan bahwa mereka akan selalu ada untuk membantunya.

2) Pengambilan keputusan medis :

- Suami Ny. D terlibat aktif dalam setiap pengambilan keputusan medis terkait perawatan kehamilan istrinya, dengan mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
- Keluarga membantu Ny. D dalam mencari informasi yang akurat dan terpercaya tentang kondisi kehamilannya dan pilihan-pilihan perawatan yang tersedia.

3) Pemenuhan Kebutuhan Fisik Ibu :

- Suami Ny. D membantu menyiapkan makanan yang mudah dicerna dan disukai oleh istrinya, serta memastikan Ny. D mendapatkan cairan yang cukup.
- Keluarga memastikan Ny. D mendapatkan istirahat yang cukup dan lingkungan yang tenang, serta membantu mengurus pekerjaan rumah tangga agar Ny. D dapat fokus pada pemulihan.

6. Hasil dan Evaluasi

Hasil penanganan yang komprehensif selama 6 minggu pada Ny. D, menunjukkan kemajuan signifikan. Mual dan muntah berangsur-angsur mereda, memungkinkan Ny. D untuk meningkatkan asupan makanan dan cairan, yang tercermin dalam peningkatan berat badan dan perbaikan tanda-tanda dehidrasi serta ketidakseimbangan elektrolit. Skor BAI menurun menjadi 12, mengindikasikan penurunan tingkat kecemasan menjadi ringan. Ny. D melaporkan perasaan yang lebih tenang, peningkatan kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menikmati kehamilannya, serta secara bertahap dapat kembali beraktivitas ringan dan berinteraksi sosial.

7. Kesimpulan Kasus

Studi kasus ini menegaskan pentingnya dukungan psikologis yang terintegrasi dengan perawatan medis bagi ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum berat dan gangguan kecemasan. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan pasien sangat penting untuk mencapai hasil positif, yang menghasilkan peningkatan kesehatan fisik, penurunan kecemasan, dan kemampuan ibu untuk menikmati kehamilan dengan lebih baik. Pendekatan terpadu ini dapat menjadi model untuk perawatan ibu hamil dengan kondisi serupa, menekankan perlunya dukungan komprehensif untuk kesehatan fisik dan mental selama kehamilan.

H. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Dukungan psikologis merupakan elemen fundamental dalam perawatan ibu hamil dengan disertai komplikasi. Komplikasi seperti hiperemesis gravidarum, preeklamsia, diabetes gestasional, maupun kondisi medis lainnya tidak hanya menimbulkan risiko fisik, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kesehatan mental ibu. Beban emosional yang menyertai kondisi tersebut, seperti rasa cemas, takut, stres, dan ketidakpastian, dapat mengganggu adaptasi psikologis ibu dalam menjalani kehamilan.

Pemberian dukungan psikologis yang efektif sangat diperlukan melalui pendekatan multidisiplin yang melibatkan tenaga kesehatan, keluarga, serta lingkungan sosial. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dini terhadap gejala stres dan gangguan psikologis, memberikan edukasi yang sesuai, serta merujuk ibu hamil apabila diperlukan. Intervensi psikologis membantu ibu mengelola emosi, memperbaiki mekanisme koping, dan meningkatkan kepercayaan diri. Pendekatan tersebut memungkinkan ibu untuk memperoleh ruang aman dalam mengekspresikan perasaannya dan mengembangkan strategi adaptif dalam menghadapi komplikasi kehamilan yang dialaminya.

Keterlibatan peran keluarga berperan besar dalam menciptakan lingkungan yang suportif secara emosional. Kehadiran dan perhatian keluarga dapat meningkatkan ketenangan, memperkuat ikatan emosional, dan membantu ibu merasa lebih dihargai serta tidak sendirian dalam menghadapi tantangan kehamilan. Dukungan psikologis yang diberikan secara konsisten dan terstruktur akan berdampak positif tidak hanya terhadap kondisi psikologis ibu, tetapi juga terhadap hasil kehamilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, integrasi dukungan psikologis dalam pelayanan antenatal perlu menjadi bagian dari standar perawatan ibu hamil dengan komplikasi, untuk memastikan kesejahteraan mental dan fisik ibu serta janin secara menyeluruh.

2. Rekomendasi

a. Pemantauan dan Evaluasi Secara Rutin

Ibu hamil dengan komplikasi memerlukan pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dibandingkan kehamilan normal. Pemantauan ini meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan laboratorium, evaluasi kesejahteraan janin melalui USG, serta pemantauan status klinis secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dini perubahan kondisi yang dapat membahayakan ibu maupun janin, sehingga intervensi dapat

dilakukan segera untuk mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut (Brown et al., 2022b).

b. Edukasi Kesehatan Berkesinambungan

Edukasi kesehatan yang berkesinambungan sangat penting bagi ibu hamil dengan komplikasi untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai kondisi kehamilan dan cara pengelolaan komplikasi yang dialami. Edukasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman individu agar ibu hamil dapat lebih aktif dalam merawat diri serta mengenali gejala yang memerlukan perhatian medis segera. Dengan edukasi yang tepat, ibu hamil akan lebih sadar dan patuh terhadap perawatan, yang dapat mengurangi risiko komplikasi serius bagi ibu dan janin (Glick et al., 2021).

c. Kolaborasi Tim Interprofesional

Kolaborasi tim interprofesional antara dokter, bidan, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya sangat penting dalam memberikan penanganan yang komprehensif bagi ibu hamil dengan komplikasi. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan setiap profesional kesehatan untuk memberikan kontribusi sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga seluruh aspek kesehatan ibu, baik fisik maupun psikologis, dapat ditangani secara terpadu dan efektif. Pendekatan tim interprofesional yang terkoordinasi dengan baik dapat mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan kepuasan pasien (Hapsari & Salim, 2023).

d. Menyesuaikan Terapi Medis dengan Kondisi Klinis

Terapi medis yang diberikan kepada ibu hamil dengan komplikasi harus disesuaikan dengan diagnosis dan tingkat keparahan kondisi klinis yang dihadapi. Penggunaan obat-obatan seperti antihipertensi, insulin, atau agen tocolitik perlu dilakukan dengan pemantauan yang ketat guna mencegah terjadinya efek samping yang merugikan bagi ibu dan janin. Penyesuaian terapi harus mempertimbangkan perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan, yang dapat mempengaruhi metabolisme dan respons tubuh terhadap obat. Oleh karena itu, kolaborasi antara dokter spesialis kandungan, spesialis penyakit dalam, serta tenaga medis lainnya sangat penting untuk memastikan terapi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klinis, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi ibu dan janin (Baso & Boimau, 2024).

e. Mempersiapkan Persalinan dan Sistem Rujukan

Perencanaan persalinan pada ibu hamil dengan komplikasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin timbul akibat kondisi kehamilan yang dialami. Persalinan sebaiknya dilakukan di

fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan untuk menangani situasi obstetri emergensi, untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat apabila terjadi komplikasi. Sistem rujukan harus disiapkan dengan matang dan berfungsi secara efektif, agar ibu dan bayi dapat segera dipindahkan ke fasilitas yang lebih memadai apabila diperlukan. Kolaborasi yang baik antar tenaga medis dan koordinasi sistem rujukan yang efisien sangat penting untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan (Olii et al., 2022).

I. Penutup

Kehamilan dengan komplikasi tidak hanya menimbulkan tantangan fisik, tetapi juga beban psikologis yang signifikan, sehingga dukungan yang tepat dan terpadu sangat diperlukan untuk memastikan kesejahteraan ibu dan janin. Dampak komplikasi terhadap kesehatan mental ibu, jenis-jenis dukungan psikologis yang dibutuhkan, peran tenaga kesehatan dan keluarga, serta strategi implementasi dukungan psikologis yang efektif. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek tersebut, diharapkan pembaca dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup ibu hamil dengan komplikasi.

Peran tenaga kesehatan sangat krusial dalam melakukan deteksi dini terhadap masalah psikologis, memberikan edukasi yang sesuai, serta merujuk ibu hamil ke layanan yang lebih spesialis jika diperlukan. Kemampuan tenaga kesehatan dalam membangun hubungan terapeutik dengan ibu hamil juga sangat penting untuk menciptakan rasa percaya dan aman, sehingga ibu hamil merasa nyaman untuk berbagi perasaan dan kekhawatiran mereka.

Keluarga terutama suami, memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memberikan dukungan emosional dan praktis kepada ibu hamil dengan komplikasi. Kehadiran dan perhatian keluarga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan ibu hamil, serta meningkatkan motivasi mereka untuk menjaga kesehatan diri dan janin. Oleh karena itu, edukasi dan pemberdayaan keluarga juga menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan dukungan psikologis bagi ibu hamil dengan komplikasi.

Strategi implementasi dukungan psikologis yang diuraikan dalam buku ini, seperti pendidikan kesehatan berbasis psikoedukasi, penerapan model perawatan kolaboratif, pelatihan strategi koping adaptif, pelaksanaan konseling psikologis terstruktur, dan pemberdayaan kader kesehatan, diharapkan dapat menjadi panduan bagi penyedia layanan kesehatan dalam merancang program dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Studi kasus yang disajikan dalam buku ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana dukungan psikologis yang terintegrasi dapat memberikan dampak positif bagi ibu hamil dengan komplikasi. Pembaca dapat belajar mengenai pentingnya pendekatan individual dalam memberikan dukungan, serta bagaimana kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan pasien dapat menghasilkan perubahan yang signifikan.

Penulis berharap bahwa buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perawatan ibu hamil dengan komplikasi. Dengan pemahaman dan implementasi yang tepat, dukungan psikologis dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan kehamilan yang sehat dan bahagia bagi setiap ibu, serta memberikan dampak positif bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Referensi

- Alves, A. C., Cecatti, J. G., & Souza, R. T. (2021). Resilience and Stress During Pregnancy: A Comprehensive Multidimensional Approach in Maternal and Perinatal Health. *Scientific World Journal*. <https://doi.org/10.1155/2021/9512854>
- Anandita, Y. R. M., & Gustina, I. (2021). Peningkatan Edukasi Tentang Kehamilan Risiko Tinggi Pada Kader Kesehatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Parahita*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54771/jpmbp.v2i01.202>
- Anvarovich, A. S. (2025). The Role and Importance of Modern Computer Technologies in the Diagnosis and Treatment of Neurological Diseases Among Adolescents. *International Journal of Medical Sciences and Clinical Research*, 5(3), 7–11. <https://doi.org/10.37547/ijmscr/Volume05Issue03-02>
- Aryaneta, Y. (2024). Pendampingan Kelas Ibu Hamil dalam Memberikan Motivasi ANC Berkualitas, Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Janin. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 1(2).
- Azizah, N., Eka Rahmawati, V., Triloka Wulandari, D., & Widaryanti, Y. (2024). Edukasi Antenatal Care Terpadu Sebagai Upaya Deteksi Dini Terjadinya Komplikasi pada Ibu Hamil di Puskesmas Mayangan Jogoroto Jombang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 53–59. <http://journal.ahmareduc.or.id/index.php/>
- Barakat, S., McLean, S. A., Bryant, E., Le, A., Marks, P., Aouad, P., Barakat, S., Boakes, R., Brennan, L., Bryant, E., Byrne, S., Caldwell, B., Calvert, S., Carroll, B., Castle, D., Caterson, I., Chelius, B., Chiem, L., Clarke, S., ... Touyz, S. (2023). Risk Factors For Eating Disorders: Findings From a Rapid Review. In *Journal of Eating Disorders* (Vol. 11, Issue 1). BioMed Central Ltd. <https://doi.org/10.1186/s40337-022-00717-4>
- Barnett, E. R., Knight, E., Herman, R. J., Amarakaran, K., & Jankowski, M. K. (2021). Difficult Binds: A Systematic Review of Facilitators and Barriers to Treatment Among Mothers with Substance Use Disorders. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 126. <https://doi.org/10.1016/j.jsat.2021.108341>
- Baso, N., & Boimau, S. V. (2024). Pemberdayaan Kader Posyandu Upaya Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan Menggunakan Community Screening Card Pada Ibu Hamil di Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1). <https://asthadarma.unmerbaya.ac.id/index.php/asthadarma/index>
- Brieger, K. K., Bakulski, K. M., Pearce, C. L., Baylin, A., Dou, J. F., Feinberg, J. I., Croen, L. A., Hertz-Picciotto, I., Newschaffer, C. J., Fallin, M. D., & Schmidt, R. J. (2022). The Association of Prenatal Vitamins and Folic Acid Supplement Intake with Odds of Autism Spectrum Disorder in a High-Risk Sibling Cohort, the Early Autism Risk Longitudinal Investigation (EARLI). *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 52(6), 2801–2811. <https://doi.org/10.1007/s10803-021-05110-9>
- Brown, W. J., Hayman, M., Haakstad, L. A. H., Lamerton, T., Mena, G. P., Green, A., Keating, S. E., Gomes, G. A. O., Coombes, J. S., & Mielke, G. I. (2022b). Australian Guidelines for Physical Activity in

Pregnancy and Postpartum. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 25(6), 511–519.
<https://doi.org/10.1016/j.jsams.2022.03.008>

- Cederlof, E. T., Lundgren, M., Lindahl, B., & Christersson, C. (2022). Pregnancy Complications and Risk of Cardiovascular Disease Later in Life: A Nationwide Cohort Study. *Journal of the American Heart Association*, 11(2). <https://doi.org/10.1161/JAHA.121.023079>
- Chapuis, S. A., Moret-Tatay, C., de Paula, T. A., Irigaray, T. Q., Antonello, I. C. F., & da Costa, B. E. P. (2022). Psychological Factors and Coping Strategies in Pregnancies Complicated by Hypertension: A Cluster-Analytic Approach. *Journal of Affective Disorders*, 296, 89–94.
<https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.09.049>
- Conrad, M. (2024). Health Information-Seeking Internet Behaviours Among Pregnant Women: a Narrative Literature Review. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 42(2), 194–208.
<https://doi.org/10.1080/02646838.2022.2088711>
- Davis, M. B., Arendt, K., Bello, N. A., Brown, H., Briller, J., Epps, K., Hollier, L., Langen, E., Park, K., Walsh, M. N., Williams, D., Wood, M., Silversides, C. K., & Lindley, K. J. (2021). Team-Based Care of Women With Cardiovascular Disease From Pre-Conception Through Pregnancy and Postpartum. *Journal of the American College of Cardiology*, 77(14), 1763–1777.
<https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.02.033>
- Dewitt, S., Jafari-Sadeghi, V., Sukumar, A., Aruvanahalli Nagaraju, R., Sadraei, R., & Li, F. (2023). Family dynamics and relationships in female entrepreneurship: an exploratory study. *Journal of Family Business Management*, 13(3), 626–644. <https://doi.org/10.1108/JFBM-01-2022-0013>
- Diabelkova, J., Rimarová, K., Dorko, E., Urdzík, P., Houžvičková, A., & Argalášová, Ľ. (2023). Adolescent Pregnancy Outcomes and Risk Factors. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(5). <https://doi.org/10.3390/ijerph20054113>
- D'Souza, P., Bailey, J. V., Stephenson, J., & Oliver, S. (2022). Factors Influencing Contraception Choice and Use Globally: A Synthesis of Systematic Reviews. *European Journal of Contraception and Reproductive Health Care*, 27(5), 364–372.
<https://doi.org/10.1080/13625187.2022.2096215>
- Febriati, L. D., & Zakiyah, Z. (2022). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Adaptasi Perubahan Psikologis Pada Ibu Hamil. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 13(1).
<https://doi.org/10.36419/jki.v13i1.561>
- Fithriany, Yuniwati, C., & Dewi, S. (2020). Pengaruh Psikoedukasi Terhadap Kadar Hormon Kortisol Pada Ibu Tujuan Dengan Depresi Postartum di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Langsa Tahun 2020. *Jurnal Health Sains*, 11, 3.

- Glick, I., Kadish, E., & Rottenstreich, M. (2021). Management of Pregnancy in Women of Advanced Maternal Age: Improving Outcomes for Mother and Baby. *International Journal of Women's Health*, 13, 751–759. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S283216>
- Hapsari, T. P., & Salim, L. A. (2023). Efektivitas Asuhan Antenatal Sebagai Upaya Untuk Mencegah Komplikasi Obstetri Yang Berdampak Terhadap Kematian Ibu: Literature Review. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat*, 12.
- Herawati, T., Kasiati, & Pertami, S. B. (2023). Integrasi Modul Edukasi Berbasis Cetak dan Terapi Berpikir Positif Dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Perilaku Pencegahan Hipertensi pada Ibu Hamil. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, 09(03). <https://doi.org/https://doi.org/10.31290/jiki.v9i3.5243>
- Hertati, D., Siti Nurdianti, D., & Dasuki, D. (2022). The Comparison Between The Implementation Of Collaborative Care In Postpartum Period And Postartum Blues Incidences In Sewon I & Banguntapan II Primary Health Centers Of Bantul District In 2020. *Jurnal Surya Medika*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jsm.vxix.xxx>.
- Hijazi, H. H., Alyahya, M. S., Al Abdi, R. M., Alolayyan, M. N., Sindiani, A. M., Raffee, L. A., Baniissa, W. A., & Al Marzouqi, A. M. (2021). The Impact of Perceived Social Support During Pregnancy on Postpartum Infant-Focused Anxieties: A Prospective Cohort Study of Mothers in Northern Jordan. *International Journal of Women's Health*, 13, 973–989. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S329487>
- Horsch, A., Garthus-Niegel, S., Ayers, S., Chandra, P., Hartmann, K., Vaisbuch, E., & Lalor, J. (2024). Childbirth-related posttraumatic stress disorder: definition, risk factors, pathophysiology, diagnosis, prevention, and treatment. In *American Journal of Obstetrics and Gynecology* (Vol. 230, Issue 3, pp. S1116–S1127). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2023.09.089>
- Insani, U., & Supriatun, E. (2021). Family Support Related to Information, Comfort, Economy and Spiritual in Preeclampsic Pregnancy Care: Qualitative Exploration. *Jurnal Keperawatan*, 12(1), 42–52. <https://doi.org/10.22219/jk.v12i1.13638>
- Kazemi, A., Aslani, A., & Hajian, S. (2021). Association between Perceived Social Support and Health-Promoting lifestyle in Pregnant Women: A Cross-Sectional Study. *Journal of Caring Sciences*, 10(2), 96–102. <https://doi.org/10.34172/jcs.2021.018>
- Khadivzadeh, T., Shojaeian, Z., & Sahebi, A. (2023). High Risk-pregnant Women's Experiences of Risk Management: A Qualitative Study. *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery*, 11(1), 57–66. <https://doi.org/10.30476/ijcbnm.2022.96781.2148>
- Khoury, J. E., Atkinson, L., Bennett, T., Jack, S. M., & Gonzalez, A. (2021). COVID-19 and Mental Health During Pregnancy: The Importance of Cognitive Appraisal and Social Support. *Journal of Affective Disorders*, 282, 1161–1169. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.01.027>
- Kinser, P. A., Jallo, N., Amstadter, A. B., Thacker, L. R., Jones, E., Moyer, S., Rider, A., Karjane, N., & Salisbury, A. L. (2021). Depression, Anxiety, Resilience, and Coping: The Experience of Pregnant and

New Mothers during the First Few Months of the Covid-19 Pandemic. *Journal of Women's Health*, 30(5), 654–664. <https://doi.org/10.1089/jwh.2020.8866>

- Kuppusamy, P., & Prusty, R. K. (2023). High-risk pregnancy in India : Prevalence and contributing risk factors – a national survey-based analysis. *Global Health*, 13(04116), 1–10. <https://doi.org/10.7189/jogh.13.04116>
- Law, S., Ormel, I., Babinski, S., Plett, D., Dionne, E., Schwartz, H., & Rozmovits, L. (2021). Dread and Solace: Talking About Perinatal Mental Health. *International Journal of Mental Health Nursing*, 30(S1), 1376–1385. <https://doi.org/10.1111/inm.12884>
- Martinez, S., Rodriguez-Almagro, J., Hernandez-Martínez, A., Delgado-Rodríguez, M., & Martínez-Galiano, J. M. (2021). Long-Term High Risk of Postpartum Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) and Associated Factors. *Journal of Clinical Medicine*, 10(3), 1–12. <https://doi.org/10.3390/jcm10030488>
- Meo, M. L. N., Rotty, M. P. F., & Mapaly, H. A. (2024). Enhancing the Role of Posyandu Cadres in Early Detection and Support for High-Risk Pregnant Women through a Psychoeducation Approach. *Journal of Community Empowerment for Health*, 7(2), 96. <https://doi.org/10.22146/jcoemph.90252>
- Moafi, F., Momeni, M., Tayeba, M., Rahimi, S., & Hajnasiri, H. (2021). Spiritual Intelligence and Post-abortion Depression: A Coping Strategy. *Journal of Religion and Health*, 60(1), 326–334. <https://doi.org/10.1007/s10943-018-0705-0>
- Navon, M., & Taubman, O. (2023). Psychological Well-being during Pregnancy: The Contribution of Stress Factors and Maternal-Fetal Bonding. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*. <https://doi.org/10.1080/02646838.2023.2222143>
- Ningsih, D. A., & Sakinah, I. (2021). The Effect of Development of a Psychoeducation Guidebook in the Management on Postpartum Depression Symptoms. *International Journal of Nursing and Health Services*, 4(3), 2654–6310. <https://doi.org/10.35654/ijnhs.v4i3.4>
- Ogueji, I. A. (2021). Experiences and Predictors of Psychological Distress in Pregnant Women Living with HIV. *British Journal of Health Psychology*, 26(3), 882–901. <https://doi.org/10.1111/bjhp.12510>
- Okafor, U. B., & Goon, D. Ter. (2021). Physical Activity in Pregnancy: Beliefs, Benefits, and Information-Seeking Practices of Pregnant Women in South Africa. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 14, 787–798. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S287109>
- O'Kelly, A. C., Michos, E. D., Shufelt, C. L., Vermunt, J. V., Minissian, M. B., Quesada, O., Smith, G. N., Rich-Edwards, J. W., Garovic, V. D., El Khoudary, S. R., & Honigberg, M. C. (2022). Pregnancy and Reproductive Risk Factors for Cardiovascular Disease in Women. *Journal of the American Heart Association*, 13(4), 652–672. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.319895>

- Olii, N., Claudia, J. G., Yanti, F. D., Abdul, N. A., Tompunuh, M. M., Suherlin, I., & Luawo, H. P. (2022). Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 6(1), 227. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6285>
- Pearce, J., & Ellis, S. (2022). Overweight, obesity and excessive weight gain in pregnancy as risk factors for adverse pregnancy outcomes: A narrative review. In *Journal of Human Nutrition and Dietetics* (Vol. 35, Issue 2, pp. 250–264). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1111/jhn.12999>
- Piccinini, C. R. P., Almeida, V. de C., Ezequiel, O. da S., Fajardo, E. F. de M., & Lucchetti, G. (2021). Religiosity/Spirituality and Mental Health and Quality of Life of Early Pregnant Women. *Journal of Religion and Health*, 60(3), 1908–1923. <https://doi.org/10.1007/s10943-020-01124-2>
- Prajapati, A. K., Kumar, V., Soni, K., Singh, N. P., Jain, P. K., & Ruchi. (2022). Prevalence of High-Risk Pregnancy Among Pregnant Women Enrolled Under Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in government health facilities of district Etawah, Uttar Pradesh. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 11(5), 1876–1882. https://doi.org/10.4103/jfmprc.jfmprc_1636_21
- Pratiwi, C. S., & Khairani, N. (2023). Distress Psikologis pada Ibu Hamil Dengan Hipertensi Gestasional: Scoping review. *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, 7(1), 43–55. <https://doi.org/10.32536/jrki.v7i1.249>
- Ratnaningtyas, M. A., & Indrawati, F. (2023). Karakteristik Ibu Hamil dengan Kejadian Kehamilan Risiko Tinggi. *Journal Of Public Health Research and Development*, 7(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294 /higeia/v7i3/64147>
- Reviani, N., Sumarwan, U., Herawati, T., & Yuliati, L. N. (2025). Hubungan Gejala Stres, Religiusitas, dan Strategi Koping dengan Kesejahteraan Subjektif Keluarga pada Kehamilan Tidak Diinginkan. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 13(1). <https://doi.org/10.29210/1141600>
- Rukina, R., & Pangastuti, D. (2022). Tingkat Pengetahuan Terhadap Ibu Hamil Resiko Tinggi Melalui Kompetensi Soft Skill dan Kinerja Petugas Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(2), 367–377. <https://doi.org/https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i2.780>
- shoib, S., Arif, N., Nahidi, M., Rumiyya, K., Swed, S., & Yusha’u Armiya’u, A. (2022). Nagorno-Karabakh Conflict: Mental Health Repercussions and Challenges in Azerbaijan. *Asian Journal of Psychiatry*, 73. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2022.103095>
- Siahaan, G., & Maghfirah, A. (2023). Hubungan Keteraturan Kunjungan Antenatal Care (ANC) Terhadap Deteksi Dini Risiko Tinggi Ibu Hamil Trimester III Dengan Menggunakan Kartu Skor Poeji Rochjati (KSPR) di Wilayah Kerja Puskesmas Rawasari Jambi. *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory*, 6(2). <https://jurnal.syedzasaintika.ac.id>
- Sunaryo, S., Isnani, T., Lestari, E., Apriliana, S., & Sari, I. Z. R. (2022). Implementation of Assistance for One Pregnant Woman One Cadre (OPOC) in Banjarnegara District, Central Java Province,

Indonesia. *African Journal of Reproductive Health*, 26(7), 83–89.
<https://doi.org/10.29063/ajrh2022/v26i7.9>

- Teskereci, G., Akgun, M., & Boz, İ. (2022). The Precursors's Adaptation to Pregnancy, Prenatal Attachment and Maternal Self-Confidence. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 42(8), 3552–3559.
<https://doi.org/10.1080/01443615.2022.2158312>
- Turesheva, A., Aimagambetova, G., Ukybassova, T., Marat, A., Kanabekova, P., Kaldygulova, L., Amanzholkyzy, A., Ryzhkova, S., Nogay, A., Khamidullina, Z., Ilmaliyeva, A., Almawi, W. Y., & Atageldiyeva, K. (2023). Recurrent Pregnancy Loss Etiology, Risk Factors, Diagnosis, and Management. Fresh Look into a Full Box. *Journal of Clinical Medicine*, 12(12).
<https://doi.org/10.3390/jcm12124074>
- Urbanova, E., Skodova, Z., & Baskova, M. (2021). The Association Between Birth Satisfaction and The Risk of Postpartum Depression. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(19). <https://doi.org/10.3390/ijerph181910458>
- Utama, R. P. (2021). Status Gizi dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(2), 689–694. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.680>
- Van, er Z. den B. A. I., Boere-Boonekamp, M. M., Groothuis-Oudshoorn, C. G. M., & Reijneveld, S. A. (2021). Postpartum Depression and Anxiety: A Community-Based Study on Risk Factors Before, During and After Pregnancy. *Journal of Affective Disorders*, 286, 158–165.
<https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.02.062>
- Wicaksana, I. P. A., Ahmad, S. A., Rika, A. P. M., Maswan, M., & Budi, A. M. (2024). Hubungan Dukungan Suami, Status Gravida, dan Kepatuhan Ibu Melakukan Antenatal Care (ANC) terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(6).
- Yan, S., Fan, W., Ma, Y., Xie, S., Li, R., Lan, Y., Xie, L., & Jing, J. (2024). Pregnant Women's Dyadic Coping and Associated Factors: A Cross-Sectional Study Utilizing Latent Profile Analysis. *International Journal of Women's Health*, 16, 1009–1022.
<https://doi.org/10.2147/IJWH.S458763>

Glosarium

A

Antenatal Care (ANC) : Pemeriksaan kehamilan rutin.

B

Beck Anxiety Inventory (BAI) : Skrining untuk mengukur tingkat kecemasan.

Blood Urea Nitrogen (BUN) : Ukuran urea nitrogen dalam darah.

C

Cognitive Restructuring : Teknik mengubah pikiran negatif.

D

Dukungan Instrumental : Bantuan praktis, contohnya transportasi.

Dukungan Profesional : Bantuan dari tenaga medis terlatih.

H

Hiperemesis Gravidarum : Mual muntah berlebihan saat hamil.

Hipokalemia : Kekurangan kalium dalam darah.

Hipokloremia : Kekurangan klorida dalam darah.

K

Ketonuria : Keton dalam urine.

Kolaborasi Interprofesional : Kerja sama antar tenaga kesehatan.

Koping Adaptif : Strategi efektif mengatasi stres.

M

Mindfulness : Teknik relaksasi fokus pada saat ini.

Morbiditas : Tingkat kejadian penyakit.

Mortalitas : Tingkat kematian.

P

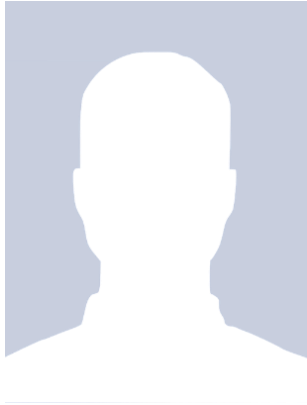
Preeklamsia : Kehamilan dengan tekanan darah tinggi.

Psikoedukasi : Pendidikan tentang kondisi medis.

T

Terapi Kognitif Perilaku (CBT) : Terapi mengubah pikiran dan perilaku.
Tocolitik : Obat penunda persalinan prematur.

Profil Penulis



Dr. Surmiasih, S.Kep., Ners., M.Kes

Lahir di Gisting, 30 September 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, STIKes Mitra Lampung tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat pada Universitas Mitra Lampung dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 pada program Studi Ilmu Biomedik pada Universitas Sebelas Maret dan lulus pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 di STIKes Aisyah Pringsewu Lampung dan saat ini telah menjadi

Universitas Aisyah Lampung pada Program Studi Keperawatan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Aisyah Pringsewu Lampung mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, dan Keperawatan Kesehatan Reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya. Penulis juga telah menghasilkan beberapa buku baik buku saku maupun buku referensi diantaranya **“Hipertensi pada Kehamilan, Waspada! Komplikasi Kehamilan dan Persalinan, Seputar TORCH pada Kehamilan (Pemahaman dan Pencegahan)”**. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:



Bdn. Yaumil Fauziah, S.Tr.Keb., M.Keb.

Lahir di Garoga, pada 15 September 1993. Penulis putri ketiga dari Bapak Irsan Pasaribu, S.Pd dan Ibu Maslaini, S.Pd. Penulis Dosen Tetap Pada Program Studi Pendidikan Profesi Bidan di STIKes Flora Medan. Telah Menyelesaikan Pendidikan D-III Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Medan Prodi Kebidanan Padangsidempuran, D-IV Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan, Magister Kebidanan di Universitas Andalas Tahun 2023. Pada Tahun 2023 sampai dengan saat ini penulis bekerja

sebagai dosen pengajar di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan di STIKes Flora Medan. Kemudian melanjutkan Pendidikan Profesi Bidan di STIKes Senior Medan selesai pada tahun 2024. Saat ini penulis aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengabdian masyarakat serta mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dan *workshop* bertujuan untuk menambah wawasan dan informasi-informasi yang up to date sebagai wujud menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di dalam bidang kebidanan dan yang lainnya. Ada beberapa buku yang sudah diterbitkan oleh penulis

pada tahun 2024 dengan judul Konsep Asuhan Kebidanan, Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kebidanan Komplementer. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa dan tenaga kesehatan khususnya kebidanan dan kepada masyarakat pada umumnya.



Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes.

lahir di Jombang Jawa Timur, 15 Maret 1963. Lulus Akper Soetomo Surabaya tahun 1992. Tahun 1994 lulus program Bidan di Akper Sutopo Surabaya, lulus dari PSIK UNPAD Bandung tahun 2000, menyelesaikan Magister KIA Kespro di UGM Jogjakarta tahun 2007. Terakhir mengikuti Pendidikan Doktorat Kesehatan di UNAIR tahun 2016. Penulis tinggal di Kabupaten Jombang Prov. Jatim. Karir penulis diawali mulai sebagai ASN di DinKes Kabupaten Jombang dan ditempatkan di Puskesmas tahun 1984 sampai 1994, selanjutnya pindah ke SPK Pemkab Jombang sampai tahun 2006. Tahun 2016 pindah ke Departemen Riset dan Teknologi dan ditempatkan di Stikes Pemkab Jombang dengan tugas tambahan sebagai Kaprodi Sarjana Keperawatan, tahun 2016 sebagai Wakil 1 Bidang Akademik sampai tahun 2023, saat ini sebagai dosen Prodi S 1 Keperawatan Stikes Pemkab Jombang dengan jabatan fungsional Lektor. Penulis memberikan kuliah Maternitas, manajemen dan Metodologi, serta membimbing mahasiswa profesi ners. Aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis tersertifikasi dosen dan aktif sebagai fasilitator kegiatan Perchepthorship yang dilakukan oleh Kemenkes melalui Badan Diklat DPW PPNI Provinsi Jawa timur. Penulis juga aktif di DPW PPNI Provinsi Jawa Timursaat ini sebagai Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan periode 2022-2026, sekaligus sebagai wakil Ketua Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI). Sebagai Ketua Dewas di RSKM Jombang, selain itu juga aktif di Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai sekretaris untuk wilayah Mojokerto-Jombang. *Email:* sestu.retno@yahoo.com



Bdn. Israini Suriati, S.ST.,M.Keb.,CBMHCT

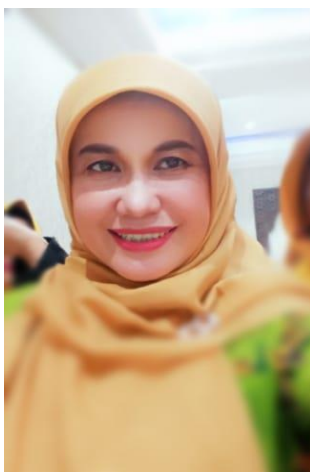
Lahir di Cilellang, 20 Februari 1990. Merupakan dosen Prodi Profesi Bidan difakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palopo. Penulis saat ini tinggal di Lorong Toangkajang, Desa Salupareman Selatan, RT. 01 RW. 01. Kec. Kamanre, Kab. Luwu, Sul-Sel. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri 249 Turangan Datu (1996-2001), SLTP Negeri 1, Cilallang (2001 – 2004), SMA Neg.1 Belopa (2004-2007), D-3 Kebidanan AKBID Muhammadiyah Palopo (2007 – 2010), D-4 Bidan Pendidik STIKES Mega Buana , Palopo (2010 – 2011). Pada tahun 2012 penulis menjadi Laboran AKBID Muhammadiyah Palopo hingga tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan Studi Magister Ilmu Kebidanan di Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus pada tahun 2018. Pernah menjabat Sekretaris UPM AKBID Muh.Palopo pada tahun 2017-2019. Penulis menjabat sebagai sekretaris LPM UM Palopo pada tahun 2019 hingga sekarang. Pengalaman Organisasi penulis, sejak 2011- sekarang telah terdaftar sebagai anggota IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Cab. Kota Palopo. Tahun 2010 hingga 2014 penulis masuk di divisi kesehatan PD. Nasiyatul Aisyiyah, kemudian di tahun 2014-2018 sebagai Anggota Majelis Kesehatan PD. Aisyiyah Kota Palopo Penulis sering mengikuti pelatihan-pelatihan yaitu Pelatihan Perseptor / Mentor Clinical Instruktur (CI), Palopo, Workshop Nasional Peningkatan Mutu Dosen Dalam Penyusunan Proposal Penelitian Program Riset Terapan di Makassar. Pada pertengahan Tahun 2021 kemarin penulis telah mengikuti Baby and Mom Spa, yang diselenggarakan di Kota Makassar. Selain menjadi dosen penulis juga terdaftar sebagai dosen bidan yang magang serta selalu meng-update ilmunya di Klinik Bersalin Nashirah yang terletak di Kota Palopo. Sekarang penulis juga menjabat sebagai ketua prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palopo, serta juga sibuk menjadi Dosen Pendamping Lapangan (DPL) Kampus Mengajar yang merupakan bagian dari program MBKM. Selain itu aktif dalam kegiatan penelitian BIMA.



Rina Utami, M.Tr.Keb.

Lahir di Pekalongan, 22 Agustus 1992. Lulus D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan tahun 2013. Selepas lulus Bidan, dihabiskan untuk melayani masyarakat sebagai Bidan. Kemudian melanjutkan Sarjana Terapan Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada Semarang lulus pada tahun 2016 dan lulus Program Magister Sains Terapan Kebidanan (M.Tr.Keb.) Poltekkes Kemenkes Semarang pada tahun 2019. Tergabung juga dalam anggota organisasi IBI kemudian saat ini mengabdikan diri di Institut Kesehatan dan Teknologi Mahardika Cirebon Jawa Barat.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pembicara, dll. Motto: "Vivere militare est". Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rinautami46@gmail.com



Dr. Ns. Sri Wahyuni, M.Kep., Sp.Kep.Mat. Lahir di Kendal, Jawa Tengah , 09 Juni 1975. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Diponegoro tahun 2003, melanjutkan pendidikan profesi Ners di Universitas Diponegoro tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Indonesia lulus tahun 2011 dan melanjutkan program ners spesialis maternitas lulus tahun 2012. Pendidikan Doktor ditempuh di Universitas Airlangga tahun 2024 dalam waktu 2 tahun 10 bulan. Riwayat pekerjaan

diawali pada tahun 1998 di Akper Islam Sultan Agung Semarang yang selanjutnya pada tahun 2007 berkembang menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan dibawah Universitas Islam Sultan Agung Semarang . Pada tahun 2007 awal berdirinya program studi penulis diamanahi sebagai Ketua Program Studi S1 Keperawatan yang pertama. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Ilmu Keperawatan. Penulis mengampu mata kuliah pada program study Diploma III, S1 Ilmu Keperawatan dan Magister Keperawatan dengan Mata kuliah Keperawatan Maternitas, Kesehatan Reproduksi, Konsep Keperawatan Maternitas, Kesehatan Perempuan, Pengkajian Keperawatan Maternitas, Manajemen Asuhan Keperawatan Maternitas, Metodologi Penelitian, Riset Kuantitatif dan Inovasi in Caring. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam penelitian, pengabdian masyarakat, seminar dan publikasi ilmiah. Penulis juga aktif pada organisasi dibidang keperawatan, himpunan, asosiasi

dan organisasi kemasyarakatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:
wahyuni@unissula.ac.id

Motto: "Tidak ada sesuatu yang luar biasa dengan usaha yang biasa"

Sinopsis

Buku referensi **Edukasi Kesehatan Reproduksi pada Ibu Hamil** ini disusun untuk memberikan wawasan mendalam kepada ibu hamil, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi selama masa kehamilan. Kesehatan reproduksi merupakan isu krusial yang tidak hanya mencakup aspek fisik semata, tetapi juga aspek mental dan sosial, yang berpengaruh besar terhadap kualitas hidup ibu dan janin. Pengetahuan yang baik tentang kesehatan reproduksi dapat menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, dan menciptakan generasi yang lebih sehat di masa depan.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan pemaparan pentingnya perencanaan kehamilan yang sehat, mencakup kesiapan fisik, psikologis, dan finansial, yang merupakan langkah awal menuju kehamilan yang aman dan berkualitas. Selain itu, buku ini memberikan edukasi mendalam tentang tanda-tanda bahaya selama kehamilan, yang bertujuan agar ibu hamil dan keluarga mampu mengenali risiko dan segera mencari pertolongan medis untuk menghindari komplikasi serius.

Topik penting lainnya adalah nutrisi selama kehamilan, yang merupakan faktor penentu dalam menjaga kesehatan reproduksi. Buku ini menjelaskan secara rinci peran nutrisi, mulai dari makronutrien hingga mikronutrien, dalam mendukung tumbuh kembang janin serta menjaga keseimbangan hormonal ibu hamil. Tidak hanya itu, pembaca juga diberikan panduan praktis untuk menyusun pola makan seimbang serta pentingnya pemantauan status gizi selama kehamilan.

Buku ini juga menyoroti peran strategis komunitas dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan reproduksi ibu hamil. Pendekatan edukasi berbasis komunitas yang dikupas dalam buku ini mencakup pelatihan dan penyuluhan melalui media massa dan teknologi digital, serta strategi kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang mendukung dan memberdayakan ibu hamil untuk menjalani masa kehamilan yang aman dan sehat.

Melalui pembahasan yang komprehensif, buku ini diharapkan mampu menjadi acuan penting bagi ibu hamil, tenaga kesehatan, dan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan reproduksi di Indonesia.

Buku referensi Edukasi Kesehatan Reproduksi pada Ibu Hamil ini disusun untuk memberikan wawasan mendalam kepada ibu hamil, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi selama masa kehamilan. Kesehatan reproduksi merupakan isu krusial yang tidak hanya mencakup aspek fisik semata, tetapi juga aspek mental dan sosial, yang berpengaruh besar terhadap kualitas hidup ibu dan janin. Pengetahuan yang baik tentang kesehatan reproduksi dapat menurunkan angka kematian ibu, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, dan menciptakan generasi yang lebih sehat di masa depan.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan pemaparan pentingnya perencanaan kehamilan yang sehat, mencakup kesiapan fisik, psikologis, dan finansial, yang merupakan langkah awal menuju kehamilan yang aman dan berkualitas. Selain itu, buku ini memberikan edukasi mendalam tentang tanda-tanda bahaya selama kehamilan, yang bertujuan agar ibu hamil dan keluarga mampu mengenali risiko dan segera mencari pertolongan medis untuk menghindari komplikasi serius.

Topik penting lainnya adalah nutrisi selama kehamilan, yang merupakan faktor penentu dalam menjaga kesehatan reproduksi. Buku ini menjelaskan secara rinci peran nutrisi, mulai dari makronutrien hingga mikronutrien, dalam mendukung tumbuh kembang janin serta menjaga keseimbangan hormonal ibu hamil. Tidak hanya itu, pembaca juga diberikan panduan praktis untuk menyusun pola makan seimbang serta pentingnya pemantauan status gizi selama kehamilan.

Buku ini juga menyoroti peran strategis komunitas dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan reproduksi ibu hamil. Pendekatan edukasi berbasis komunitas yang dikupas dalam buku ini mencakup pelatihan dan penyuluhan melalui media massa dan teknologi digital, serta strategi kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang mendukung dan memberdayakan ibu hamil untuk menjalani masa kehamilan yang aman dan sehat.

Melalui pembahasan yang komprehensif, buku ini diharapkan mampu menjadi acuan penting bagi ibu hamil, tenaga kesehatan, dan berbagai pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan reproduksi di Indonesia.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

